

01. EINE NEUE VISION

DAUER : 16:19

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem fesselnden Video geht es um eine neue Vision unserer Beziehung zur Erde und wie diese unsere Praxis als Therapeuten beeinflussen sollte. Basierend auf Konzepten wie der Illusion der Wahrnehmung und der Vernetzung schlägt der Sprecher eine Erneuerung des Bewusstseins vor, die nicht nur das Leid der Patienten lindert, sondern auch zu deren spirituellem Erwachen beiträgt. Die drei wesentlichen Elemente, die integriert werden müssen, sind Mobilisierung, Kreation und spirituelle Arbeit, wobei jedes dazu dient, neue Perspektiven zu eröffnen und ein einfacheres, bewussteres Leben zu fördern. Eine Einladung, sensorische Freuden zugunsten authentischer Freude aufzugeben, geht nachhaltig von diesem Ansatz aus und verleiht der Therapie eine neue Dimension.

EINE NEUE VISION

Die Wahrnehmung, die wir von der Realität haben, kann oft eine **enorme Illusion** sein. Zum Beispiel haben Sie den Eindruck, dass ich hier vor Ihnen existiere, aber in Wirklichkeit bin ich eine **Fata Morgana**. Yona Messi hat ein Buch geschrieben, das uns einlädt, die **Erde** als eine Erweiterung unserer selbst zu betrachten, im Geiste des **Respekts** und der Liebe.

Wir sind letztendlich eine Summe von **Aggregaten**, eine **momentane, vergängliche** und **wechselseitig abhängige** Zusammensetzung. Diese Aggregate umfassen unsere Form und unsere Beziehung zur Erde, sowie das große Spiel der **Wahrnehmungen**. Unsere Wahrnehmungen, wenn wir sie genau beobachten, sind nur Fata Morganas. Sie sind oft **verschwommen**, und wir neigen dazu, Dinge zu fixieren, obwohl sie in Wirklichkeit ziemlich unsicher bleiben.

Diese Vorstellung der **Interpretation** ist entscheidend. Wie nehmen wir unsere Umgebung wahr? Das Spiel, das sich um uns herum aufbaut, ist ebenfalls eine Interpretation der Phänomene. Wir sind eine **Phänomenologie**, und es ist vielleicht an der Zeit, unsere Wahrnehmungsweise zu ändern, nach einer größeren Fata Morgana zu streben, so groß wie unser Planet. Wenn wir uns bewusst werden, dass wir mit der Erde verbunden sind, könnten wir uns besser um sie kümmern.

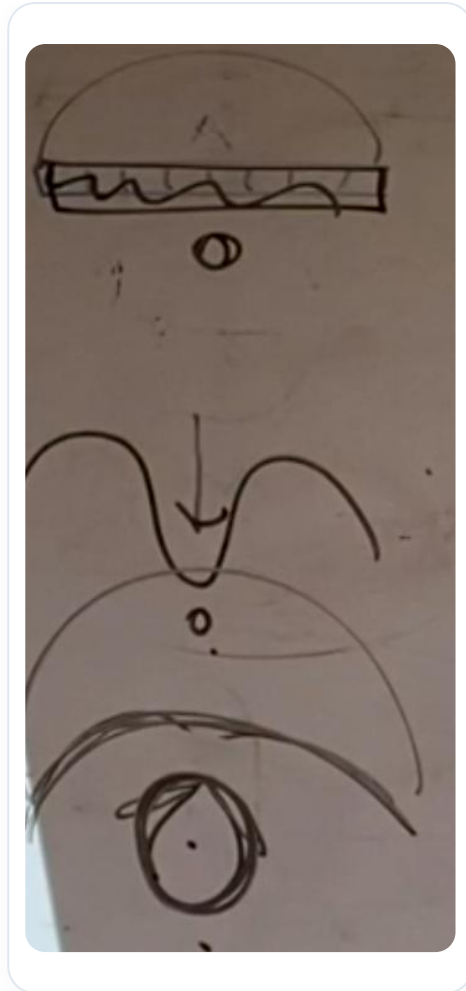


ABB. — *Das Bild, ein allgemeines Konzept, und dieser Absatz, der das Bewusstsein unserer Verbindung zur Erde behandelt, nehmen die Einführung und die Notwendigkeit einer 'neuen Vision' vorweg, die folgen wird*

Wir leben in einer Gesellschaft, die auf **Wachstum** ausgerichtet ist, oft als unendlich wahrgenommen, während unsere Welt in Wirklichkeit **endlich** ist. Es ist unerlässlich, diesen bevorstehenden Wandel anzuerkennen. Ich schlage Ihnen eine **neue Vision** vor: Entweder wir vollziehen diese Wende, oder wir steuern auf einen unvermeidlichen **Zusammenbruch** zu.

Die Emergenztheorien lehren uns, dass alles entsteht und dann zusammenbricht. Die heutige Gesellschaft befindet sich an einem Wendepunkt, und als **Therapeuten** haben wir eine Rolle zu spielen. Wir können das Leid unserer Patienten lindern und ihnen gleichzeitig helfen, sich neuen Perspektiven zu öffnen.

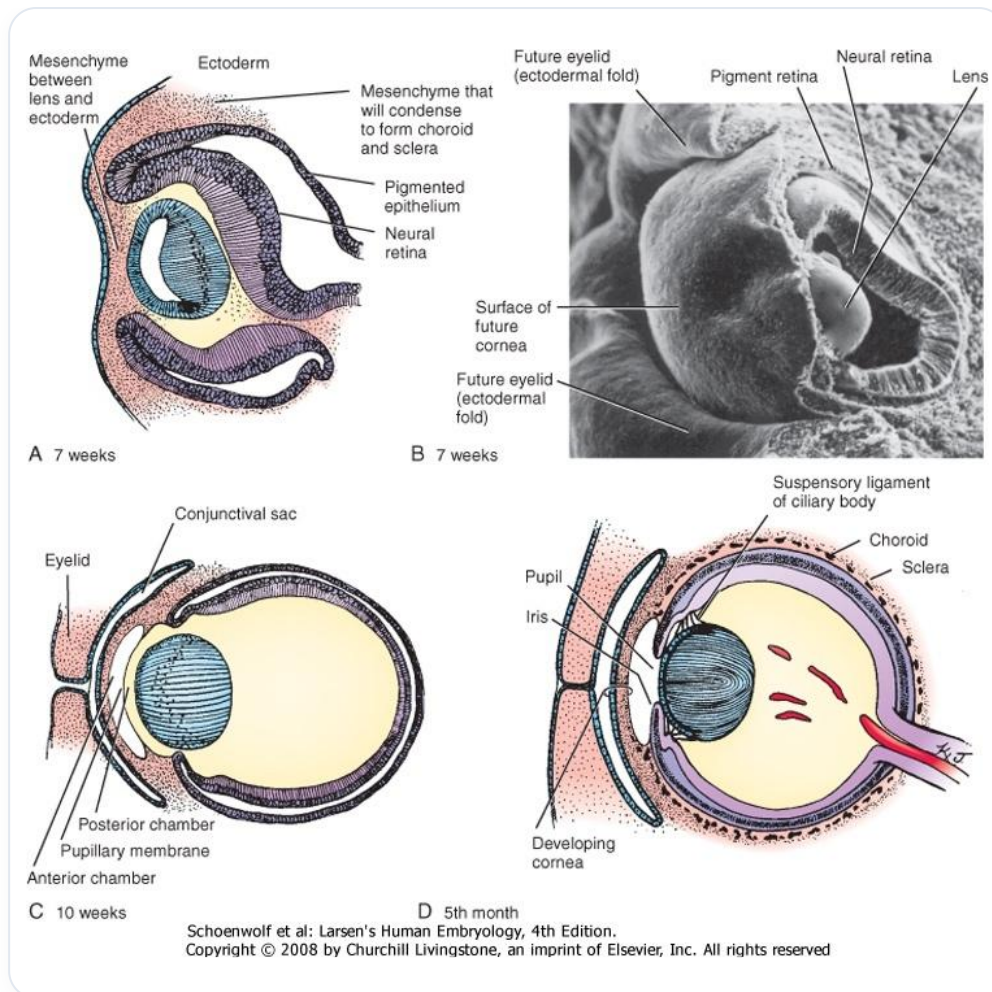


ABB. — Wahrscheinlich ein Aspekt der 'Emergenztheorien' oder ein visuelles Konzept im Zusammenhang mit dem Übergang und der Rolle von Therapeuten. Der vorhergehende Satz schließt diese allgemeine Idee ab

Andreas Messie hat drei wesentliche Elemente identifiziert, um diese Wende zu vollziehen:

1. **Mobilisierung:** Es ist entscheidend, sich zu engagieren und Nein zu sagen zu dem, was nicht funktioniert, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere.
2. **Schöpfung:** Es ist wichtig, neue Ideen und Formen zu entwickeln, was uns dazu anregt, **Schöpfer** und **Denker** zu sein.

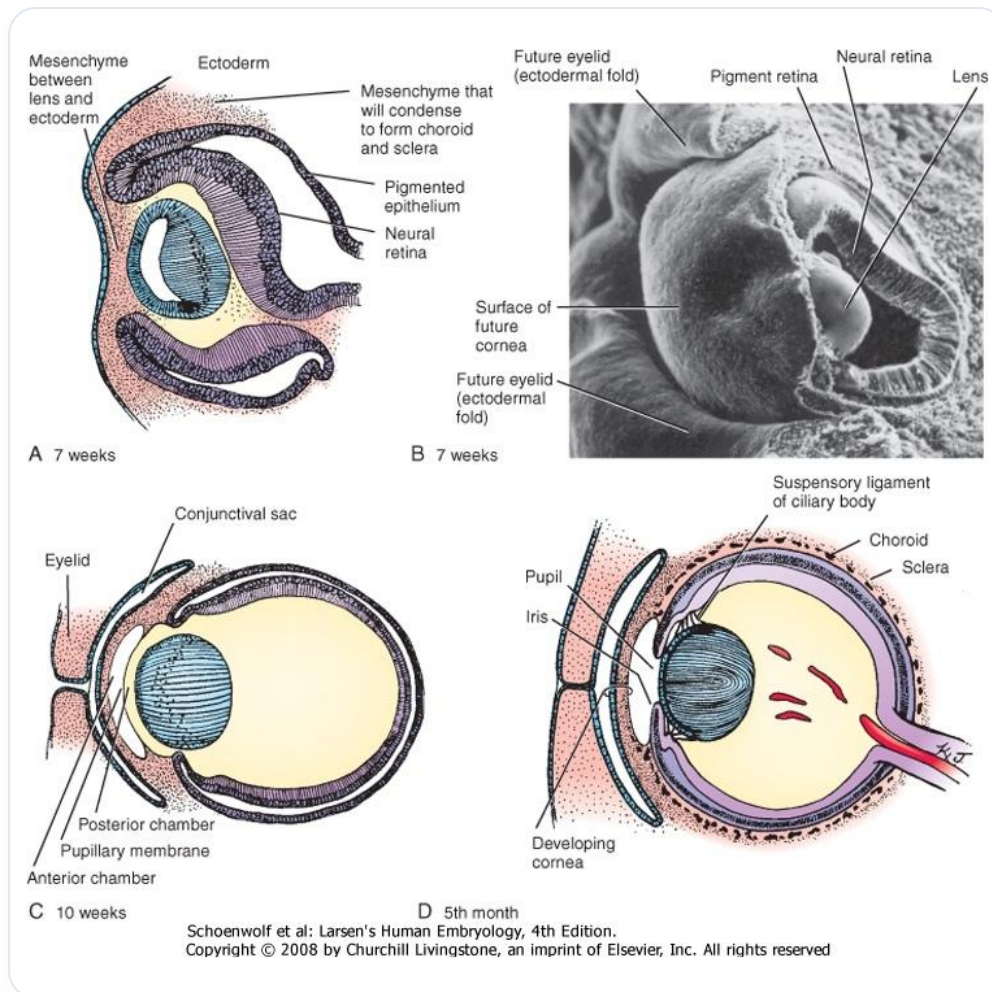


ABB. — Dieses Bild könnte die Aspekte im Zusammenhang mit 'spiritueller Arbeit' und 'Veränderung', die im vorhergehenden Absatz von Iona Messie erwähnt wurden, visuell zusammenfassen oder einführen, bevor konkretere Konzepte wie wohlwollendes Bewusstsein angesprochen werden

3. Spirituelle Arbeit: Laut Iona Messie können wir ohne diese Arbeit diesen Wandel nicht vollziehen.

Diese Arbeit besteht darin, ein wohlwollendes **Bewusstsein** und ein **gutes Herz** zu entwickeln. Wir müssen uns fragen, wie wir Leid reduzieren können, nicht nur unser eigenes, sondern auch das anderer. Zu oft sind wir vom Vergnügen unserer Sinne absorbiert.

Ich ermutige Sie, sich selbst zu beobachten und Ihr Verhalten zu überprüfen. Wir haben die Pflicht, anderen eine Form von Vergnügen zu lehren, die über die bloße sensorische Befriedigung hinausgeht. Dies kann das Vergnügen der **Einfachheit**, einer **authentischen Präsenz** oder einer Beziehung zu den Dingen anstatt ihres Besitzes umfassen.

Zufriedenheit kann aus einer gewissen **Neutralität** entstehen. Die Freude des Verzichts ist ein Konzept, das in buddhistischen Texten zu finden ist. Der Buddha selbst drückte aus, dass er, obwohl er zunächst Wut bei dem Gedanken an Verzicht empfand, schließlich eine immense Freude in dieser **Loslösung** fand.

Ich lade Sie ein, darüber nachzudenken, was Sie aufgeben könnten, um das Leid in Ihrem Leben und dem anderer zu reduzieren. Als Therapeuten haben wir die Verantwortung, dieses Bewusstsein zu öffnen und uns einer Form der **Einfachheit** zuzuwenden. Das kann sogar bedeuten, Freude daran zu finden, auf einige unserer **Privilegien** zu verzichten.

02. EINFÜHRUNG IN DAS AUGEN

DAUER : 06:56

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet einen faszinierenden Einblick in die Anatomie und Physiologie des Auges und enthüllt seine entscheidende Rolle nicht nur für das Sehen, sondern auch für das Gleichgewicht und die emotionale Wahrnehmung. Zu den Schlüsselkonzepten gehören die enge Beziehung zwischen Auge und Herz, die Auswirkungen von Augenverspannungen auf die Leber und die Notwendigkeit eines multidisziplinären Ansatzes, der Embryologie, Anatomie und spirituelle Dimensionen kombiniert. Indem Therapeuten lernen, das Auge in einem globalen Kontext zu behandeln, können sie die Auswirkungen von Emotionen auf die Wahrnehmung besser verstehen und dadurch ihre Praxis verbessern, indem sie die Verbindungen zwischen der physischen Struktur und den Umweltinformationen, die unsere Sicht beeinflussen, berücksichtigen.

EINFÜHRUNG IN DAS AUGEN

Das **Auge** ist eine faszinierende Struktur, die eine entscheidende Rolle bei unserer Wahrnehmung der Welt spielt. Ein Teil unseres **Gehirns**, die Netzhaut, ist in der Lage, das kleinste Lichtteilchen, das **Photon**, zu erkennen. Das Auge ist in Wirklichkeit eine **Erweiterung** unseres Gehirns, mit einer hohen Gehirnaktivität.

Die Bedeutung des Auges beschränkt sich nicht nur auf das Sehen. Es beeinflusst direkt unseren **Schwerpunkt**, und dieser wiederum beeinflusst das Auge. In diesem Sinne fungiert das Auge als ein **Leuchtturm** für alle **Faszien** des Körpers. Augenverspannungen, die wir in der Konsultation beobachten, stehen oft in Verbindung mit der **Leber**. Zum Beispiel kann ein rotes oder gelbes Auge ein Ausdruck von Leberproblemen sein.

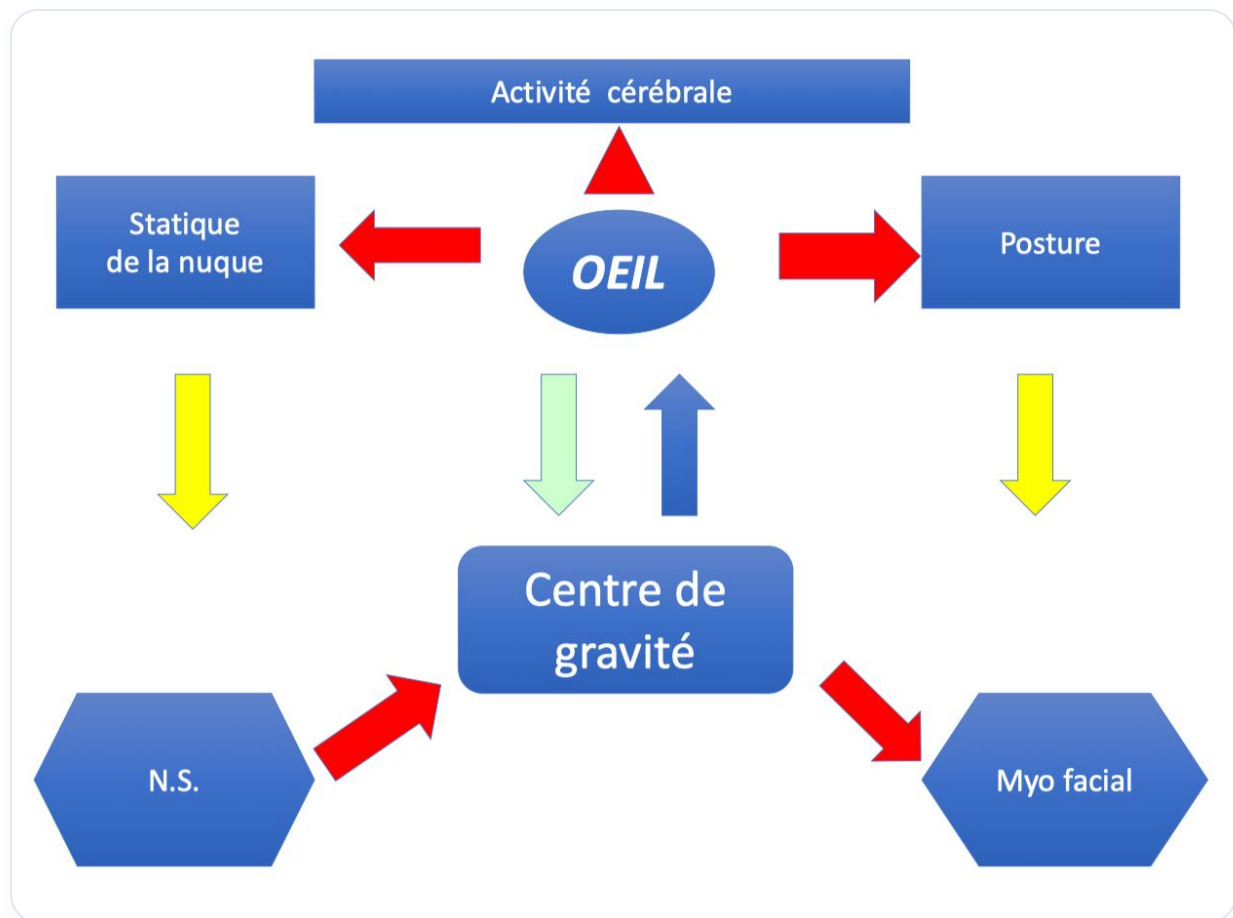


ABB. — Konzept des Auges als 'Leuchtturm der Faszien' und dessen Einfluss auf den Schwerpunkt, wie im Text beschrieben

Es ist auch interessant festzustellen, dass sich das Auge bereits in der Embryologie in Beziehung zum **Herzen** entwickelt. Es empfängt rhythmische Informationen, genau wie der Hals und die Hände. Diese verschiedenen Teile unseres Körpers übertragen **elektrische** und **elektromagnetische Ladungen**. Zum Beispiel können wir jemanden durch unsere Stimme oder durch den Blick beeinflussen.

Das Auge empfängt Informationen nicht nur vom Herzen, sondern auch aus unserer Umgebung. Die **Gehirnfrequenzen**, insbesondere die Alpha-Frequenzen, spielen eine Rolle bei der Stabilisierung unserer Wahrnehmung. Buddhisten sprechen von einem **unsichtbaren Faden**, der Herz und Augen verbindet, und betonen die Bedeutung dieser Verbindung.

Es ist wesentlich zu lernen, **mit dem Herzen zu sehen**. Dieser Ansatz kann unsere Wahrnehmung verändern und subtile Veränderungen in unserer Sichtweise bewirken. Ein einfaches Wort, eine Geste oder ein Blick kann eine tiefe Wirkung auf eine Person haben, sei es, um sie zu blockieren oder um sie zu befreien.

Die **Aufmerksamkeit** ist ein entscheidendes Werkzeug, das geschärft werden muss, um das Sehen zu trainieren. Emotionen wie Angst oder Wut können unsere Wahrnehmung der Realität verändern. Zum Beispiel kann Wut eine vorübergehende Klarheit bieten, aber sie kann auch unsere Sicht verzerren.

Die Arbeit am Auge erfordert einen multidisziplinären Ansatz, der die **Embryologie**, die **Anatomie** und eine eher **spirituelle** Dimension umfasst. Wir werden die verschiedenen **Skandhas** erforschen, die wesentlich sind, um die Welt der Wahrnehmung, der Empfindung und des Bewusstseins zu verstehen. Es ist wichtig, zwischen Illusion und Realität zu unterscheiden, da unsere Vorurteile unsere Sichtweise beeinflussen können.

Das Auge ist ein **Konformator**, der dem Einfluss seiner Umgebung unterliegt. Es ist bereits vor der Knochenbildung vorhanden und gehorcht Gesetzen der Position, der Mobilität und der Informationsintegration. Wir müssen auch die **neurosensorische** Ebene des Auges und seine **neuromotorische** Beteiligung verstehen.

Wenn Licht auf das Auge trifft, erfährt es eine **Transduktion**, die Licht in Elektrizität umwandelt. Diese Information wird dann an das **Gehirn** weitergeleitet, insbesondere an den Corpus geniculatum laterale, was unsere Wahrnehmung beeinflusst. Es ist wichtig zu beachten, dass wir etwa **80%** der Realität in unserer Art zu sehen verlieren, da unsere Wahrnehmung stark von unseren Erfahrungen und Emotionen beeinflusst wird.

Als Osteopath ist es entscheidend, diese Umwelt- und Gesichts-Informationen zu empfangen. Die Behandlung des Auges bedeutet, den gesamten Körper zu behandeln, da das Auge als **Balance** zwischen der Körperstruktur und den Problemen, die sich äußern können, fungiert.

03. URSPRUNG DES AUGES

DAUER : 07:12

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit dem Ursprung des Auges, das sich ab dem achten Tag der Embryonalentwicklung aus dem Dienzephalon entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der Amnionhöhle und des Liquor cerebrospinalis (LCS) sowie darauf, wie diese Elemente die Bildung des Auges und sein dynamisches Gleichgewicht mit der Umgebung beeinflussen. Die Beziehung zwischen der Amnionhöhle, dem Ventrikelsystem und dem Auge wird hervorgehoben, wobei auch die klinischen und genetischen Implikationen betont werden, die die Gesundheit des Individuums beeinträchtigen und sich durch das Auge manifestieren können. Dieses Verständnis kann Therapeuten helfen, das Gleichgewicht bei ihren Patienten zu beurteilen und wiederherzustellen, was die Lehre für diejenigen, die Osteopathie und biodynamische Embryologie praktizieren, unerlässlich macht.

URSPRUNG DES AUGES

Das Auge weist eine faszinierende **Ähnlichkeit** mit seiner Entstehung am achten Tag der Embryonalentwicklung auf, dem Zeitpunkt, an dem eine kleine Höhle, die sogenannte **Amnionhöhle**, entsteht. Diese Höhle ist grundlegend für die Entwicklung des Auges, das aus dem **Gehirn**, genauer gesagt aus dem **Diencephalon**, einer Ausdehnung des dritten Ventrikels, stammt.

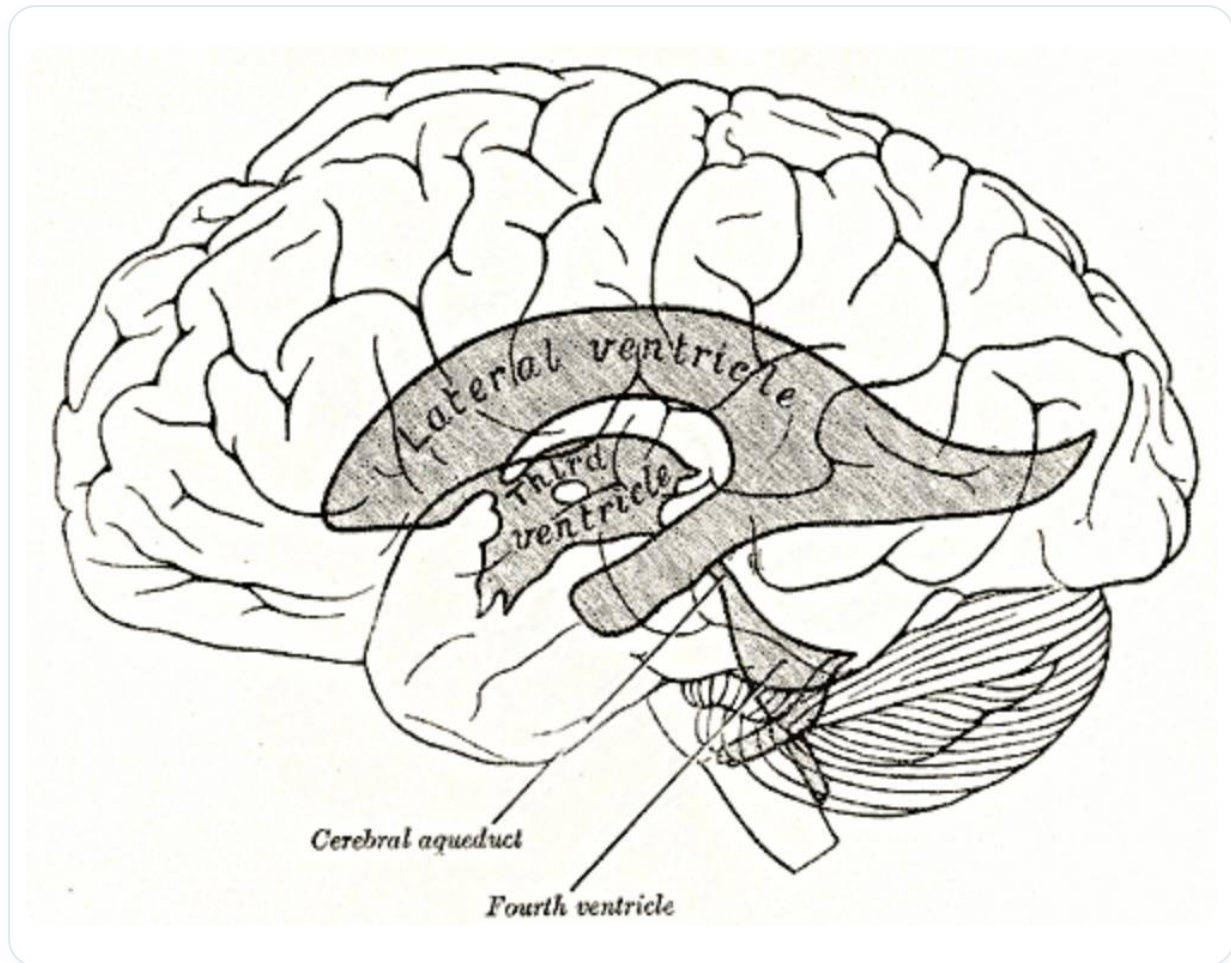


ABB. — Schema zur Entstehung des Auges aus dem Diencephalon, in Verbindung mit dem dritten Ventrikel

Während dieser Entwicklung empfängt das neuronale System **primitives Fruchtwasser**, das die **Zerebrospinalflüssigkeit (CSF)** bilden wird. Diese erste CSF, die aus dem Fruchtwasser stammt, wird im Neuralrohr eingeschlossen. Anschließend öffnet sich dieses Rohr nach vorne und bildet **primitive Vesikel**.

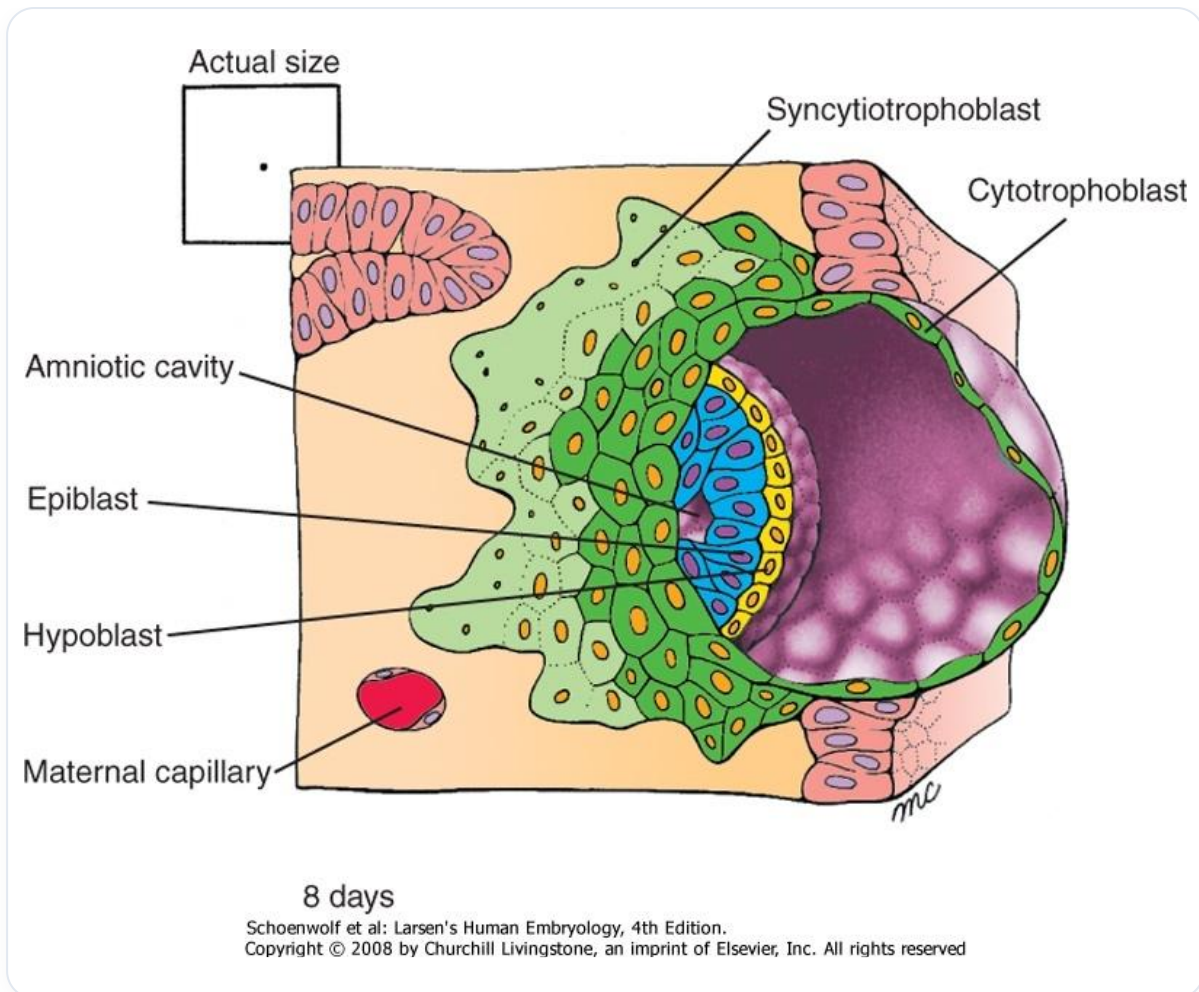


ABB. — Schema zum Auftreten der Amnionhöhle, die direkt nach diesem Satz in der Zusammenfassung erwähnt wird

Der Überrest dieser Amnionhöhle findet sich in der sogenannten **Knochentasche** oder **Zone B** wieder, wo sich Zerebrospinalflüssigkeit befindet. Es ist interessant festzustellen, dass die Flüssigkeit innerhalb und außerhalb des Embryos dieselbe ist. Das Auge, als Membran, versucht ständig, diese Zone B auszugleichen.

Die Zone A wird durch die zentrale Achse des physischen Körpers dargestellt, während die Amnionhöhle am achten Tag zu entstehen beginnt und den Eintritt in die **Schleimhaut** markiert. In diesem Stadium erzeugt ein zentraler Flüssigkeitsverlust eine kleine Höhle, und das **Ektoderm**, zu diesem Zeitpunkt **Epiblast** genannt, beginnt sich zu bilden. Dies stellt bereits die subtile Struktur dar, die das Auge und das Gehirn bilden wird.

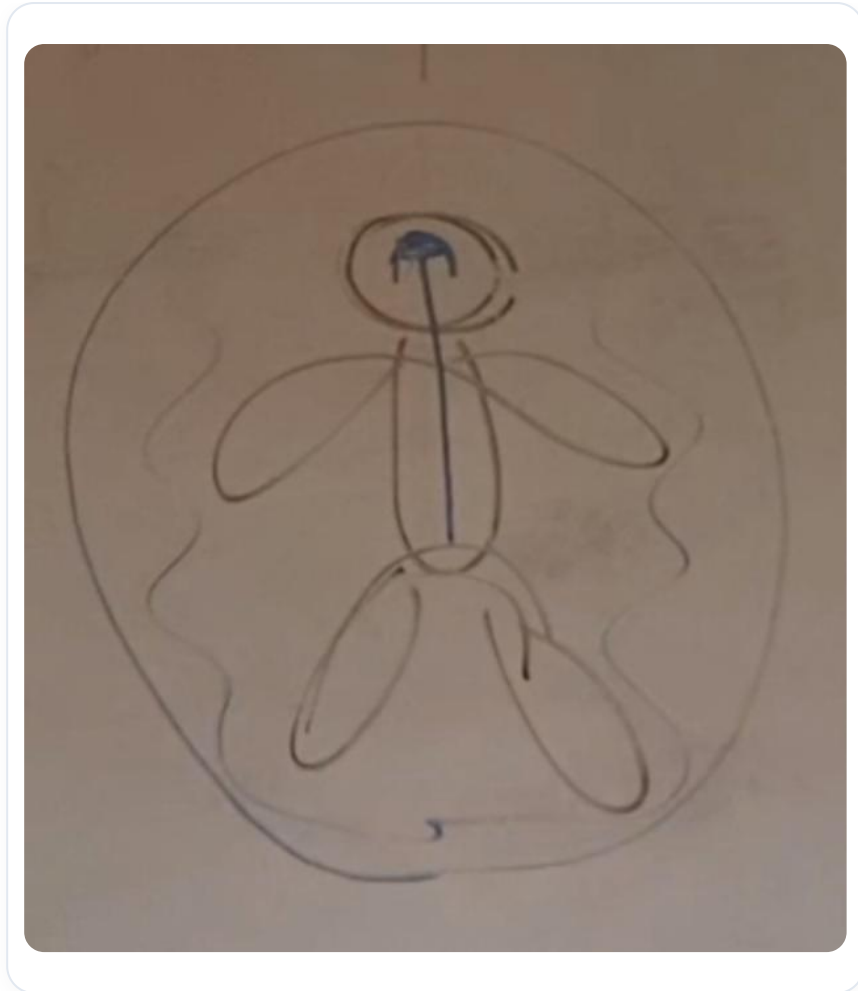


ABB. — *Vestige de la cavité amniotique (zone B)*

Die Amnionhöhle, die den Embryo neun Monate lang umgibt, wird dann zu einem dampfförmigen Raum. Dieser Raum muss im Gleichgewicht mit der inneren Flüssigkeit sein. Ungleichgewichte können auftreten, insbesondere bei Unfällen, die die Position des Auges beeinflussen. Das Auge stellt somit ein Gleichgewicht zwischen der Flüssigkeitstiefe des Nervensystems (CSF) und dem umgebenden Raum dar.

Die Beobachtung der Augenposition kann Aufschluss über das Gleichgewicht einer Person geben. Jedes Individuum hat ein leicht unterschiedliches Auge, oft im Zusammenhang mit der Architektur seines Gehirns. Die Suche nach einer **Horizontalität** im Verhältnis zu einer **Vertikalität** ist ebenso wesentlich wie das Gleichgewicht zwischen dem Verdauungssystem und dem Peritonealsystem.

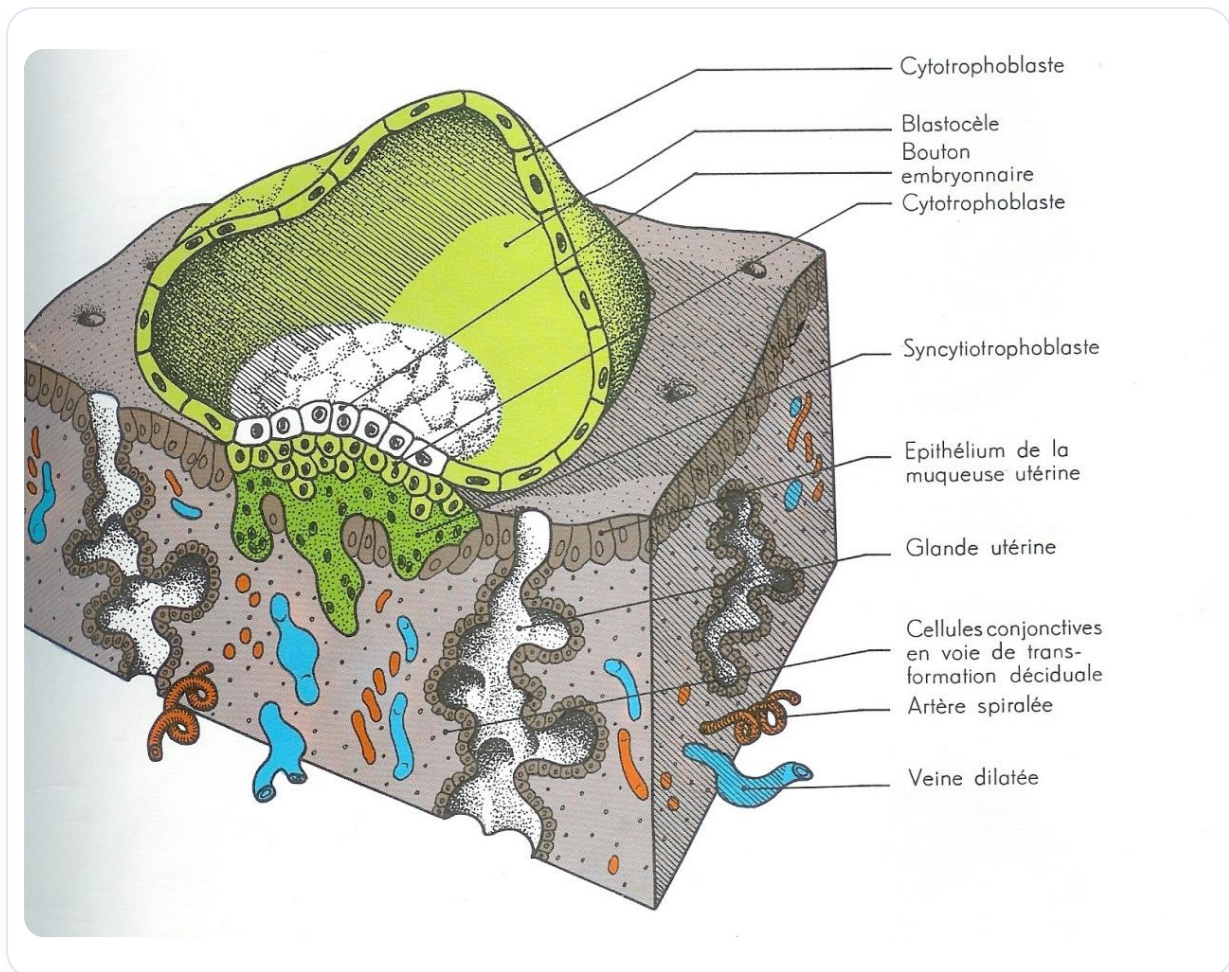


ABB. — Implantationsprozess: Höhlenbildung

Es ist entscheidend, die Augen nach einer Behandlung zu beobachten. Wenn die Augenposition nicht stabil ist, deutet dies darauf hin, dass das Gleichgewicht noch nicht wiederhergestellt ist. Die Amnionhöhle, obwohl nicht mehr in flüssiger Form, bleibt in anderen Zuständen, wie z.B. dampfförmig, erhalten.

Diese Beziehung zwischen der Amnionhöhle, dem Auge und dem Ventrikelsystem ist grundlegend. Das Auge, als Ausdehnung des dritten Ventrikels, beginnt sich vor dem Verschluss des **vorderen Neuroporus** zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es interessante genetische Implikationen mit Co-Lokalisationen von Informationen in Aufprallzonen, wie dem hepatopankreatischen, kardialen und Schilddrüsensystem.

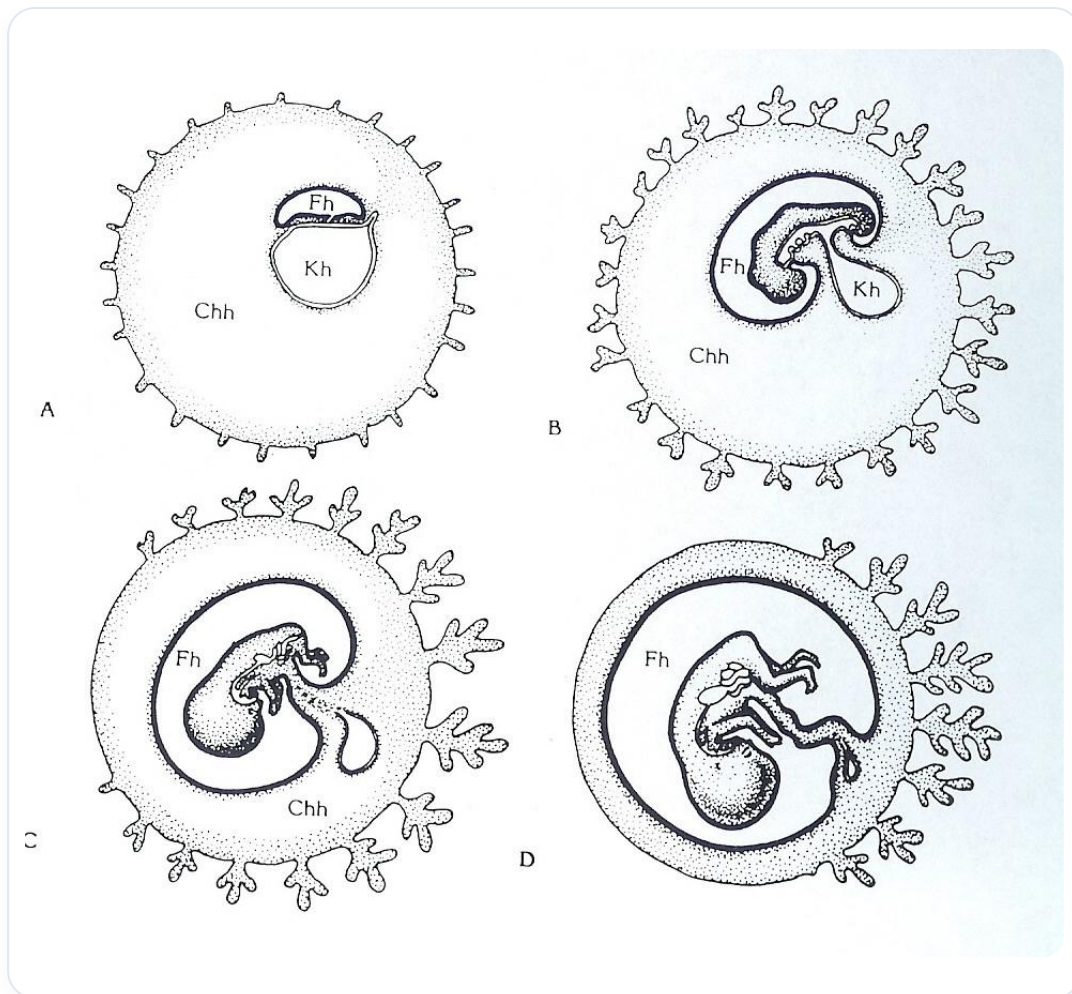


ABB. — Amnionhöhle

Pathologien wie **Diabetes**, Herz- und Schilddrüsenprobleme können sich durch das Auge manifestieren und so die Bedeutung der **Neuralleiste** für die Organisation der Mittelachse und der Lateralität aufzeigen.

04. ANLAGE DES AUGES

DAUER : 08:39

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video erforscht die Entwicklung des Auges im Rahmen der biodynamischen Embryologie und Osteopathie. Sie werden lernen, wie die Interaktion zwischen Endoderm und Mesoderm, sowie die primäre Rolle der Chorda dorsalis und des Neuralrohrs, an der Bildung essentieller Strukturen wie dem Auge beteiligt sind. Permeations- und Infusionsbewegungen, sowie der Begriff der Polarität, sind Schlüsselkonzepte, die der embryonalen Entwicklung zugrunde liegen. Darüber hinaus wird behandelt, wie Ausgleichstechniken, als Reaktion auf emotionale oder physische Schleudertraumata, die für die optimale Entwicklung des Auges notwendigen Bewegungen wiederherstellen können, und diese somit mit Ereignissen wie dem ersten Herzschlag verbinden.

ENTWICKLUNG DES AUGES

Das **Entoderm** ist ein Epithel, während das **Mesoderm** ein Bindegewebe ist. Es ist entscheidend, das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Hauptgewebetypen zu verstehen: einem inneren Gewebe und einem äußeren Gewebe. Zum Beispiel fungiert das Verdauungsepithel, obwohl es innen liegt, als Grenzgewebe.

Der Vorläufer der **Neuralrinne** und der **Neuralplatte** ist die **Notochord**. Dieser Prozess der Ausstülpung in einer Längsachse steht in Beziehung zur **Primitivrinne**, die die primitive Achse des Körpers bildet. Diese Achse ist entscheidend, da sie die Zellen nach ihrem Raum, ihrer Zeit und ihrem Schicksal organisiert.

Am 18. Tag entwickelt sich die Neuralplatte, und die dritte Höhle, die des **externen Zöloms**, erscheint. Diese Polaritätsänderung und die Reorganisation der Achse erzeugen die Primitivrinne durch ein Aspirationsfeld der kaudalen Zone, das die Information „ansaugt“. Dieses Phänomen wird von Bewegungen begleitet, die als **Permeation** und **Infusion** bezeichnet werden.

Die Permeationsbewegung, eine große metabolische Bewegung, findet um den Embryo herum statt und lässt die **Amnionhöhle** voranschreiten. Man unterscheidet so die Amnionhöhle, die Dottersackhöhle und ein Gewebe namens **Epiblast**, das das zukünftige Nervensystem bilden wird, während das darunterliegende Gewebe das zukünftige Verdauungssystem bildet.

Diese Bewegung bewirkt eine Formänderung der Notochord, die eine S-Form annimmt. Dieses differentielle Wachstum ist mit der Polarität verbunden. Die primitive Achse organisiert das Epithelgewebe, das durch Induktions- und Inhibitionsphänomene in Beziehung zur Notochord reagiert.

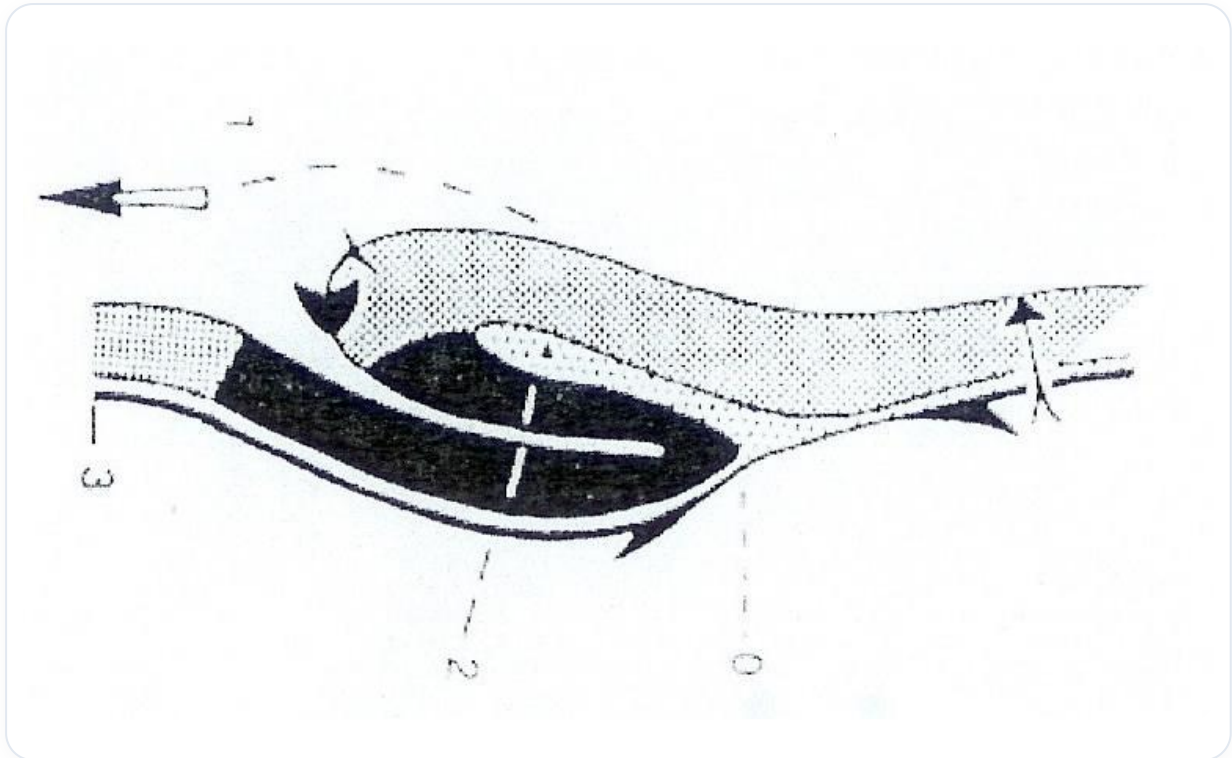
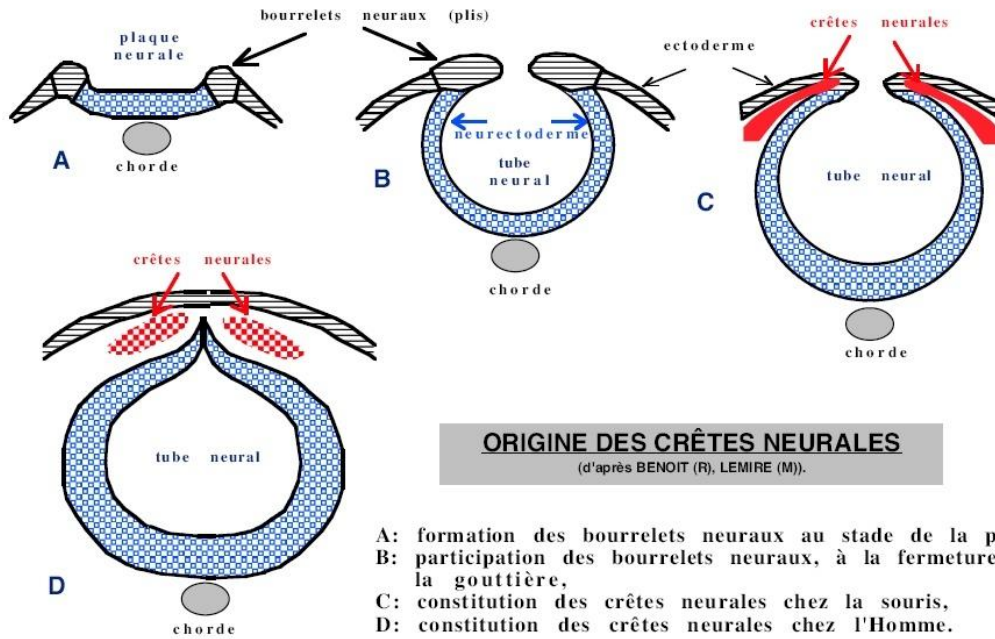


ABB. — Differenzielles Wachstum

Die Neuralplatte entwickelt sich zu einer **Neuralrinne**, die Liquor cerebrospinalis oder vielmehr primitive Amnionflüssigkeit umschließt. Der Verschluss dieser Rinne bildet ein **Neuralrohr**. Die **Neuralleisten**, die als viertes embryonales Gewebe gelten, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Auges.

La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural



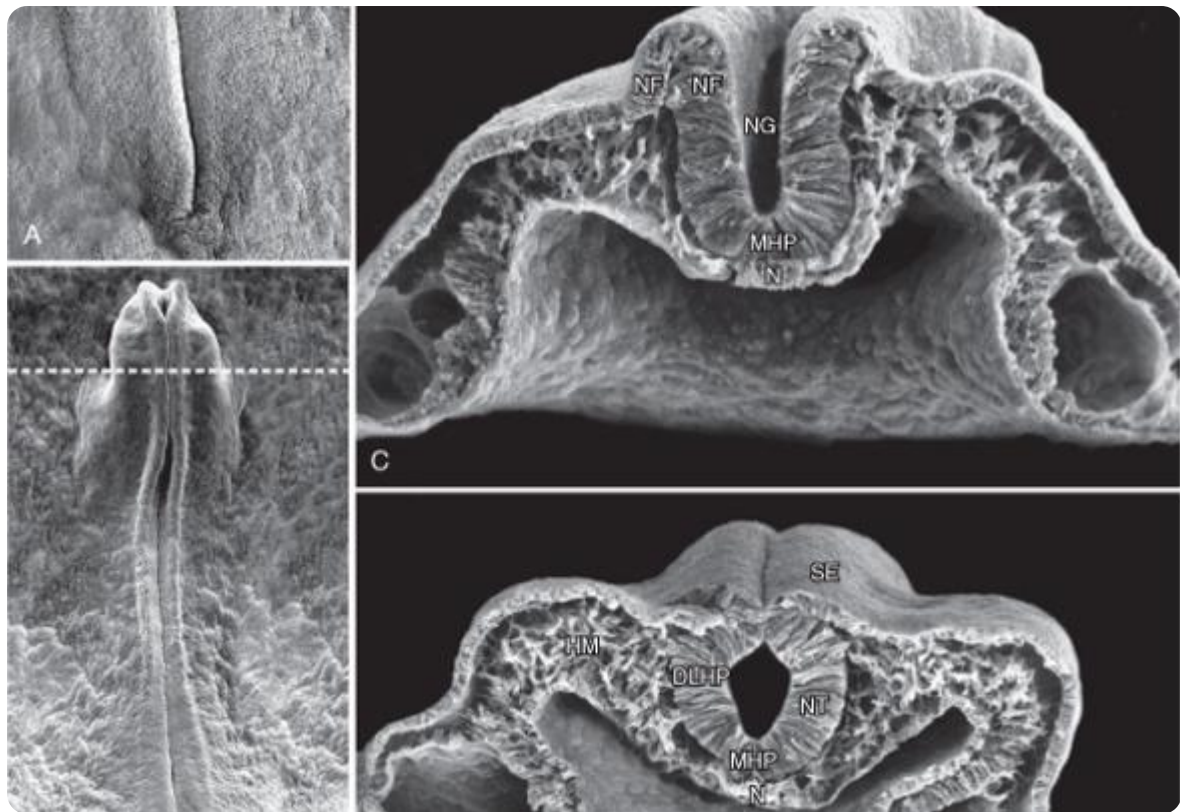
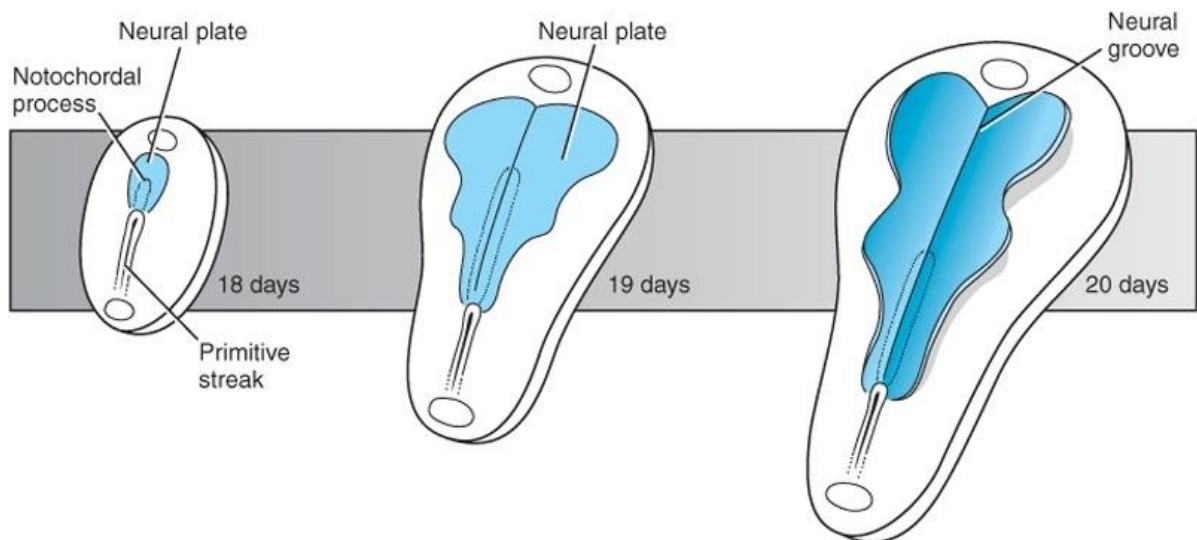


ABB. — Bildung der Neuralrinne



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Transformation der Neuralplatte in die Neuralrinne

Die Notochord ist wesentlich für die Entwicklung des Auges. Ohne eine ausgeglichene Notochord ist ein stabiles Auge unmöglich. Ebenso ist ein freies Sakrum notwendig, um die Stabilität des Gehirns zu gewährleisten. Es ist daher grundlegend, das Sakrum neu auszurichten, um eine gute Vertikalität zu sichern.

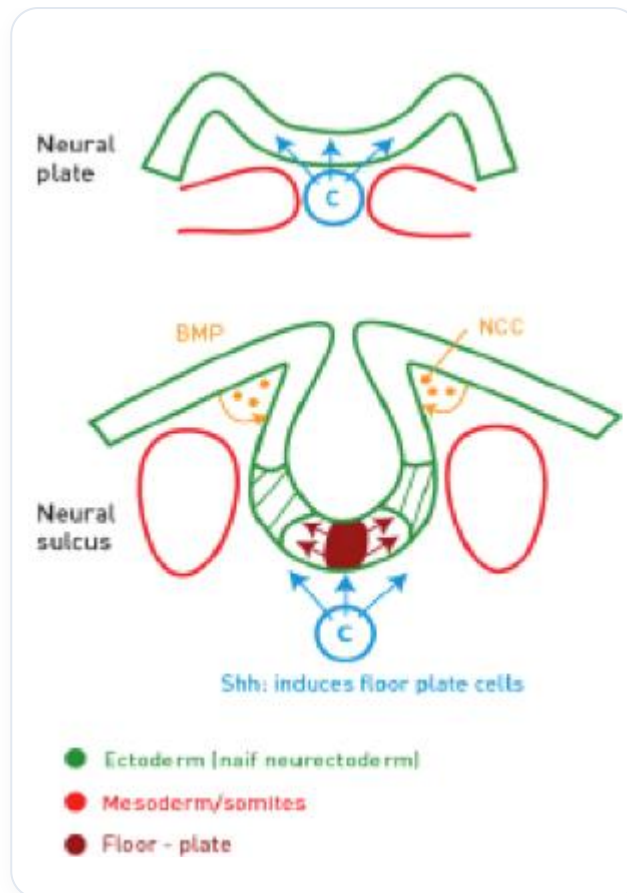


ABB. — Verschluss zur Bildung des Neuralrohrs und der Neuralleisten

Der Embryo weist die Amnionhöhle, die Dottersackhöhle und die zweiblättrige Keimscheibe auf, die sich um die Notochordachse und das Neuralrohr organisieren. Die Bildung dieses Neuralrohrs beinhaltet den Verschluss der Amnionhöhle und der Dottersackhöhle.

Während sich die Längsachse des Embryos entwickelt, bildet sich die Gehirnanlage und schließt sich in der Mitte des Embryos, wobei ein Rest oben verbleibt. In diesem Raum entwickelt sich die **Linsenplakode**, die das Auge bilden wird.

Vor dem Verschluss des Neuralrohrs findet ein Induktionsphänomen statt, um die Notochord zu bilden, die die Grundlage der kortikalen Entwicklung ist. Aus dieser Entwicklung wird das Auge hervorgehen, das eine Expansion eines ventrikulären Systems ist, das mit Liquor cerebrospinalis gefüllt ist. Das Auge kann als flüssige Kugel, ein subtiler Filter für Photonen und ein Ausgleich des umgebenden Raumes betrachtet werden.

Es ist möglich, das Auge neu auszurichten, indem man an einem spezifischen Bereich arbeitet, der oft von **Schleudertraumata** betroffen ist. Diese Schleudertraumata können emotionalen oder physischen Ursprungs sein. Die Behandlung eines Schleudertraumas beinhaltet die Wiederherstellung der Bewegungen der **Zephalisierung, Kardialisierung, Diaphragmatisierung** und **Hepatisation**, die für die embryonale Entwicklung wesentlich sind.

Die Entstehung des Auges beginnt mit dem ersten Herzschlag, um den 22. Tag herum. Die erste epiblastische Zelltransformation erfolgt synchron mit diesen primitiven Herzschlägen und stellt eine signifikante Korrespondenz zwischen der Entwicklung des Auges und der Herzaktivität her.

05. EINFLUSS DER CHORDA DORSALIS

DAUER : 03:50

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video erforscht die essentielle Rolle der Chorda dorsalis in der Embryonalentwicklung, insbesondere ihren Einfluss auf das Neuralrohr durch sonetische S-hatch-Systeme, entscheidende Elemente wie 40A und 40T. Die Studenten werden lernen, wie die Chorda dorsalis elektromagnetische Signale aussendet, die als GPS für die Organbildung wirken, unter Verwendung von Nährstoffen wie Beta-Carotin und Retinsäure. Durch die Beobachtung der Zelldynamik und der Lateralisierung beleuchtet dieses Video die Bedeutung, die Chorda dorsalis nicht nur als Struktur, sondern als essentielle Funktion für die embryonale Organisation zu betrachten, die eine Schlüsselrolle bei der Bildung des Gehirns und der Augen spielt.

EINFLUSS DER CHORDA DORSALIS AUF DIE EMBRYONALENTWICKLUNG

Die **Chorda dorsalis** spielt eine entscheidende Rolle in der Embryonalentwicklung und beeinflusst insbesondere das **Neuralrohr**. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Chorda dorsalis Signale aussendet, die als **sonetische S-Hatch-Systeme** bezeichnet werden und Elemente wie **40A** und **40T** umfassen. Diese Induktionsphänomene sind bedeutsam, insbesondere im Hinblick auf **Beta-Carotin** und **Vitamin A**, die mit 40T integriert und für die Entwicklung des **Auges** unerlässlich sind. Die **Retinsäure** ist in diesem Stadium ebenfalls wichtig und involviert große Gene.

Stellen Sie sich eine zentrale Achse vor, um die sich das Neuralrohr entwickelt. Diese Chordalplatte liefert Informationen durch ein **elektromagnetisches Feld** der Position, das wie ein **GPS** für die umgebenden Zellen wirkt, was zur Reaktion verschiedener **Proteine** führt. Zum Beispiel entwickeln sich die Augen an einem bestimmten Ort, während sich andere Teile, wie die Füße, an anderen Stellen bilden. Die empfangenen Informationen in Bezug auf die Mittellinie variieren je nach Raum und Zeit.

Das elektrische Feld, das von dieser Chordalplatte ausgesendet wird, erstreckt sich zwischen links und rechts sowie zwischen vorne und hinten. Beim Eintritt in den **nodalen Fluss** beobachtet man sich bewegende Zellen, ähnlich wie fallender Schnee, wobei Zilien um die Achse der Chorda dorsalis rotieren. Diese Dynamik ermöglicht die Übertragung von Mikroinformationen nach links und trägt zur **Lateralisierung** des Embryos bei.

Es ist wichtig zu beachten, dass es keine Symmetrie gibt, sondern vielmehr eine **Harmonie** in der Strukturierung der genetischen Information in Bezug auf die Chorda dorsalis. Wenn man Zellen als **Moleküle** betrachtet, dann werden **Proteine** produziert und freigesetzt. Diese Informationen stammen aus dem **Genom**, das verschiedene Gene je nach Raum-Zeit aktiviert, insbesondere im Rahmen der **sonetic edges** und des **PAX-Raum-Zeit-Kontinuums**.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass die Chorda dorsalis nicht nur eine Struktur, sondern eine **Funktion** ist. Diese Unterscheidung ist grundlegend: Die Chorda dorsalis als Funktion wahrzunehmen, ermöglicht es, ihre Kräfte und Reaktionen zu erfassen, was für die Organisation des **Gehirns** und des **Auges** unerlässlich ist.

06. HEMMUNG UND KOLOKALISATIONEN

DAUER : 05:42

LEHRBLATT

KURZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video erforscht die komplexen Mechanismen von Hemmung und Kolokalisationen in der Embryonalentwicklung und beleuchtet die Bedeutung der Linksseitigkeit und die entscheidende Rolle des Neuralrohrschlusses. Zu den behandelten Schlüsselkonzepten gehören die Bildung der Augenbläschen, die Interaktion zwischen der Neuralleiste und verschiedenen Organsystemen wie dem hepato-pankreatischen System und dem Herzen sowie wie diese Interaktionen die Entwicklung des Auges beeinflussen. Durch die Integration von Prinzipien der elektromagnetischen Theorie demonstriert das Video den Einfluss dieser Prozesse auf die embryonale Morphologie und die Genomexpression.

HEMMUNG UND KOLOKALISATIONEN IN DER EMBRYONALENTWICKLUNG

Lateralisierte Informationen, sonetisch und hutch, sind essenziell für die Embryonalentwicklung, insbesondere in der Links-Rechts-Dynamik. Eine **linke Lateralität** beginnt sich zu etablieren, aber ein inhibitorisches Phänomen verhindert die Expression von Sonetik und Hutch nach vorne und fördert eine laterale Expression.

Diese Hemmung hängt mit der **Nicht-Schließung des Neuralrohrs** zusammen. Ohne diese Hemmung könnte sich ein Zyklopendauge entwickeln, da die zentrale Hemmung die Bildung von zwei kleinen lateralen Vesikeln ermöglicht. Wenn das Neuralrohr nicht geschlossen ist, erscheint das Auge um den 22. Tag, und der Verschluss des anterioren Neuroporus erfolgt um den 24. oder 25. Tag.

Zu diesem Zeitpunkt entsteht eine **sogenannte „negative“ Information** aus der Neuralleiste, die Kolokalisationen mit Informationen aus dem **hepatopankreatischen System** und dem **Herzen** aufweist. Das Herz empfängt wichtige Informationen von der Neuralleiste, ebenso wie der Rachen. Diese Kolokalisationen äußern sich im Auge, wobei Gene in verschiedenen Räumen kodieren, was Systeme der Kolokalisation genetischer Informationen illustriert.

Ein **Autokörper** repräsentiert eine genomische Funktion und dient als Referenz für den Körper. Dieses elektrische Feld, das aus einer Polarität resultiert, ist fundamental. Nach dem **Maxwell-Gesetz** erzeugt jedes elektrische Feld ein elektromagnetisches Feld. Somit empfängt jedes Individuum eine spezifische Information.

In der Anotocorte empfangen die vorderen Zellen eine Information, die als Sonetik HH bezeichnet wird. Wenn dieses Wachstum verlangsamt wird, tritt eine Beschleunigung auf, die zu einer Expansion des Epithels führt, verbunden mit genetischen Prozessen. Solange das Neuralrohr jedoch nicht geschlossen ist, bleibt ein kleiner Spalt bestehen.

Ohne Hemmung entwickelt sich das Auge in der Mitte, was zur Bildung eines Zyklopenauges führt. Der Verschluss des Neuralrohrs ist entscheidend, damit sich die Neuralleiste lateral ausdrücken kann. Sobald der Verschluss erfolgt ist, beeinflusst die negative Hemmung das Auge, in Verbindung mit **thyreoidalen**, **kardialen** und **hepatopankreatischen** Kolokalisationsphänomenen. Diese großen Organe haben einen direkten Einfluss auf das Auge, das stark mit der **Aderhaut**, einem vaskulären mesenchymalen Gewebe, verbunden ist.

Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie das Auge im Raum interagiert. Die starke Beugung des Embryos hängt mit dem Auftreten der **Augenbläschen** zusammen, die sich aufgrund des Wachstums und dieser Beugung bilden. Diese Beugung wird durch die **primitive aortale Gefäßachse** induziert, um die sich das Gefäßsystem windet.

07. BILDUNG DER AUGENPLAKODE

DAUER : 04:28

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video befassen wir uns eingehend mit der Bildung der Augenplakode, einem Schlüsselereignis der Embryonalentwicklung. Aus dem Ektoblasten und dem Neuralrohr entsteht die erste Augenanlage, die die Bedeutung der Zellkommunikation in verschiedenen Formen, insbesondere autokrin, parakrin und juxtakrin, und ihre Interaktion mit genetischen Phänomenen wie dem Sonic Hedgehog (HH) aufzeigt. Wir untersuchen die Bildung der Augenblase und die Umwandlung des Epiblasten in die primitive Augenplakode, wobei wir den Einfluss umgebender Strukturen wie der Chorda dorsalis und der Kolobomspalte auf die Morphogenese des Auges hervorheben. Dieser Inhalt ist essenziell für jeden Studenten oder Therapeuten, der sein Verständnis der embryologischen Entwicklung des Auges vertiefen möchte.

BILDUNG DER AUGENPLAKODE

In diesem Abschnitt werden wir die **Bildung der Augenplakode** aus dem Oberflächenektoblast und dem Neuralrohr untersuchen.

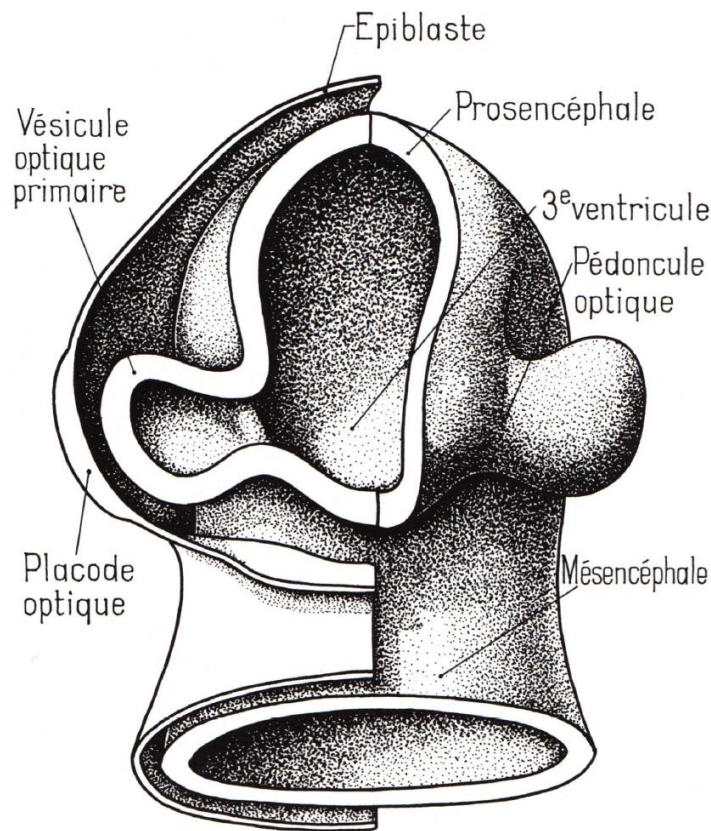


Fig. 1 b. — Environ 27 jours (4 mm).

ABB. — Neuralrohr und die sich bildenden Augenanlagen

Wir beobachten zunächst das **Neuralrohr** im Inneren, mit dem **Neuroporus** und der noch nicht geschlossenen **Gehirnrinne**. In diesem Stadium erscheint die erste **Augenanlage**. Dieses Auftreten ist auf eine **Expansion** durch Stützpunkte nach außen zurückzuführen.

ARTEN DER ZELLKOMMUNIKATION

Es ist wichtig, die verschiedenen Arten der **zellulären Kommunikation** zu verstehen:

1. **Autokrin:** Die Zelle informiert sich direkt selbst.
2. **Parakrin:** Die Zelle informiert ihren Nachbarn durch direkten Kontakt.
3. **Telokrin:** Fernkommunikation, wie im Fall von **endokrinen** Hormonen.
4. **Neurokrin:** Kommunikation über Neurotransmitter.
5. **Justakrin:** Kommunikation zwischen benachbarten Zellen.

Im Fall der Augenplakode ist die Information des Ektoblasten mit einem genetischen Phänomen verbunden, insbesondere dem **Sonic Hedgehog (HH)**, das an der Spitze der prächordalen Platte gehemmt wird. Dies führt zu einer **lateralen Expansion** durch verschiedene genetische Phänomene.

BILDUNG DER AUGENBLASE

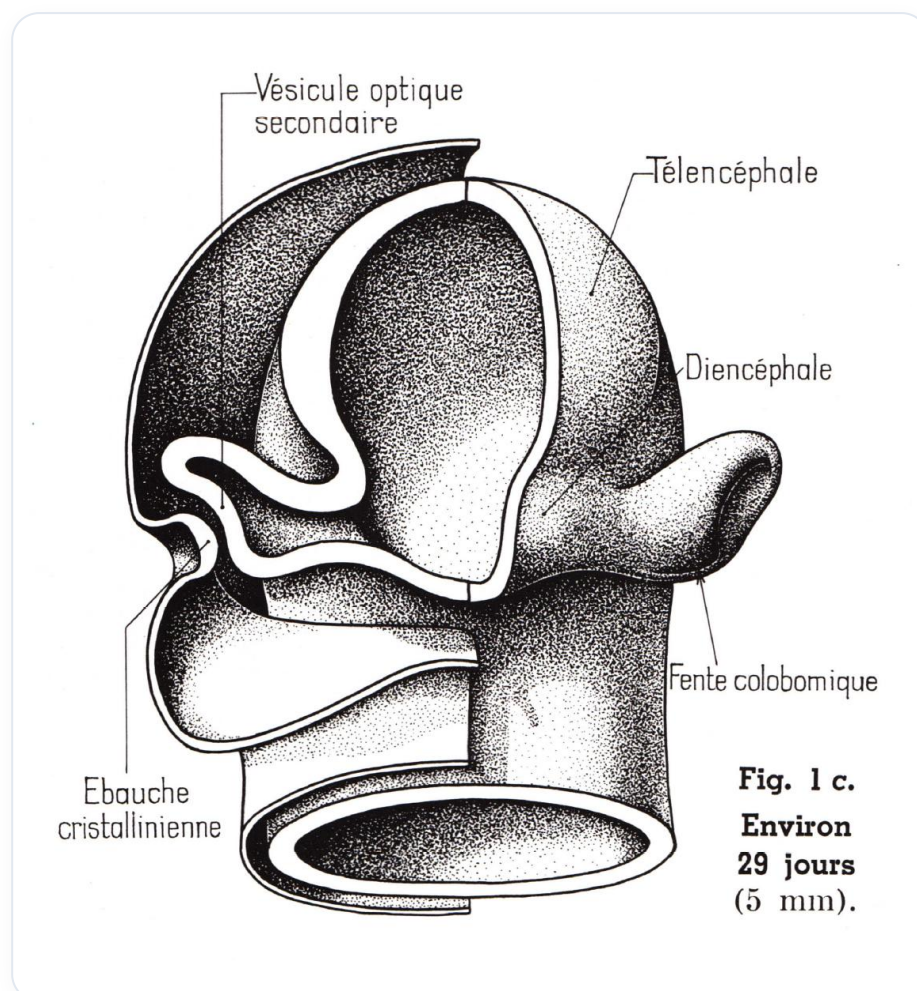
Wir beobachten die beginnende Bildung der **primären Augenblase**. Zwei laterale Bläschen erscheinen und drücken auf den Teil des Oberflächenepiblasten. Es kommt zu einer **justakrinen Stoffwechselreaktion**, die zu einer Schwellung führt, die die **primitive Augenplakode** bildet.

Anfangs, zwischen dem **siebten und achten Tag**, erscheint ein epiblastisches Gewebe. Dieses Gewebe entwickelt sich zu einer **Neuralplatte**, die unter dem Einfluss der **Chorda dorsalis** ihre Form ändert und zu einer **Rinne** wird. Diese Rinne schließt sich, um ein **Neuralrohr** zu bilden. Der obere Teil verschwindet und hinterlässt die **Neuralleiste** und das Oberflächenepiblastengewebe.

AMNIONFLÜSSIGKEIT UND LIQUOR

Die Flüssigkeit über der Augenplakode ist dieselbe wie die im Inneren, d.h. die **Amnionflüssigkeit**, die später zum **Liquor cerebrospinalis (LCS)** wird.

Die kleinen lateralen Bläschen schwellen an, und durch einen molekularen **justakrinen** Kontakt verändert sich das Epithelgewebe, um die **Augenplakode** zu bilden. Diese Plakode wird zu einem **Fulcrum**, das auf der Zeichnung den Eindruck erweckt, sich zu vertiefen. Dies ist auf das Wachstum von außen zurückzuführen, das einen Stützpunkt schafft.



KOLOBOMSPALTE

Es ist wichtig zu beachten, dass es eine **Kolobomspalte** gibt, durch die eine Arterie, bekannt als **Hyaloidarterie**, verläuft. Diese Spalte spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Augenplakode und der umgebenden Strukturen.

08. URSPRUNG DER NETZHAUT UND DER LINSE

DAUER : 04:24

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Untersuchung der Augenembryologie, von der Entwicklung der Netzhaut bis zur Linse. Nachweis von juxtakrinen Kommunikationen und Interaktionen zwischen Epiblast, Liquor und Amnionflüssigkeit. Untersuchung der primären und sekundären Augenblase und der Transformation der hyaloiden Gefäße in das retinale Netzwerk (Erweiterung des Gehirns, moduliert durch chemische Gradienten). Die Organogenese der Linse ist mit dem Oberflächenepithel und der Unterteilung der Augenkammern verbunden.

URSPRUNG DER NETZHAUT UND DER LINSE

Die Entwicklung des Auges beginnt mit der Beobachtung eines **Raumes** zwischen den verschiedenen Strukturen. Das **Epiblast** heftet sich an und ändert seine Form, während sich im Inneren **Zerebrospinalflüssigkeit (CSF)** und **Fruchtwasser** befinden, die einen gemeinsamen Ursprung haben.

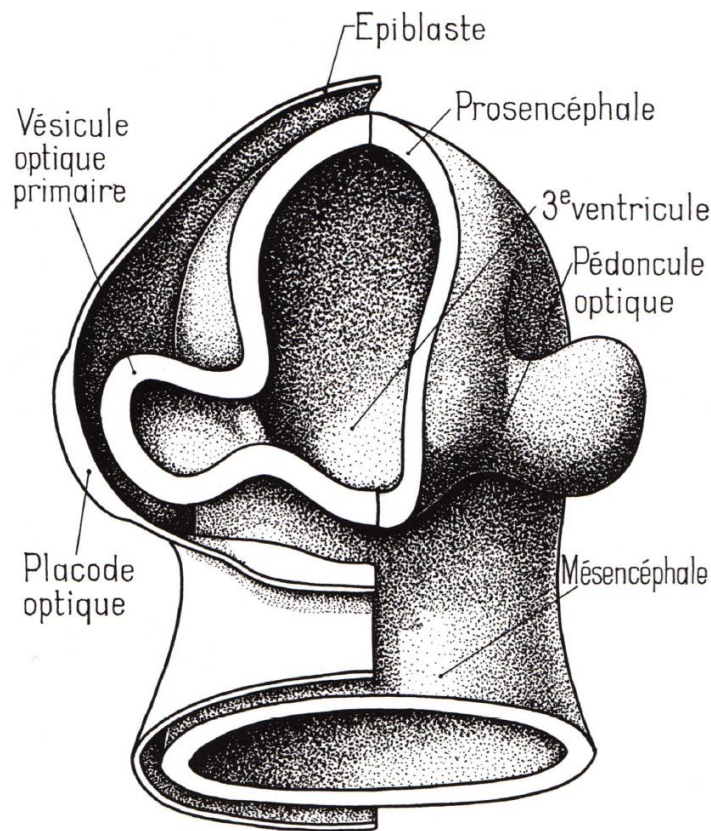


Fig. 1 b. — Environ 27 jours (4 mm).

ABB. — Erste Stadien der Augenentwicklung

Eine **juxtakrine Kommunikation** wird hergestellt, die molekulare Verbindungen ermöglicht. Man beobachtet auch den Verlauf eines Gefäßes, das die erste Welle der **Aderhaut**, des vaskulären Gewebes des Auges, darstellt. Diese Invasion ist entscheidend für die Bildung einer Arterie, die verschiedene Komponenten wie das Vorhandensein von **Vesikeln** und einen **chemischen Gradienten** beinhaltet.

Die Kolobomspalte ermöglicht den Durchtritt der **Hyaloidgefäße**, die sich später zu **Netzhautgefäßen** entwickeln. Die Kommunikation zwischen dem Epiblast und diesem Bereich führt zur **primären Augenblase**, die sich zur **sekundären Augenblase** entwickelt. Dieses Gewebe teilt sich in das **innere Blatt** und das **äußere Blatt** der Netzhaut und bildet so den **Netzhautraum**.

Anatomen und Embryologen betrachten die Netzhaut als eine Erweiterung des **Gehirns**, beeinflusst durch die Zerebrospinalflüssigkeit und die auf interzellulärer Ebene ausgeschiedenen Informationen. Die **Linseblase**, aus der die **Linse** hervorgeht, stammt ebenfalls vom Oberflächenepiblast. Diese Begegnung erfolgt durch juxtakrine Kommunikation.

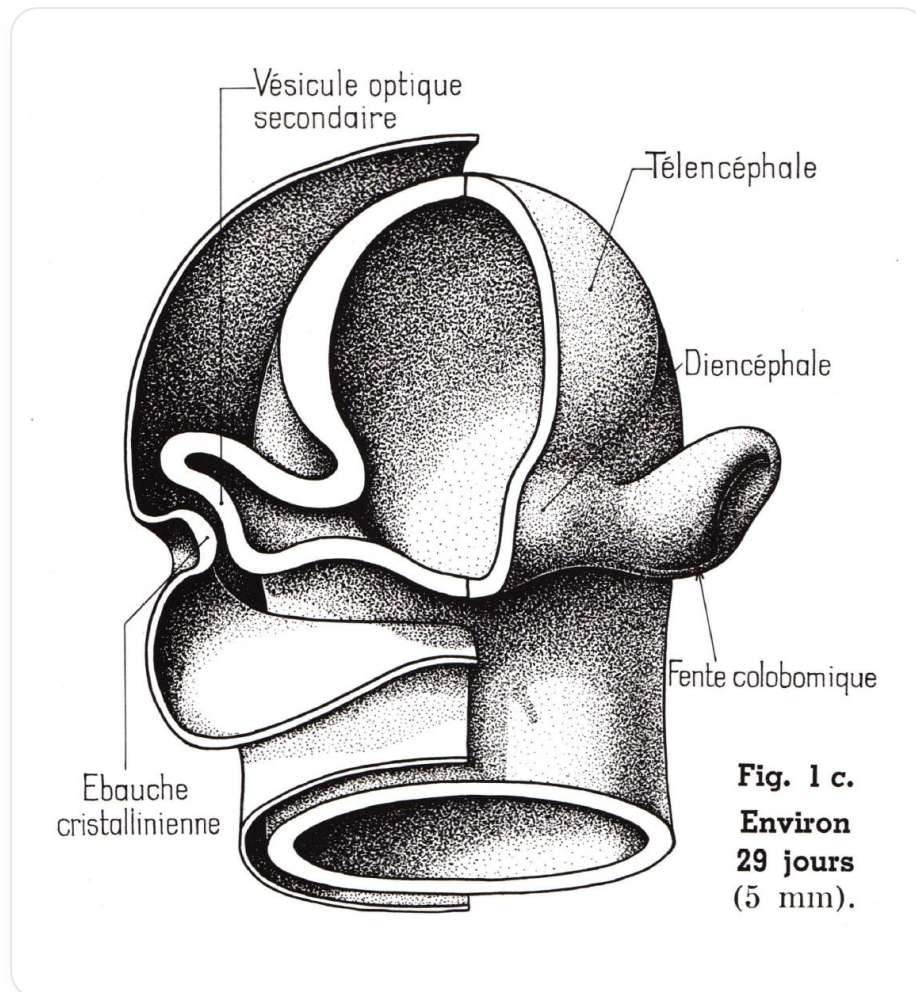
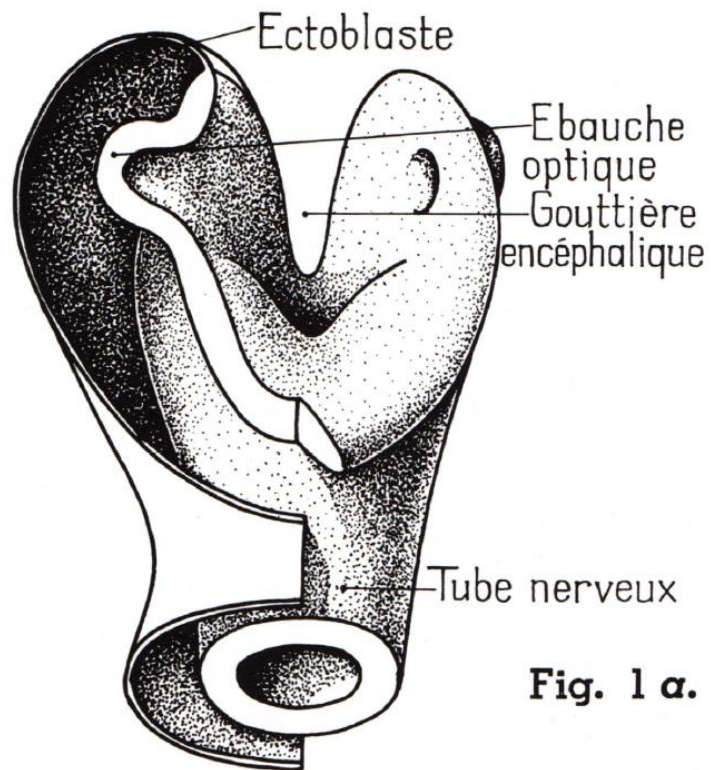


ABB. — *Bildung der Augenblase und Differenzierung der Netzhaut*

Die Linse bildet sich im Inneren, während das Oberflächenepithel an Ort und Stelle bleibt, einem ähnlichen Schema folgend wie bei der Bildung des **Neuralrohrs**. Die Haut an der Oberfläche teilt sich in verschiedene Schichten. Das Linsengewebe bildet die erste Schicht des Auges.

Die **Bindehaut** ist die erste Membran, die das Auge bedeckt und auch die zukünftigen Augenlider auskleidet. Im Inneren der Linse teilt sich ein Raum in zwei Kammern: die **vordere** und die **hintere**. Die Netzhaut ist ihrerseits extrem dünn, ähnlich einem Zigarettenpapier.



Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.

ABB. — Entwicklung und Invagination der Linse

09. DIE VERSCHIEDENEN SCHICHTEN DES AUGES 1

DAUER : 05:01

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Analyse der okulären Histologie (Sklera, Choroidea, Ziliarkörper, Retina) und ihrer funktionellen Besonderheiten. Einführung in die Prinzipien der Iridologie als diagnostischer Ansatz für Gewebe. Detaillierte Erklärung der Aktivität von Photorezeptoren und der Pigmentschicht, die die biochemischen Mechanismen der visuellen Transduktion illustriert.

DIE VERSCHIEDENEN SCHICHTEN DES AUGES

Das **Auge** besteht aus mehreren Schichten, die oft als übereinanderliegende Socken beschrieben werden.

1. DIE SKLERA

Die erste Schicht, die **Sklera**, steht vorne in Verbindung mit der **Kornea** (Hornhaut). Die Kornea ist eine **transparente** Struktur, die es Licht ermöglicht, in das Auge einzudringen. Der **Limbus** und der weiße Teil des Auges, bekannt als **Sklera**, bilden diese erste Socke.

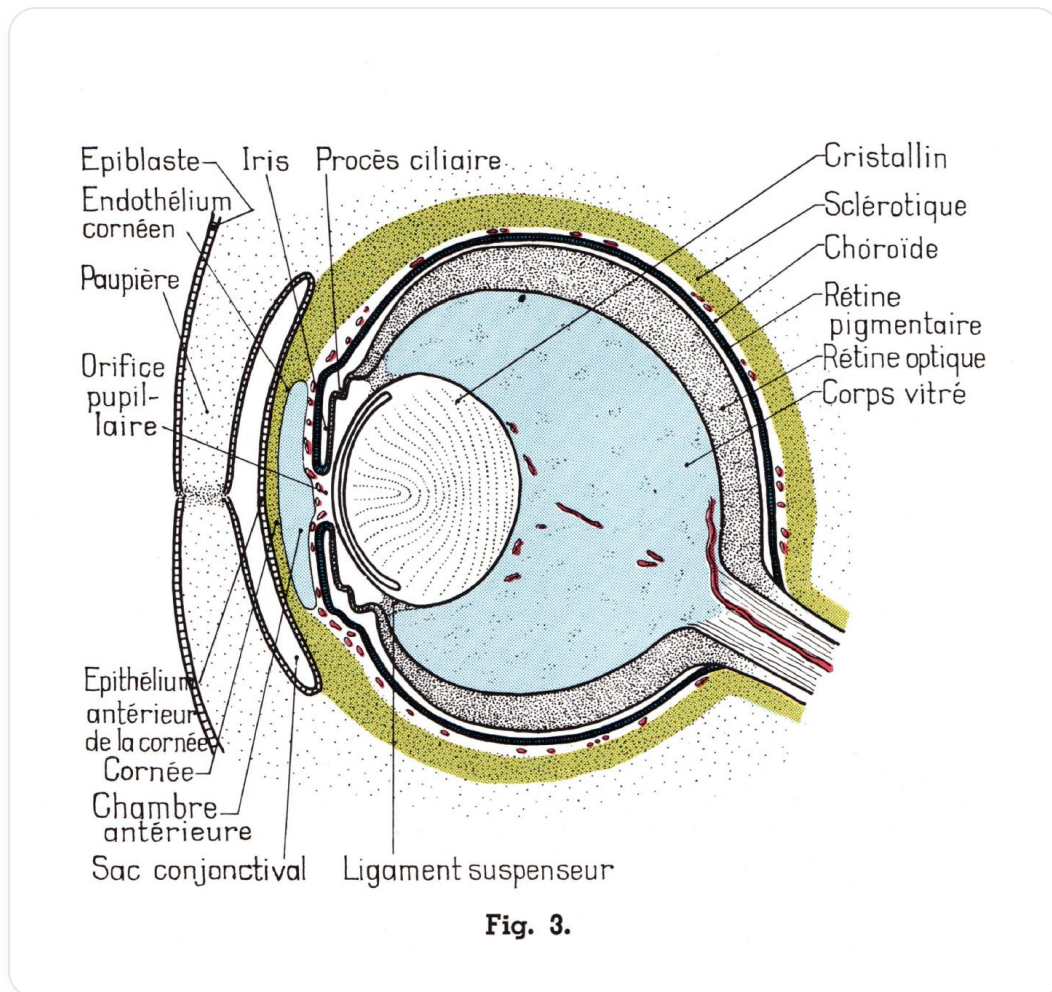


ABB. — Allgemeines Schema des Auges

2. DIE CHOROIDEA

Entfernt man die Sklera, entdeckt man die **Choroidea** (Aderhaut), eine extrem **vaskularisierte** Schicht. Die Choroidea setzt sich nach vorne mit der **Iris** (Regenbogenhaut) fort. Die **Iridologie** ist eine Praxis, bei der Informationen über die Gesundheit durch die Iris abgelesen werden, die verschiedene Elemente, wie zum Beispiel **Schwefel**, speichern kann.

3. DIE ZILIARFORTSÄTZE

Die **Ziliarfortsätze** und die **Aufhängemuskeln der Iris** spielen eine entscheidende Rolle in der **Physiologie** des Auges. Diese Strukturen sind wesentlich für das **Akkommodationssystem**, das es der **Linse** ermöglicht, ihre Form zu ändern, damit das Bild korrekt auf die **Retina** (Netzhaut) projiziert wird.

4. DIE RETINA

Die dritte Socke ist die **Retina**, das tiefste Nervengewebe und eine Erweiterung des **Gehirns**. Sie besteht aus zwei Schichten: einer inneren und einer äußeren Schicht. Eine **Netzhautablösung** tritt auf, wenn sich der Raum zwischen diesen beiden Schichten ausdehnt.

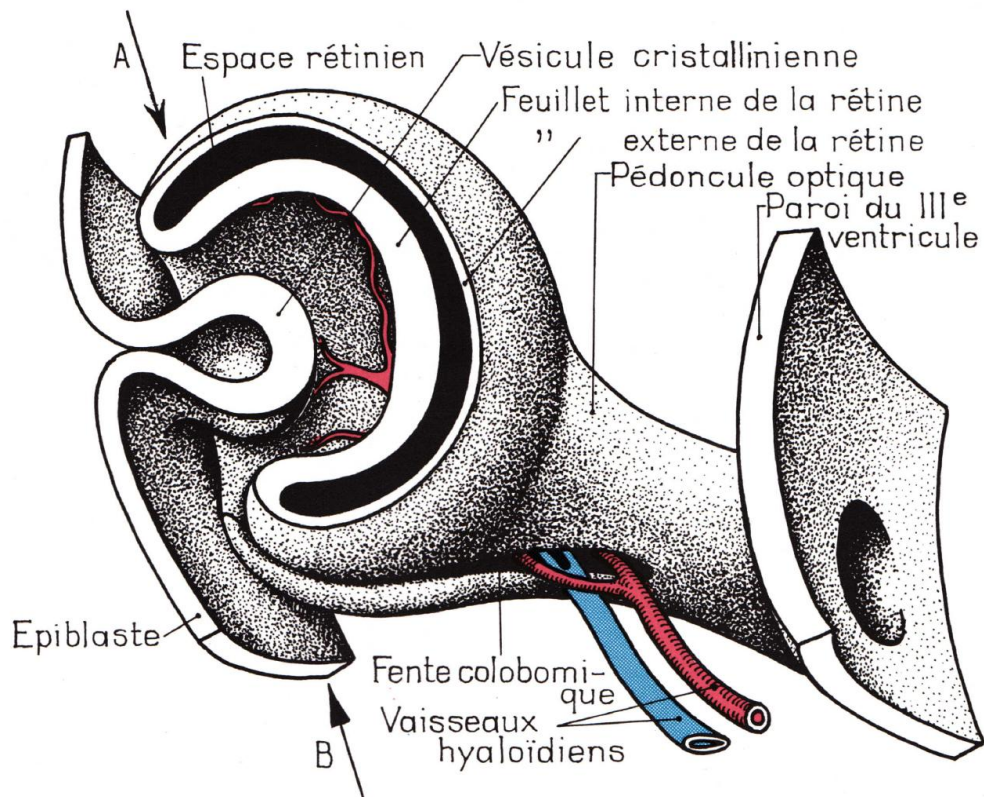


Fig. 3. — Ebauche oculaire humaine. Embryon d'environ 33 jours.

ABB. — Augen tunicae, Ziliarkörper und Netzhaut

5. DIE PIGMENTSCHICHT UND DIE PHOTOREZEPTOREN

Die Retina enthält auch eine **Pigmentschicht** und **Photorezeptoren**, die sich in **Zapfen** und **Stäbchen** unterteilen. Diese Zellen sind essenziell für die **Transduktion**, den Prozess, bei dem ein Photon in elektrische Energie umgewandelt wird, wodurch die visuelle Wahrnehmung ermöglicht wird.

FAZIT

Diese verschiedenen Schichten des Auges arbeiten zusammen, um das Sehen zu ermöglichen, wobei jede eine spezifische und entscheidende Rolle in der Funktion dieses komplexen Organs spielt.

10. ERINNERUNG AN DIE ENTWICKLUNGSBEWEGUNG

DAUER : 06:13

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet einen wesentlichen Einblick in die Entwicklung der Bewegung, wobei der Schwerpunkt auf der Integration des Schädels und der Gehirnentwicklung sowie deren Auswirkungen auf die Augenfunktion liegt. Die Konzepte der Kephalisation, Kardialisierung und die Bedeutung des Gaumens werden untersucht, um die Synergie zwischen Struktur und Funktion zu veranschaulichen. Durch die Hervorhebung der Rolle von Selbstregulationsmechanismen und der embryonalen Kraft ermöglicht die Ausbildung ein tiefgreifendes Verständnis der Entwicklungskartierung und der anatomischen Achsen. Dies führt zu einer neuen Perspektive auf die Behandlung von Pathologien wie Sehnenentzündungen, indem elektrische Wechselwirkungen und dynamische Bewegungen innerhalb der elektromagnetischen Felder des Körpers berücksichtigt werden. Die neurophysiologischen und therapeutischen Implikationen werden ebenfalls diskutiert, was neue Wege für Praktiker eröffnet.

ERINNERUNG AN DIE ENTWICKLUNGSBEDINGTE BEWEGUNG

Die Integration von **Schädel** und **Gehirnentwicklung** ist entscheidend für das Verständnis der entwicklungsbedingten Bewegung. Das Auge, das sich anfänglich sehr lateral entwickelt, bewegt sich allmählich nach vorne. Dieser Prozess ist Teil einer globalen Körperentwicklung, die Mechanismen wie die **Kephalisation**, die **Kardialisierung**, den **Ascensus** des Gehirns und die **viszerale Deszensus** umfasst.

Diese Entwicklung wird auch durch das **Gaumenbein** beeinflusst, das zu einem Stützpunkt für das Auge auf der Schädelebene wird. Jeder Schädelknochen spielt eine entscheidende Rolle für die ordnungsgemäße Funktion des Auges. Das Verständnis dieser Entwicklung ermöglicht es, die **funktionelle Kraft** und die **therapeutische Kraft** zu erfassen. Die Beziehung zwischen **Struktur, Funktion** und **Form** ist grundlegend: Die Form ist der Ausdruck von Struktur und Funktion. Eine gute Struktur führt zu einer guten Form.

Der Körper besitzt **Selbstregulationsmechanismen**, die es ihm ermöglichen, sich durch **allostatische** und **homöostatische** Prozesse auszugleichen. Allostase ist ein interner Prozess, der zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts beiträgt. Die embryonale Kraft oder Heilkraft nutzt

dieselbe Energie, die im Embryo vorhanden ist, um eine Form zu entwickeln. Somit teilen die embryologische Entwicklung und die Körperregeneration eine gemeinsame Energie.

Die Kenntnis der Entwicklungsprozesse bedeutet, die **Kartierung** dieser Entwicklung zu verstehen, die einer spezifischen Organisation folgt. Zum Beispiel öffnet sich ein Glied zuerst auf eine bestimmte Weise, bevor es eine komplexere Bewegung ausführt. Diese Entwicklung findet gleichzeitig mit anderen Bewegungen im Körper statt.

Die Bedeutung des Gehirns ist entscheidend, und es ist notwendig, die **anatomischen** und **strukturellen Achsen** neu zu betrachten. Letztendlich manifestiert sich all dies in einem **elektrischen Feld**. Bei der Behandlung einer Tendinitis ist es relevant, in elektrischen Begriffen zu denken, da die Interventionen an diesen Gehirnachsen eher elektrische Felder als einfache Strukturen betreffen.

Das Auge ist in einer Sphäre reiner Energie verwurzelt und sucht eine elektrische Achse. Diese Vorstellung von **Polarität** ist von Anfang an im Organismus integriert, mit Nähr- und Follikelzellen sowie spezifischen Stoffwechselkonzentrationen. Diese elektromolekularen Ebenen erzeugen dynamische Bewegungen.

Bei der Arbeit am Auge ist es wichtig, diese elektrischen Aspekte zu berücksichtigen. Die Achse der Augen ist verwurzelt, und die Bewegungen der Wurzeln veranschaulichen, wie elektromagnetische Felder funktionieren. Diese Bewegungen sind nicht linear, sondern eher molekulare und ionische Bewegungen. Die **Transduktion** eines Photons in ein elektrisches Feld beinhaltet Änderungen der Membranpermeabilität, die im Rahmen der **Neurophysiologie** untersucht werden, insbesondere mit Elementen wie **Rhodopsin** und **Metarhodopsinen**. Diese Integrationsänderungen zeigen, wie energetische Informationen die Membranform verändern.

11. PRAXIS: KOMPRESSION V4 UND ZONE B

DAUER : 07:04

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der Praxis der Kompression des vierten Ventrikels (CV4) in Verbindung mit dem Foramen Mangali und dem Gleichgewicht zwischen dem intra- und extraenzephalischen Milieu. Die Teilnehmer lernen, wie sie effektiv mit dieser Technik arbeiten können, um die Zirkulation der Zerebrospinalflüssigkeit und die körperliche Harmonie zu fördern, indem sie Schlüsselkonzepte wie die Haltung der Neutralität und die Bedeutung der weiträumigen Aufmerksamkeit integrieren. Anhand von klinischen Beispielen und präzisen Anweisungen führt die Sitzung die Therapeuten in die Kunst der Kompression ein und unterstreicht die Bedeutung von Geduld und der Verbindung von Körper und Geist im Heilungsprozess.

PRAXIS: CV4-KOMPRESSION UND ZONE B

In dieser Sitzung werden wir uns mit der **Kompression des vierten Ventrikels** (CV4) befassen. Diese Technik steht in Verbindung mit **Mangali**, einem Schlüsselkonzept, das die Erforschung des **extraenzephalischen Raums** darstellt.

Die Verbindung auf der Ebene des vierten Ventrikels ist essenziell, da sie mit den **Plexus choroidei** zusammenhängt, die den **Liquor cerebrospinalis** produzieren. Hinten gibt es eine Öffnung zum **intraenzephalischen Flüssigkeitskompartiment**, die den vierten Ventrikel mit dem dritten Ventrikel, den Augen und den Seitenventrikeln verbindet. Dieser Durchgang ist als **Foramen von Mangali** bekannt.

Ziel dieser Praxis ist es, ein **Gleichgewicht** zwischen dem intra- und extraenzephalischen Milieu zu finden. Das Auge spielt eine entscheidende Rolle in diesem Gleichgewicht, und wir werden durch den CV4 arbeiten, um diesen Zustand der Harmonie zu erreichen.

Die Kompression sollte mindestens **sieben Minuten** dauern, damit der Körper sich **ausdrücken** und befreien kann. In dieser Phase ist es wichtig, aufmerksam zu sein, um eine **EV4** durchzuführen, eine Expansion des vierten Ventrikels in Richtung **Zone B**, wodurch der umgebende Raum gefüllt wird.

Es ist unerlässlich, während dieser Praxis eine Haltung der **Neutralität** einzunehmen. Vermeiden Sie den Wunsch, "es gut zu machen", da dies zu einem inneren Wettbewerb führen kann. Lassen Sie den Raum auf natürliche Weise entstehen, denn in dieser Begegnung der **beiden Neutralen** findet Heilung statt.

Ein anschauliches Beispiel ist das von Doktor **Jalous**, der Becker behandelte. Nach einigen Minuten der Behandlung äußerte Becker seine Ungeduld, aber Jalous erklärte, dass die eigentliche Behandlung oft nach dem Ende der Manipulation beginnt. Es ist entscheidend, dem Prozess Zeit zu geben, sich zu etablieren und dem Stück zu ermöglichen, sich zu setzen.

Um den CV4 zu visualisieren, positionieren Sie sich direkt unterhalb des **Inion**, am hinteren Teil des **Kleinhirns**. Achten Sie darauf, die **Karotiden** nicht zu komprimieren; wenn sie blau werden, muss die Kompression beendet werden. Die Daumen sollten leicht locker sein, und es ist wichtig, einen guten **Fulcrum** zu finden.

Der CV4 erfordert die Beteiligung Ihres gesamten Körpers, nicht nur Ihrer Hände. Finden Sie ein Gleichgewicht zwischen vorne, hinten, links und rechts, indem Sie sich auf Ihren eigenen **Schwerpunkt** konzentrieren. Die Kompression muss ein bewusster Akt sein, bei dem Ihr Körper und Ihr Geist im Dienste Ihrer Hände stehen.

Es ist entscheidend, nicht mit Ihrem Blick zu komprimieren. Eine zu starke Fokussierung kann zu einem Bewusstseinsverlust führen. Versuchen Sie, eine **weite Aufmerksamkeit** aufrechtzuerhalten, die Ihre Zone B und Ihre innere Flüssigkeit ausgleicht.

Wenn Sie eine Reaktion spüren, deutet dies auf eine **EV4** hin, eine Öffnung, die die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen dem extraenzephalischen und intraenzephalischen Kompartiment darstellt, in Verbindung mit **Maljandi**.

12. DIE UNBESTÄNDIGKEIT

DAUER : 09:08

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine tiefgreifende Erkundung der Vergänglichkeit und ihrer Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung und unsere Emotionen. Die Lehre betont die Wichtigkeit, unsere eigenen Muster durch Praktiken wie Meditation zu erkennen, und lehrt uns, unsere Gedanken zu beobachten und zu einem Zustand der Neutralität zurückzukehren. Darüber hinaus behandelt sie die Funktionsweise des visuellen Systems und wie unsere Vorurteile unsere Wahrnehmung der Realität beeinflussen. Indem wir ein Verständnis für die Interdependenz von Erfahrungen entwickeln und an unserem Schwerpunkt arbeiten, können wir unsere Lebensenergie ausrichten und einen Ansatz fördern, der auf Gesundheit statt auf Krankheit ausgerichtet ist. Lernen Sie, Ihre Wahrnehmungen zu hinterfragen und sich von Ihren falschen Interpretationen zu befreien, um einen bewussteren therapeutischen Weg zu gehen.

DIE UNBESTÄNDIGKEIT

Es ist essenziell, nach und nach zu lernen, **unsere Wahrnehmung zu erweitern**. Das bedeutet, mit etwas offeneren Augen zu leben und zu lernen, unsere eigenen **Muster** zu erkennen. Beobachten Sie ein Muster: Wenn Sie es beobachten können, können Sie es **bereinigen**. Oft benutzen wir andere als Putzlappen, um unsere eigenen Scheiben zu reinigen.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass wir unsere **Zufriedenheitsmuster** nach außen projizieren, sei es auf ein Thema oder ein Objekt? Dann sind wir eines Tages enttäuscht. Wichtig ist, dass wir dem anderen irgendwann die Schuld geben. Manche gehen sogar noch weiter: Nachdem sie zu viel nach außen projiziert haben, geben sie der ganzen Welt die Schuld.

Es ist entscheidend, unsere eigenen Muster zu beobachten und zu erkennen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die **Meditation**. Wenn Sie Ihren Geist entdecken möchten, meditieren Sie. Nach wenigen Sekunden werden Gedanken aufsteigen, und Sie werden oft von einem davon entführt. Meditation besteht darin, diese Gedanken zu beobachten und zu einem Zustand der **Neutralität** zurückzukehren. Dies lehrt Sie allmählich, Ihre eigenen Muster zu entdecken, die nicht neutral sind.

Was fühlen Sie, wenn Sie sehen? Es ist unmittelbar und passiv. Sie öffnen die Augen, und die Welt ist da. Oft denken wir, dass **sehen** gleich **glauben** ist. Wir glauben, weil wir gesehen haben. Doch was wir sehen, ist keine universelle Wahrheit. Es ist keine objektive Realität, denn wir haben

Vorurteile, die unsere Wahrnehmung beeinflussen. Die Natur berücksichtigt diese Vorurteile nicht, und der therapeutische Prozess auch nicht.

Wir erschaffen eine **virtuelle Realität**, die wir für einzigartig halten. Es ist interessant festzustellen, dass Ihr visueller Kortex **30 %** Ihres Gehirns beansprucht, verglichen mit **8 %** für den Tastsinn und **2-3 %** für das Gehör. Jede Sekunde senden Ihre Augen etwa **2 Milliarden Informationen** an Ihren visuellen Kortex, während der Rest Ihres Körpers nur eine Milliarde sendet. Das bedeutet, dass das Sehen ein Drittel Ihres Gehirnvolumens ausmacht und zwei Drittel Ihrer Ressourcen verbraucht. Es ist also nicht überraschend, dass das Sehen eine so wichtige Illusion ist.

Der **Papez-Kreislauf**, einschließlich der Colliculi und der Amygdala-Kerne, zeigt, dass alles, was Sie sehen, Ihre **Emotionen** beeinflusst und umgekehrt. Das bedeutet, dass das Sehen zu einer **mentalenen Komposition** wird. Zum Beispiel kann Angst die Realität verzerren. Ich hatte ein traumatisiertes Kind, das nach dem Ansehen eines Films Angst und Gefahr miteinander assoziiert hatte. Indem ich diese beiden Erfahrungen dissoziierte, konnte ich seine Wahrnehmung der Realität neu anpassen.

Nichts existiert aus sich selbst heraus. Wenn wir das verstehen, ändert sich unsere Sichtweise. Selbst das **Ego** existiert nicht autonom; es wird zu einem Aggregat. Alles ist **interdependent** und **unbeständig**. Die Unbeständigkeit ist das, was Energie und Bewegung verleiht und unsere **Lebensenergie** oder **Chi** darstellt.

Um mit der Unbeständigkeit zu arbeiten, muss man auf jeden Moment, jeden Gedanken, jedes Detail achten. Das bedeutet, über unsere Projektionen und Ängste hinaussehen zu lernen. Nach und nach müssen wir uns von unseren **falschen Interpretationen** befreien, was nicht immer einfach ist. Manchmal wollen wir in unserer Ideologie verhaftet bleiben.

Sobald Sie denken, in der Realität zu sein, riskieren Sie, falsche Emotionen zu haben. Ich schlage Ihnen vor, Ihre **innere Stärke** zu nutzen und Ihre Vorstellungen von Glück und Erfolg neu anzupassen. Die richtige Absicht zu haben, ist von größter Bedeutung.

Wir werden mit Ihrem **Schwerpunkt** arbeiten. Die Lebensenergie befindet sich im Bauch, das ist **ARA**, eines der wichtigen Zentren. Diese Unbeständigkeit unterstützt diese Lebensenergie. Wenn Sie es schaffen, sich mit Ihrem eigenen Zentrum in Einklang zu bringen, wird das viel kraftvoller sein.

Wir werden drei Haupttypen von Energie und Bewegungen untersuchen: die **induzierte Bewegung**, die **erlaubte Bewegung** und die **präsenste Bewegung**. Es ist essenziell, seine Stärke und Schwäche zu akzeptieren, ebenso wie sein Herz für viele Möglichkeiten zu öffnen.

Wenn Menschen mit akuten Problemen kommen, stelle ich ihnen oft die Frage: "Wenn du geheilt bist, was kannst du dann tun?" Das schafft eine neue Richtung, denn es ist wichtig, mit der **Gesundheit** zu arbeiten und nicht gegen die Krankheit. Unsere Aufmerksamkeit auf die Gesundheit zu richten, ist entscheidend.

13. PRIMITIVE KRANIOSAKRALE ACHSE

DAUER : 03:34

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir ausführlich die primitive kraniosakrale Achse, die in der zweiten Woche der Embryonalentwicklung mit der Bildung der Chorda dorsalis entsteht. Die Lehre beleuchtet die Bedeutung dieser Struktur für den Schädel und das Kreuzbein, insbesondere indem sie hervorhebt, wie ein freies Kreuzbein unerlässlich ist, um die Funktionalität der Wirbelsäule und die Flexion-Extension der Schädelbasis zu gewährleisten. Darüber hinaus behandelt das Video die Auswirkungen dieser embryonalen Dynamik auf urogenitale Pathologien und wie die Lösung bestimmter emotionaler oder energetischer Blockaden zwischen dem Sigma und der Blase zu einem besseren Gesamtgleichgewicht beitragen kann. Die Studenten lernen, diese Konzepte zu manipulieren, um ihre Praxis in der Osteopathie und der biodynamischen Embryologie zu verbessern.

PRIMITIVER KRANIOSAKRALER ACHSE

In der zweiten Woche der Embryonalentwicklung beginnt die **S-Form** des Epiblastenprozesses die **Notochord** zu bilden. Der **Hensen-Knoten**, oder primitive Grube, wird zu einem fixen Stützpunkt und bewegt sich allmählich nach hinten.

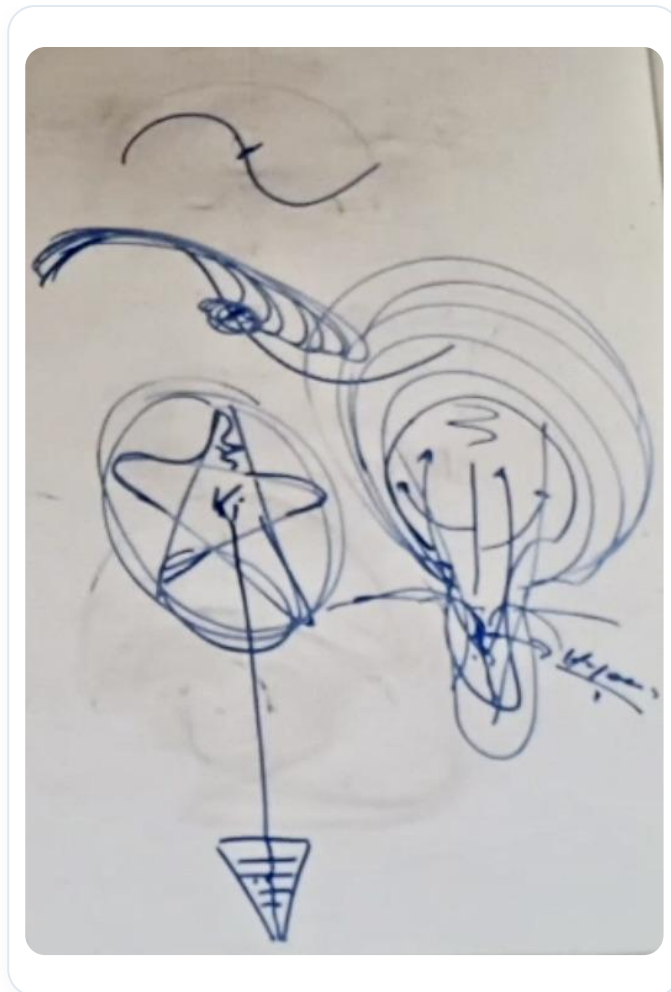


ABB. — Beginn des Epiblastenprozesses

Diese Struktur ist wesentlich, da sie die Basis des **Schädels** bildet und Elemente wie die **Hypophyse**, die **großen Keilbeinflügel**, das **Felsenbein-System**, das **Okzipital-System** und das **Siebbein** integriert. Unten beginnt die Entwicklung des **Kreuzbeins** mit dem S2-Prozess, der den Überrest der Primitivrinne darstellt. Dieser Prozess wird zu einem entscheidenden Stützpunkt und unterstreicht die Bedeutung eines **freien Kreuzbeins** für eine funktionelle Einheit.

In dieser Entwicklungsphase nimmt der Embryo eine schlägerähnliche Form an, mit der Notochord und der Primitivrinne. Dieser Wachstumsprozess erzeugt ein Aspirationsfeld zur Bildung des **Mesoderms**, insbesondere des präkardialen Feldes. Das anteriore Wachstum des Embryos saugt Material in diesen Bereich, wodurch **Flaschenzellen** zum Zentrum gezogen werden. Diese Zellen setzen **Hyaluronsäure** frei, die auf mesenchymaler Ebene essentiell ist.

Die Notochord-Achse ist grundlegend, da sie die Bewegungsfreiheit des Kreuzbeins beeinflusst. Ist das Kreuzbein blockiert, kann die Wirbelsäule nicht richtig funktionieren, was die Schädelbasis beeinträchtigt. Eine nicht freie Schädelbasis verhindert eine gute **Flexion-Extension**, was zu einem Ungleichgewicht zwischen **Neurokranium** und **Viszerokranium** führt.

Diese Dynamik hängt mit der aufsteigenden Kraft des Schädels zusammen, wo sich das Auge einnistet, und mit der Etablierung eines **mesodermalen Gewebes**. Das ektodermale Wachstum zieht nach oben, während der Primitivknoten zum Kreuzbein absteigt. Dies schafft einen

wichtigen Bereich für Proteininformationen in Bezug auf die Mutter.

Viele blockierte **Ahnenbilder** befinden sich zwischen dem Sigma und der Blase, wo es entscheidend ist, diese Informationen zu klären. Urogenitale Probleme können durch diese Informationen übertragen werden, und die absteigende sakrale Migrationskraft spielt eine Schlüsselrolle in diesem Prozess.

14. VERSCHIEDENE SCHICHTEN DES AUGES 2

DAUER : 05:25

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

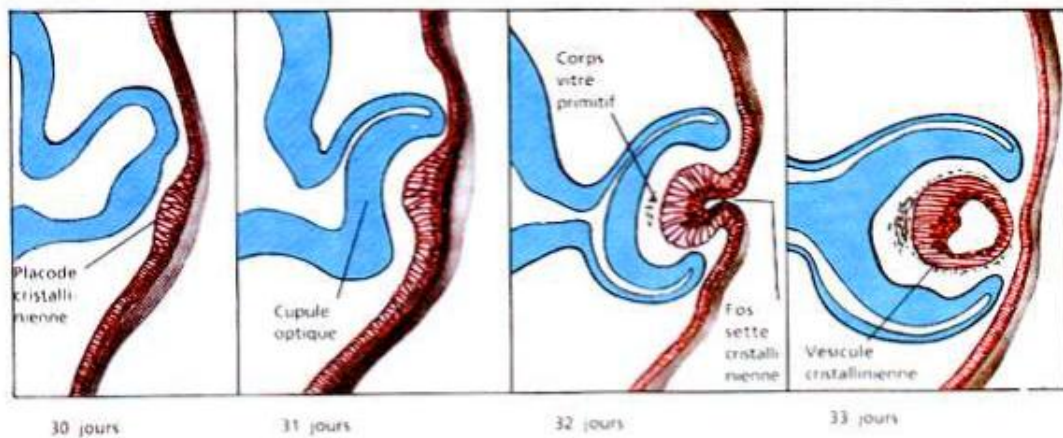
Dieses Video befasst sich eingehend mit den verschiedenen Schichten des Auges, insbesondere mit dem Cloquet-Kanal, dem Kammerwasser, dem Glaskörper und der Entwicklung der Linse aus dem Ektoderm. Zu den Schlüsselkonzepten gehören die Bedeutung der Invagination bei der Linsenbildung und die Unterscheidung zwischen dem vorderen und hinteren Teil des Auges, einschließlich der Linsenblase und der Netzhaut. Durch die Aufdeckung der Verbindungen zwischen den Augenstrukturen beleuchtet das Video komplexe embryologische Prozesse, die die Praxis der Therapeuten und ihr Verständnis von Augenpathologien bereichern.

DIE VERSCHIEDENEN SCHICHTEN DES AUGES

Es verbleibt ein **feiner Kanal** im Auge, der sogenannte **Cloquet-Kanal**. Dieser Kanal ist ein Überbleibsel im Glaskörper.

Der **Kammerwasser** und der **Glaskörper** sind zwei Arten von Flüssigkeiten, die im Auge vorhanden sind. Der Glaskörper kann als ein **gelatinöser Wasserballon** vorgestellt werden, der im Auge schwimmt, mit einem feinen Kanal in seinem Zentrum, der direkt mit der **Linse** verbunden ist. Dieser Kanal ist auch mit dem **Sehnerv** oder dem **Hyaloidkanal** verbunden.

Die Linse stammt aus dem Oberflächen-**Ektoderm**. Während der fünften Entwicklungswoche bildet eine **Invagination** eine **Linsenblase**, die von **vaskularisiertem Mesenchym** umgeben ist. Die Plakode invaginiert, um die Linse zu bilden, ein Prozess, der dem der Bildung des **Neuralrohrs** ähnelt. Diese Bewegung hinterlässt einen Raum im Inneren, der zur Linse wird.



Formation du cristallin

ABB. — Invagination des Ektoderms

Die Linse durchläuft eine Entwicklung, die **primitive Linien** bildet. Es ist wesentlich zu verstehen, wie sie sich wie ein Neuralrohr entwickelt, um die Akkommodationslinse zu werden.

Die **Kolobomspalte** weist eine Linie auf, die zusammen mit den Arterien den Cloquet-Kanal bilden wird. Dieser Kanal schließt sich mit der **Hyaloidarterie** und **-vene**, die sich im Zentrum befinden. Die primäre Linsenblase entwickelt sich zu einer sekundären Linsenblase mit der Plakode.

Außen bildet sich die **Sklera**, die die erste Hülle darstellt. Die **Aderhaut** bildet die zweite Hülle und verbindet die Linse. Das Auge kann in zwei Teile unterteilt werden: **anterior** und **posterior**. Der vordere Teil teilt sich in **vordere Augenkammer** und **hintere Augenkammer**.

Die **Bindehaut** und die **Hornhaut** stehen in Kontinuität, wobei die Hornhaut transparent und in Kontinuität mit der Sklera ist. Die Aderhaut, auch **Uvea** genannt (vom lateinischen *uva*, was Traube bedeutet), ist eine gefäßreiche Haut. Sie teilt sich in drei Teile: die Aderhaut, die Hornhaut vorne und die **Iris** hinten, die eine Fortsetzung der Aderhaut ist.

Die **Iris** wird von einem **Aufhängeband** und **Ziliarmuskeln** gehalten.

Schließlich ist die **Netzhaut** die innerste Schicht des Auges. Sie stammt aus der ersten Blase, der **primären Augenblase**, die sich zu einer kelchförmigen Struktur entwickelt. Die Netzhaut besteht aus zwei Schichten, einer inneren und einer äußeren, und hier kommt es zu einer **Netzhautablösung**.

15. NEURALLEISTEN

DAUER : 03:29

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video konzentriert sich auf die Bewegung der Neuralleiste, einen Schlüsselprozess in der Embryologie, der nach der Neurulation verschiedene Körperstrukturen hervorbringt. Es werden die Arten von Bewegungen untersucht, insbesondere prosencephale, mesencephale und rhombencephale, und erklärt, wie die Neuralleiste unser Verständnis der genetischen und metabolischen Interaktionen während der Embryonalentwicklung in Frage stellt. Indem Therapeuten lernen, Anzeichen in den Körperstrukturen, insbesondere im Gesicht, zu identifizieren, können sie den inneren Zustand der Patienten besser interpretieren. Das Video betont auch die Bedeutung von Zellwanderungen und Umwelteinflüssen bei der Gewebebildung, wobei die Rolle von Mikrogefäßen und Mikronerven hervorgehoben wird, um eine integrierte Sichtweise der biodynamischen Embryologie zu vermitteln.

BEWEGUNG DER NEURALLEISTE

Die **Bewegung der Neuralleiste** ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Arten von **Differenzierung** und **Induktionsfaktoren** beinhaltet. Diese Faktoren können **metabolisch** oder **passiv** sein und treten nach der **Neurulation** auf.

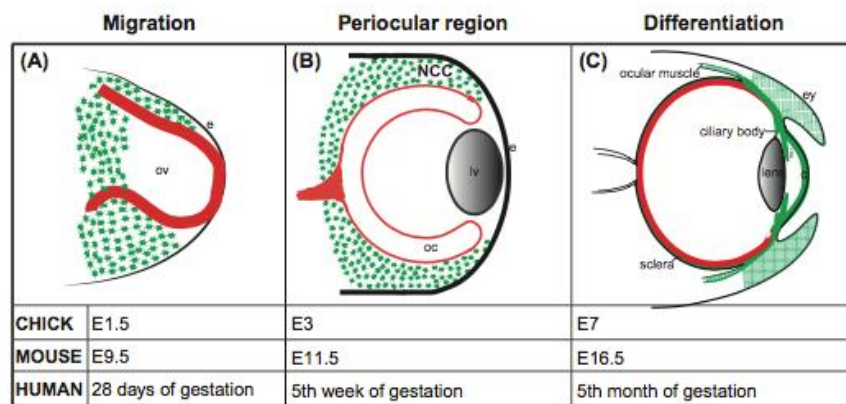


ABB. — Bewegung der Neuralleiste

Die **Blutgefäße** spielen eine entscheidende Rolle bei der Steuerung des Systems, während **genetische** Elemente auch die Ausrichtung der Zellen zu den entsprechenden Bereichen beeinflussen.

ARTEN VON BEWEGUNGEN

Man unterscheidet drei Haupttypen von Bewegungen:

- **Prosencephal**
- **Mesencephal**
- **Rhombencephal**

Beim **Verschluss des Neuralrohrs** entstehen die Zellen, die die Neuralleiste bilden werden. Diese Zellen werden verschiedene Prozesse im Körper hervorrufen und einen **Fluss** erzeugen, der sich von hinten nach vorne erstreckt und das gesamte **Gesicht** durchdringt. Das bedeutet, dass das Gesicht, die Knochen, die Haut bis zum **Platysma** von der Neuralleiste stammen.

Dieses Gewebe ist hochgradig **informiert** und **informierend**. Zum Beispiel stammt alles in Ihrem Bauch ebenfalls von der Neuralleiste. Die **Ganglien** und andere Strukturen spiegeln den inneren Zustand des Körpers wider und ermöglichen es, das **Gesicht zu lesen** anhand von Falten, Augenringen und Farben.

MIGRATION UND ENTWICKLUNG

Das **Prosencephal** entwickelt sich zum **Telencephalon** und **Diencephalon**, wobei eine signifikante Migration des Diencephalons stattfindet. Letzteres, sowie das **Diencephalon** und das vordere **Mesencephalon**, migrieren zur Neuralleiste. Dieser Fließprozess ist für die Entwicklung unerlässlich.

Vor dem Verschluss des Neuralrohrs liefern negative Einflüsse, wie die im Zusammenhang mit dem **hepatopankreatischen, thyreoidalen** und **kardialen System**, Informationen an die Neuralleiste, die auch als **Ektomesenchym** betrachtet wird. Letzteres ist eine Mischung aus **Mesoderm** und Neuralleiste.

BEDEUTUNG DER NEURALLEISTE

Die Neuralleiste spielt eine grundlegende Rolle bei der **Migration** und **Kolonisierung** und trägt zu spezifischen Merkmalen bei. Sie beeinflusst auch den Aufbau von **Mikrogefäßen** und **Mikronerven**, insbesondere der **Perizyten**.

Dieser Prozess ermöglicht die Schaffung von Stütz- und Austrittspunkten und liefert eine **embryonale Umgebungsenergie**, die die wachsenden Mikronerven umstrukturiert. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Interaktionen auf einer **elektrischen** Ebene stattfinden.

Im Bereich des Auges umhüllt und formt ein grüner Bereich das vordere Gewebe, das **Ektoderm** ist, in Bezug auf diesen mesodermalen Fluss, insbesondere um die **Sklera**.

16. DAS AUGE UND DIE ERINNERUNGEN

DAUER : 05:02

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video tauchen wir in die Konzepte der neuronalen und Gewebememorisierung ein und erläutern, wie unser Körper Erfahrungen speichert und welche Folgen dies für die körperliche Gesundheit hat, wenn diese Erinnerungen nicht integriert werden. Anhand konkreter Beispiele, wie den emotionalen Auswirkungen auf Kinder, untersuchen wir die entscheidende Rolle von Drüsen wie den Nebennieren und der Schilddrüse in diesem Prozess. Therapeutische Techniken wie die schnelle Augenbewegung (EMDR) und die Herzfrequenzkohärenz werden als Werkzeuge vorgestellt, um diese vergrabenen Erinnerungen zu behandeln und ein Gleichgewicht zwischen den kognitiv diskordanten Dimensionen unserer Existenz wiederherzustellen.

DAS AUGE UND DIE ERINNERUNGEN

Die **neuronale Speicherung** und die **gewebliche Speicherung** sind wesentliche Konzepte für das Verständnis, wie unser Körper Erfahrungen aufzeichnet. Es ist möglich, **Erinnerungen** in verschiedenen Körperteilen zu speichern, die vom Auge beeinflusst werden. Wenn diese Erinnerungen nicht integriert werden, können sie sich **somatisieren**. Mit anderen Worten, was nicht integriert ist, manifestiert sich physisch.

Jedes Mal, wenn ein Problem ungelöst bleibt, speichert der Körper es symbolisch, abhängig von verschiedenen **Räumen**: mineralisch, pflanzlich, tierisch oder menschlich. Diese Speicherung hängt auch von den **Timings**, den Prozessen der **Koordination** und der **Synchronizität** ab. Zum Beispiel kann ein dreijähriges Kind, das allein zu Hause gelassen wird, Panik empfinden und physische Symptome wie chronische Sinusitis entwickeln. Dieses Phänomen veranschaulicht, wie ein emotionales Problem sich in physischen Symptomen äußern kann.

Die **Nebennieren** spielen eine entscheidende Rolle in dieser Dynamik. Sie reagieren auf Stress, und wenn sie blockiert sind, kann dies zu Gesundheitsproblemen führen. Es ist wichtig, die Nebennieren zu entlasten, um die Symptome zu behandeln. Ebenso ist die **Schilddrüse** mit dem stimmlichen Ausdruck und der Kommunikation verbunden, besonders um das siebte Lebensjahr herum, wenn das Kind beginnt, sich zu behaupten.

Im Alter von zwölf Jahren manifestiert sich das **hypophysäre** Phänomen, das den Beginn der Pubertät und die Reifung der **Gonaden** markiert. Dieser hormonelle Prozess ist auch mit **Synchronizitätsräumen** verbunden.

Es gibt Menschen, die in der Zeit stecken bleiben und Kindheitserfahrungen wiedererleben können. Diese Erinnerungen können durch visuelle oder auditive Reize reaktiviert werden. Zur Behandlung dieser Erinnerungen werden Techniken wie die **Schnelle Augenbewegung (MDR)** eingesetzt. Diese Methode beseitigt das Trauma nicht, ermöglicht aber eine Dissoziation und Neuordnung der Erinnerungen.

Die Augenbewegungen helfen, das Gleichgewicht zwischen dem **Rationalen** und dem **Irrationalen** sowie zwischen dem **Intuitiven** und dem **Rationalen** wiederherzustellen. Ein Ungleichgewicht in diesen Bereichen kann zu hypophysären Problemen führen. Die Hypophyse spielt eine Schlüsselrolle bei der Informationsübertragung zwischen den verschiedenen Gehirnbereichen, insbesondere bei Augenbewegungen.

Der Traum und die Augenbewegungen sind daher wesentlich für die **Rationalisierung** und Neuordnung der erlebten Erfahrungen. Praktiken wie die **Herzkohärenz** können ebenfalls zu diesem Gleichgewicht beitragen.

17. DAS AUGE UND DIE BEWEGUNG DER KORTIKALISIERUNG

DAUER : 08:22

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video untersucht die dynamische Verbindung zwischen dem Auge und der Kortikalisierungsbewegung in der Gehirnentwicklung. Der Prozess der Kopf- und Halsbeugung wird ebenso untersucht wie die Reorganisation des Hirngewebes in Bezug auf Gesichts- und viszerale Strukturen. Das Auge wird als zentrale Akteurin in dieser Bewegung dargestellt, die die Bildung der Falx cerebri und des Tentorium cerebelli beeinflusst und gleichzeitig psychische und emotionale Aspekte durch ihre Verbindung zum Hormonsystem integriert. Die Konzepte des Gleichgewichtsdiaphragmas und des terminalen Fulkrums werden eingeführt, wobei die Bedeutung der Stabilisierung der Kreuznaht für die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Augen und die Förderung der körperlichen Harmonie hervorgehoben wird. Diese Lektion bietet praktische und theoretische Schlüssel für Praktiker, die die embryologische Entwicklung und ihre therapeutischen Implikationen besser verstehen möchten.

DAS AUGE UND DIE KORTIKALISATIONSBEWEGUNG

Das **Gehirn**, ursprünglich als flaches Gewebe wahrgenommen, durchläuft im Laufe seiner Entwicklung eine signifikante Transformation. Stellen Sie sich eine Person vor, die auf einem Tisch liegt, mit ihrem Gehirn in der Hand. Die erste Information, die man sich merken sollte, ist die der **Expansion** und der **Bildung des Neuralrohrs**.

Dieser Prozess beginnt mit einer **cephalen Flexionsbewegung**, gefolgt von einer **zervikalen Flexion**, dann einer **pontinen** Entwicklung und einem **Telencephalie**-Prozess. Während sich das Gehirn aufrichtet, folgen die kleinen Strukturen dieser Entwicklung, was auf eine Richtungsänderung hinweist.

Das **Auge** enthält in seiner Entwicklungsspirale die Information der **Kortikalisation**. Bei dieser Aufrichtung reorganisiert sich das gesamte Gewebe in einer Rotationsbewegung und nähert sich der **Mittellinie**. Unten zieht das Gewebe zum Herzen und zum Verdauungssystem, während es sich oben aufrichtet. Diese Bewegung wird durch den **Aufstieg des Gehirns** und den **Abstieg des kardio-viszeralen Systems** erzeugt.

Das Auge spielt eine entscheidende Rolle bei diesem Phänomen der **Kortikalisierung** und trägt zur Entwicklung der **Falx cerebri** und des **Tentorium cerebelli** bei, das sich an den Processus clinoidei ansetzt. In der Nähe befindet sich das **Chiasma opticum**, ein wesentliches Element, das berücksichtigt werden muss.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das **Gleichgewichtsdiaphragma** und die **Tonon-Kapsel**, die das Auge mit dem gesamten Gesichtssystem und allen Faszien des Körpers verbindet. Dies bedeutet, dass das Auge eine integrale **Einheit** darstellt, die alle Gesichtsinformationen enthält. Es empfängt auch emotionale und psychische Informationen, die durch hormonelle Substanzen vermittelt werden. Somit ist der psychische Zustand untrennbar mit einem hormonellen und emotionalen Zustand verbunden.

Das Auge zu behandeln bedeutet also, die Entwicklung sowohl **peritoneal**, **peripher** als auch **kortikal** anzugehen. Das Auge steht in Beziehung zur Gesamtheit des Körpers in seiner Expression und Entwicklung. Jedes Organ hat seinen eigenen Standpunkt, und jedes Organ ist ein Symbol.

Um den **26. Tag** herum erscheint eine **Augenfurche**, die mit einer internen Verbindung zusammenhängt. Diese Furche wird durch eine Vesikel stimuliert, die die oberflächliche Wand berührt. Die cephalische und zervikale Flexion führt zu einer Begegnung zwischen Gehirn und Herz, wobei sich das Auge auf dem Herzen ablegt. Dies erzeugt eine **hintere Falte**, bekannt als **pontine Krümmung**, wo sich das Sakrum und das Tentorium cerebelli befinden.

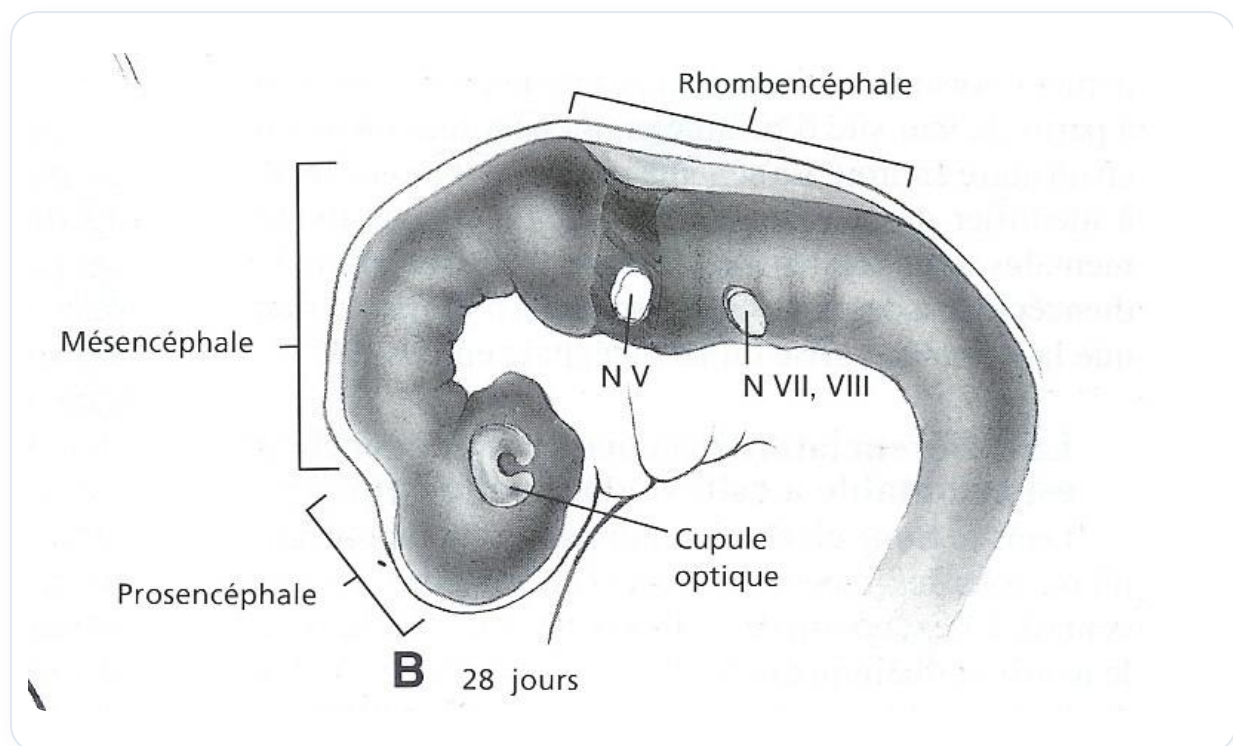


ABB. — Augenfurche und Blase

Das **Tentorium cerebelli** ist von größter Bedeutung, da es Synchronizitäten mit dem Peritoneum und dem Gehirn herstellt. Die **submesenzephalie Flexur** steht in Beziehung zur Spitze der **Chorda dorsalis** und dient als Stützpunkt. Das **Supraocciput** ist ebenfalls mit der zervikalen

Flexion verbunden, während die pontine Flexur mit der Schädelbasis assoziiert ist.

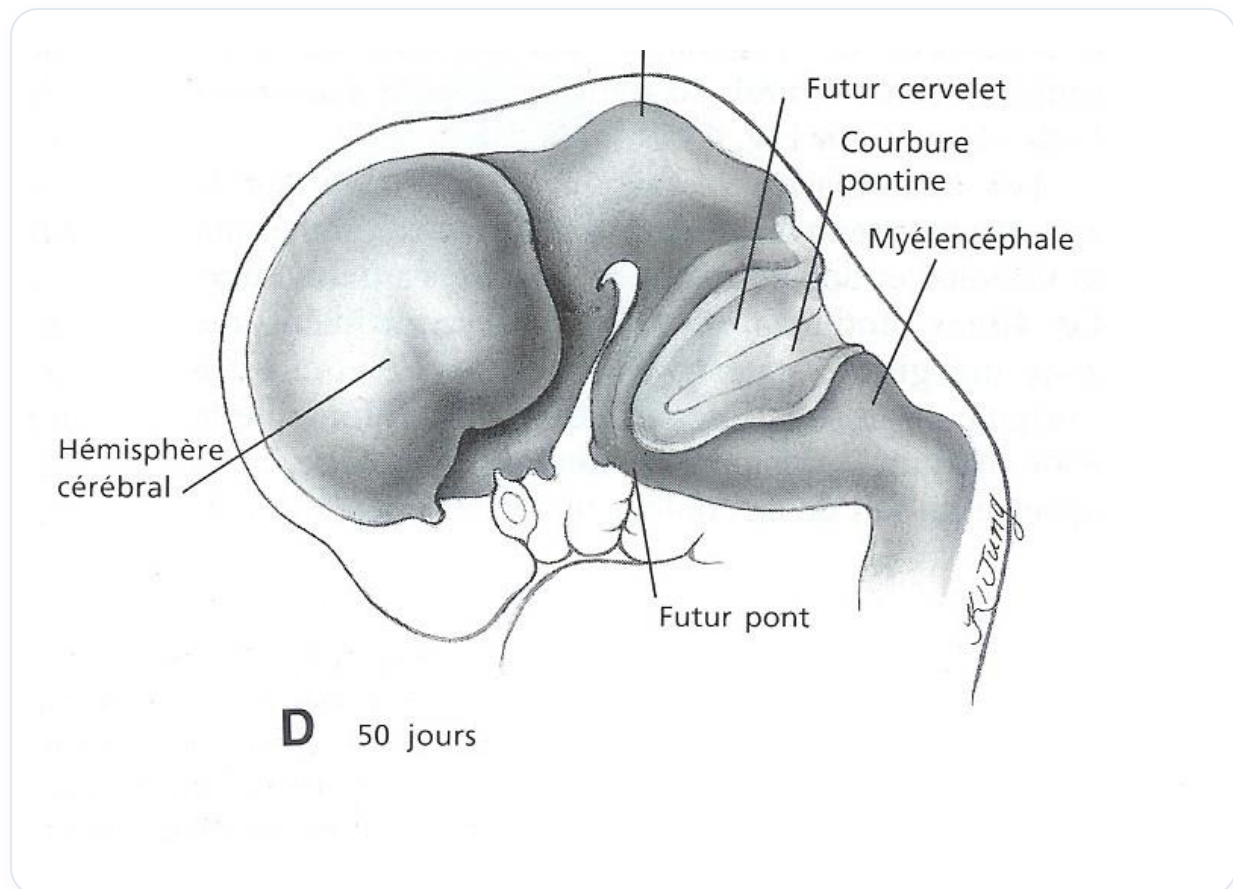


ABB. — Begegnung von Gehirn und Herz

Der Aufstieg des Neuralrohrs beeinflusst die Entwicklung des Verdauungs- und Herzsystems sowie anderer Entwicklungsräume. Die **Kolokalitäten** und **Synchronizitäten** während der Morphogenese helfen, die Stützpunkte zu verstehen. Der Aufstieg des **Ektoderms** und der Abstieg des **Endoderms** sind wesentlich für die Integration des Gehirns.

Das Auge folgt dieser Entwicklungsphase und nähert sich der Mittellinie, um die **Crista galli** zu bilden, die die Membranen vereint, um die Falx cerebri zu schaffen. Das Tentorium cerebelli entwickelt sich ebenfalls während des Pontisationsphänomens.

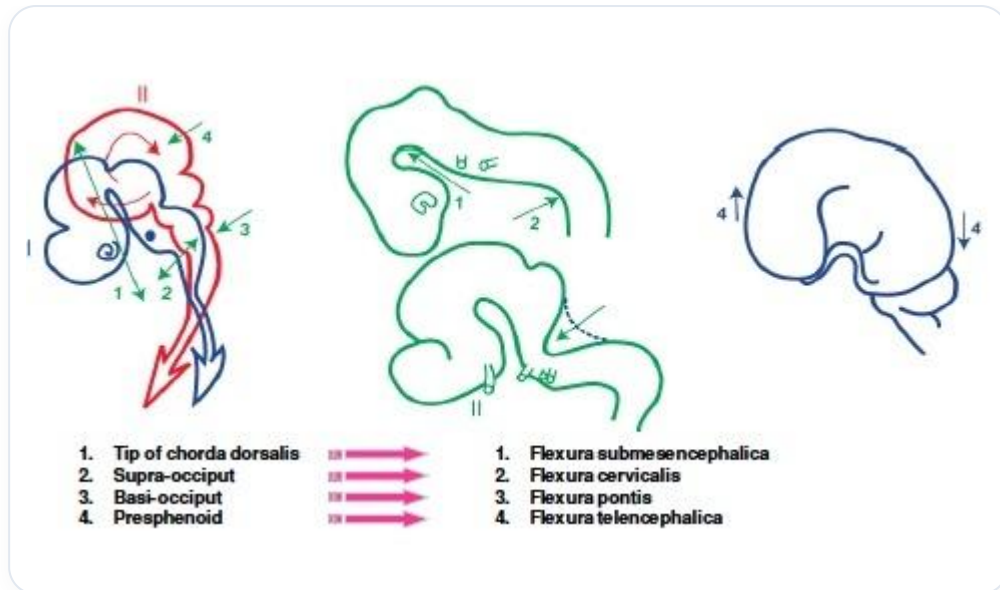


ABB. — Stützpunkte

Es ist entscheidend zu beachten, dass der Stützpunkt oder **terminale Fulcrum** der Augenpositionierung wesentlich ist. Um die Augen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wird empfohlen, einen Finger in den Mund zu legen, auf Höhe der kleinen **kreuzförmigen Naht**. Dies ermöglicht es den beiden Augen, ihren Raum zu finden, wenn sich diese Naht stabilisiert.

Der **Stirnrand**, der **Jochbeinrand** und der **Oberkieferrand** sind wichtige Stützpunkte. Das Auf- und Absteigen der Strukturen trägt zur Schließung der Mittellinie bei, was auch mit der Gaumenschließung zusammenhängt. Wenn der Gaumen seinen Stützpunkt findet, finden auch die Augen ihren Platz, was einen **Ankunftsfulcrum** in der Entwicklung markiert.

18. ANMERKUNG: SCHLEUDERTRAUMA

DAUER : 01:12

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht den Einfluss von Augenspannungen auf die kraniale und emotionale Entwicklung. Es beleuchtet das Konzept des Ascensus als Methode zum Ausgleich von augenbedingten Spannungen und zeigt die Verbindungen zwischen dem Zustand der Augäpfel, Emotionen und der psychischen Gesundheit auf. Sie erfahren, wie diese Spannungen Ungleichgewichte im Nervensystem widerspiegeln können und wie sie mit körperlichen Manifestationen wie Torsionen und Dissoziationen zusammenhängen können. Durch die Untersuchung dieser Aspekte ebnet dieses Video den Weg zu einem besseren Verständnis der Gehirn- und Schädelentwicklung und bietet somit einen wertvollen Ansatz für Therapeuten und Studenten der Osteopathie und biodynamischen Embryologie.

AUGENSPANNUNGEN UND IHR EINFLUSS AUF DIE SCHÄDELENTWICKLUNG

Das **Gehirn** kann von verschiedenen Arten von **Spannungen** betroffen sein, die sich in den **Augen** manifestieren. Diese Spannungen können durch einen Prozess des **Ascensus** wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Obwohl dies komplex erscheinen mag, ist es wichtig zu verstehen, dass unser Gedächtnis und unsere Emotionen sich durch unseren Körper ausdrücken, insbesondere in der **Zone B**.

Wenn wir von **Ascensus** und **Descensus** sprechen, ist es wichtig zu beachten, dass einige Personen sehr eingefallene **Augäpfel** aufweisen, was mit depressiven Zuständen oder einer schlechten Verbindung zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte verbunden sein kann. Diese Manifestationen können auch mit erheblichen **Torsionen** und **Dissoziationen** zusammenhängen.

Die Augen spielen eine außergewöhnliche Rolle bei der Ausdrucksweise unseres emotionalen und physischen Zustands. Sie spiegeln die Position und den Zustand unseres **Nervensystems** wider. Darüber hinaus besteht eine signifikante Beziehung zwischen der Entwicklung des **Schädels** und der Augen.

Indem wir das Auge untersuchen, können wir die Entwicklung des Gehirns und damit die Schädelentwicklung besser verstehen.

19. KRAFTLINIEN UND ELEKTRIZITÄT

DAUER : 03:44

LEHRBLATT

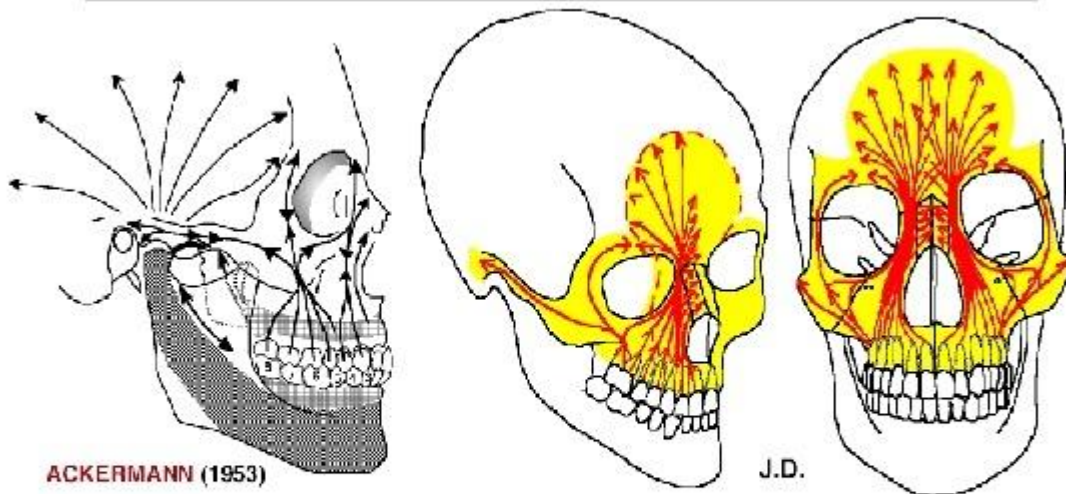
KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht den Einfluss von Kraftlinien und elektrischen Ladungen auf die Knochenstruktur und Bewegung. Die Dozenten erklären, wie das Auge als Former eine entscheidende Rolle bei der Knochenbildung spielt, und betonen gleichzeitig die Gegenbewegungen und die Cephalisation, die als Reaktion auf elektromagnetische Ladungen auftreten. Die Trägerkomplexe, einschließlich des frontalen canino-nasalen Trägers und der frontalen maxillären Linie, werden mit relevanten anatomischen Details vorgestellt. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Spürens von Frequenzschwankungen und des Gleichgewichts zwischen der linken und rechten Körperseite hervorgehoben, was den Weg für effektive Anpassungen zur Behandlung von Mikroverletzungen und zur Verbesserung der Körperdynamik ebnet. Praktiker lernen auch, die Auswirkungen der Augenachsen auf das allgemeine Körpergleichgewicht zu beurteilen, um ihre therapeutischen Interventionen zu optimieren.

KRAFTLINIEN UND ELEKTRIZITÄT

Die **Kraftlinien** werden durch die Ladung der **Elektronen** auf der konvexen Seite im positiven Bereich gebildet, wodurch Ladungen im Knochen entstehen. Dies wirkt sich auf tiefer liegende Kraftlinien aus, die als **Balken** bezeichnet werden und eine entscheidende Rolle in der Knochenstruktur spielen.

Effets des Forces Piézo-électriques à la Face supérieure



ACKERMANN (1953)

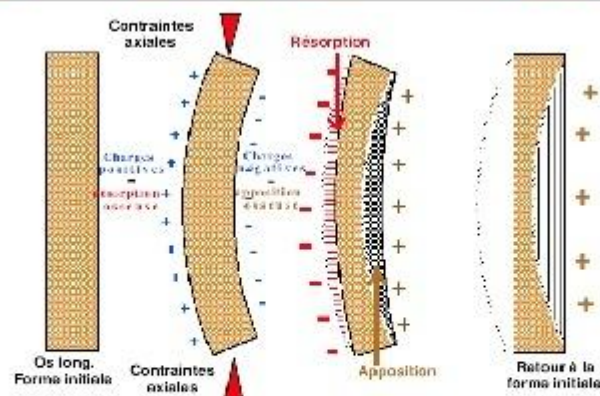
J.D.

Les **forces occlusales antéro-latérales**, les pressions du massif lingual, et les effets piézo-électriques qui en résultent, déterminent la formation de travées osseuses, contribuant au **développement des parties antérieures du "Complexe Maxillaire" et du Frontal**.

Les **forces postéro-latérales** passent par l'apophyse zygomatique et **s'étendent aux os Temporaux**.

ABB. — Elektrische Aufladung des Knochens

Effets de la piézo-électricité sur les pièces osseuses



Selon BASSET, FROST, EPKER: "**Les contraintes axiales** provoquant la courbure d'un os déterminent l'apparition de charges électriques positives du côté convexe, et inversement. Les ions calcium (+), attirés par les charges négatives s'accumulent dans la concavité; c'est l'inverse du côté convexe."

ABB. — Erzeugung von Ladungen auf dem Knochen

Das Auge fungiert als **Konformator** und beeinflusst die Knochenbildung, die sich um es herum aufbaut. Bei dieser Abwärtsbewegung führt der Knochen eine **Gegenbewegung** aus. Letztere ist mit der **Kephalisation** verbunden, wobei der Knochen eine **Gegenrotation** aufweist. Ein besonders interessanter Balken ist der **canino-nasal-frontale Balken**, der sich kontralateral entwickelt.

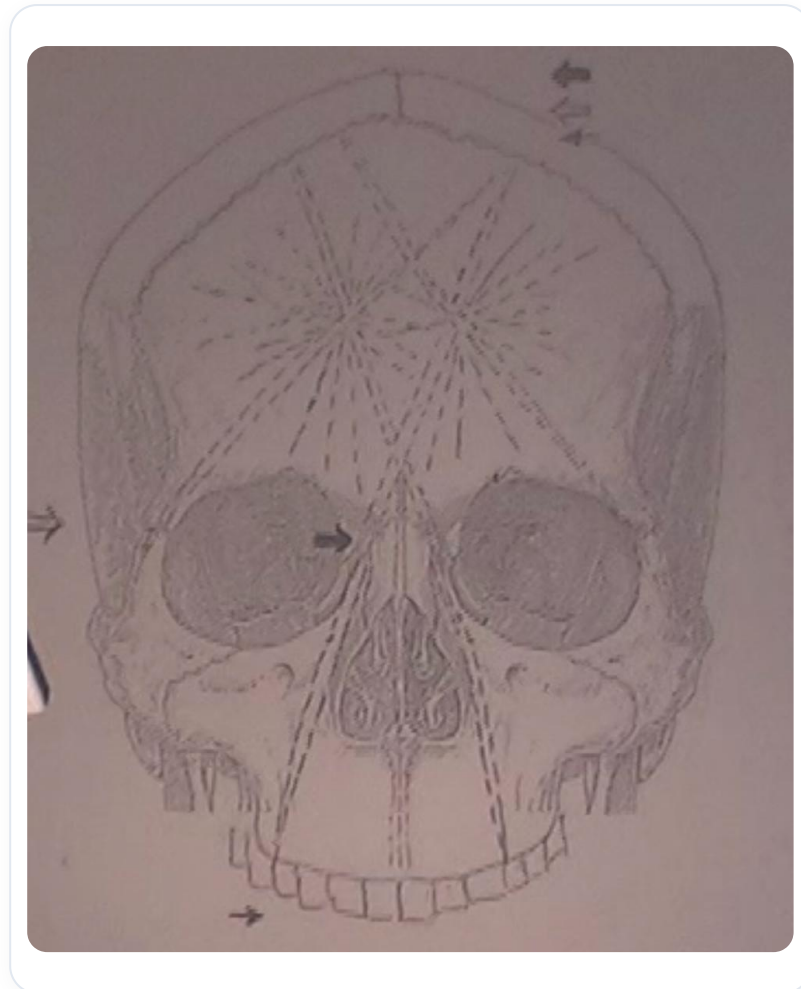


ABB. — *Lignes de force (poutres)*

An der Schädelbasis sind ebenfalls Kraftlinien vorhanden, die die Hauptachsen dieser Region darstellen. Im Gesichtsbereich erstreckt sich eine Kraftlinie vom Eckzahn bis zum **Stirnhöcker** und der **Kranznaht**. Manchmal bilden sich kleine **Mikroläsionen** an der Kranznaht, die zu bemerkenswerten Veränderungen führen. Zum Beispiel kann ein Zahn eine Fasenänderung aufweisen, und eine Anpassung kann eine signifikante **elektrische Veränderung** hervorrufen.

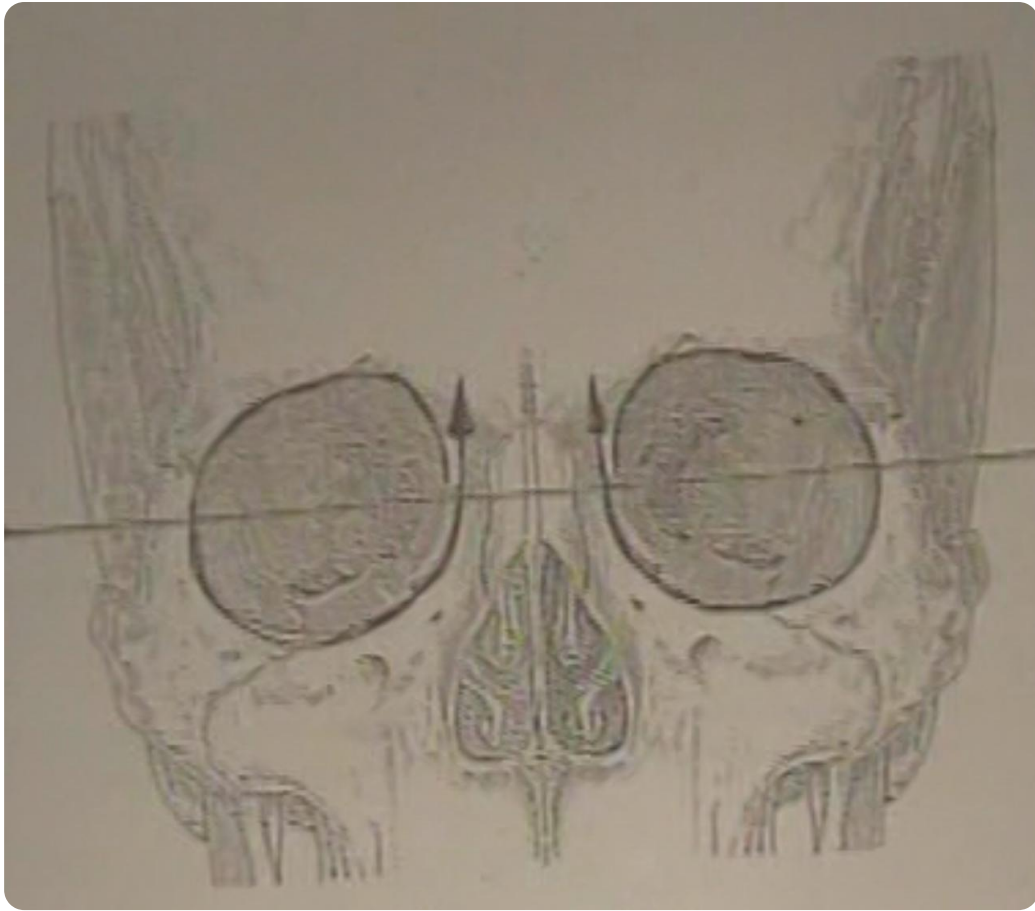


ABB. — Frontaler canino-nasaler Balken

Es ist unerlässlich, an der **Frequenz** dieser Kraftlinien zu arbeiten und die Variationen von links nach rechts zu erspüren, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das Verständnis der **Synchronizitäten** ist ebenfalls entscheidend, da das, was auf einer Ebene bearbeitet wird, Auswirkungen auf einer anderen Ebene haben kann.

Eine weitere interessante Kraftlinie ist die **maxillär-frontale Linie**, die auf der Höhe des Ingus verläuft. Darüber hinaus ist die **Jochbeinlinie** zu beachten, die dieselbe Seite im Stirnbereich und die gegenüberliegende Seite im Bereich der Kranznaht verbindet.

Schließlich ist es im Bereich des Auges und der Augenhöhle wichtig, die Achsen des Auges hinzuzufügen, um deren Gleichgewicht zu beurteilen. Es können Veränderungen auftreten, die eine besondere Aufmerksamkeit auf diese Strukturen erfordern.

20. DAS AUGE UND DIE SCHÄDELENTWICKLUNG

DAUER : 04:35

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video werden die komplexen Zusammenhänge zwischen der Entwicklung des Auges und der Schädelbildung detailliert untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf embryologischen Prozessen, wie der primitiven Kopfbeugung und deren Auswirkungen auf die Knochenstruktur, insbesondere auf die zentrale Rolle des Keilbeins für die Stabilität des Auges. Die Konzepte des Kopf-Wachstums und des Orbita-Spasmus werden behandelt, wobei die Bedeutung der Harmonie zwischen Auge, Nase und Gaumenbildung hervorgehoben wird. Darüber hinaus veranschaulicht das Video die Entwicklungsspiralen, die die Schädelstruktur beeinflussen, und deren Auswirkungen auf die Sehfunktion, wodurch praktische Werkzeuge für Studenten und Therapeuten bereitgestellt werden, die ihr Verständnis in Osteopathie und biodynamischer Embryologie vertiefen möchten.

DAS AUGE UND DIE SCHÄDELENTWICKLUNG

Die Entwicklung des **Auges** ist eng mit der Bildung des **Schädels** verbunden. Während der **primitiven Kopfbeugung** wird das **submesenzepale Mesenchym** zwischen dem vorderen und hinteren Teil der **Gehirnblase** komprimiert. Dieser Prozess führt zu einem Wasserverlust und einer Umwandlung des Mesenchyms in **Knorpelgewebe**, wodurch die Schädelbasis gebildet wird.

Oben befindet sich das **Siebbein**, gefolgt vom **Keilbeinkörper** und dann dem **Pars basilaris des Hinterhauptbeins**. Die **Keilbeinflügel** spielen eine entscheidende Rolle als Stützpunkt für das Auge. Letzteres wird vom Keilbein gestützt, das seine **Stabilität** gewährleistet. Während der Schädel wächst, entwickelt sich das Knochengewebe des Auges als Reaktion auf das Wachstum des **Gehirns**, prägt sich um das Auge herum ein und schließt sich mit spezifischen Kraftlinien.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Auge und Schädel miteinander verbunden sind. Ein leichter Stoß kann die **Orbita** destabilisieren und die visuelle **Reflexion** beeinträchtigen. Daher ist es entscheidend, die Stabilität des Auges wiederherzustellen, sowohl über das Gehirn als auch über den Schädel.

Während sich die Nase entwickelt, erscheint das Auge seitlich. Gleichzeitig bildet sich der **Gaumen**. Der Verschluss des **Gaumenbeins** fällt mit der Ausrichtung des Auges in seinen vertikalen und horizontalen Achsen zusammen und markiert einen wichtigen Endpunkt in der

Knochenentwicklung.

Das Kopfwachstum ist von größter Bedeutung. In diesem Moment nähern sich die Augen der **Mittellinie**. Ein Stützpunkt bildet sich auf Höhe des **Nasion**. Mit fortschreitender kortikaler Entwicklung richtet sich das Auge in seine endgültige Position aus.

Man beobachtet zwei Spiralen: eine Augenspirale und eine knöcherne Gegenspirale, sichtbar in der Form der Schädel**nähte**. Die Ausrichtung dieser Nähte ist wesentlich für die Untersuchung der Dreidimensionalität des **Prämaxillare**, das eine komplexe Form aufweist und zur orbitalen und okularen Struktur beiträgt.

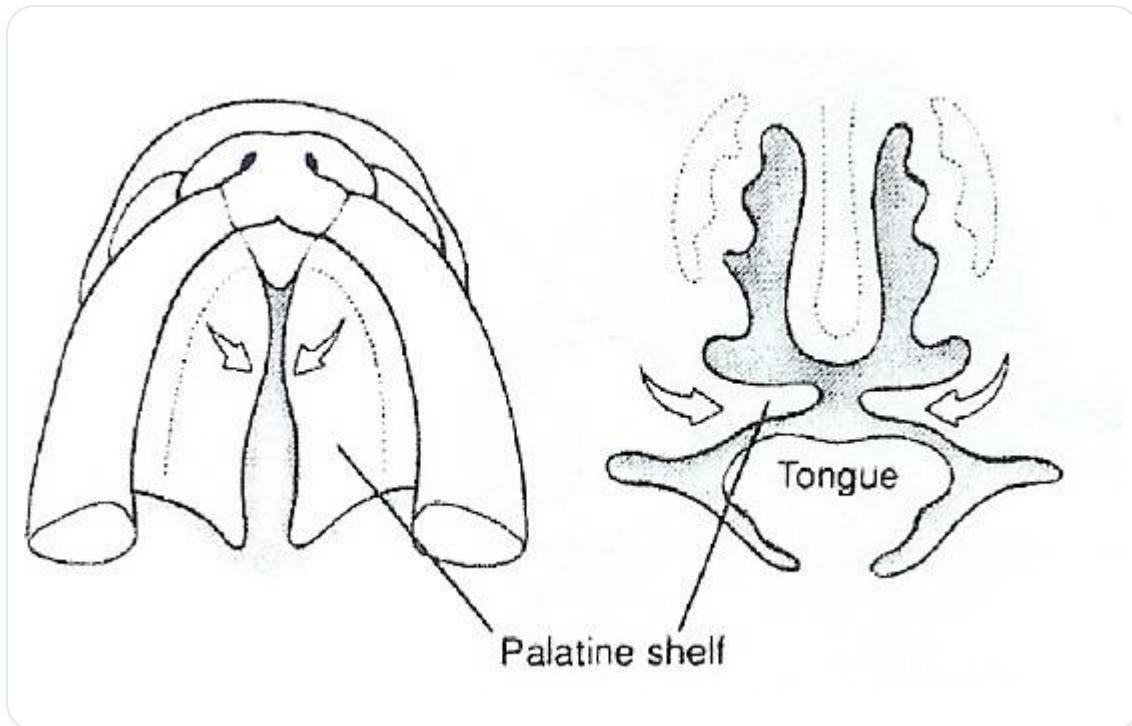


ABB. — Erläuterndes Schema

21. DAS LIGAMENTUM LILIEQUIST

DAUER : 07:37

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der Anatomie und den Mechanismen des Ligamentum Liliequist, einer wesentlichen Struktur, die als Diaphragma auf der Höhe des dritten Ventrikels fungiert. Es wird erläutert, wie dieses Band mit dem Nervus oculomotorius und dem Basilaris interagiert und so das ventrikuläre System und die Hypophyse beeinflusst. Die Konzepte von Membranspannungen, Achsen der Schädelbewegung und deren Auswirkungen auf das Gesichts- und Hormonsystem werden behandelt, wobei die Bedeutung der kranio-sternalen und mandibulären Bewegungen hervorgehoben wird. Die Analyse von Spannungen kann auch bei der Diagnose von okklusalen Dysfunktionen helfen und therapeutische Schlüssel zur Wiederherstellung der körperlichen Harmonie bieten.

DAS LILIEQUIST-LIGAMENT: ANATOMIE UND MECHANISMEN

Das **Liliequist-Ligament** ist eine anatomische Struktur, die wie ein kleines Diaphragma wirkt und gemeinhin als **Liliequist-Membran** bezeichnet wird. Dieses Ligament setzt am **dritten Ventrikel** an und reicht bis zum **Keilbein** hinab. Dort spielt es eine entscheidende Rolle in Bezug auf den **Nervus oculomotorius** und den arteriellen Durchgang, insbesondere den **Basilarisstamm**, der für die Bildung der **Hirnarterien** verantwortlich ist.

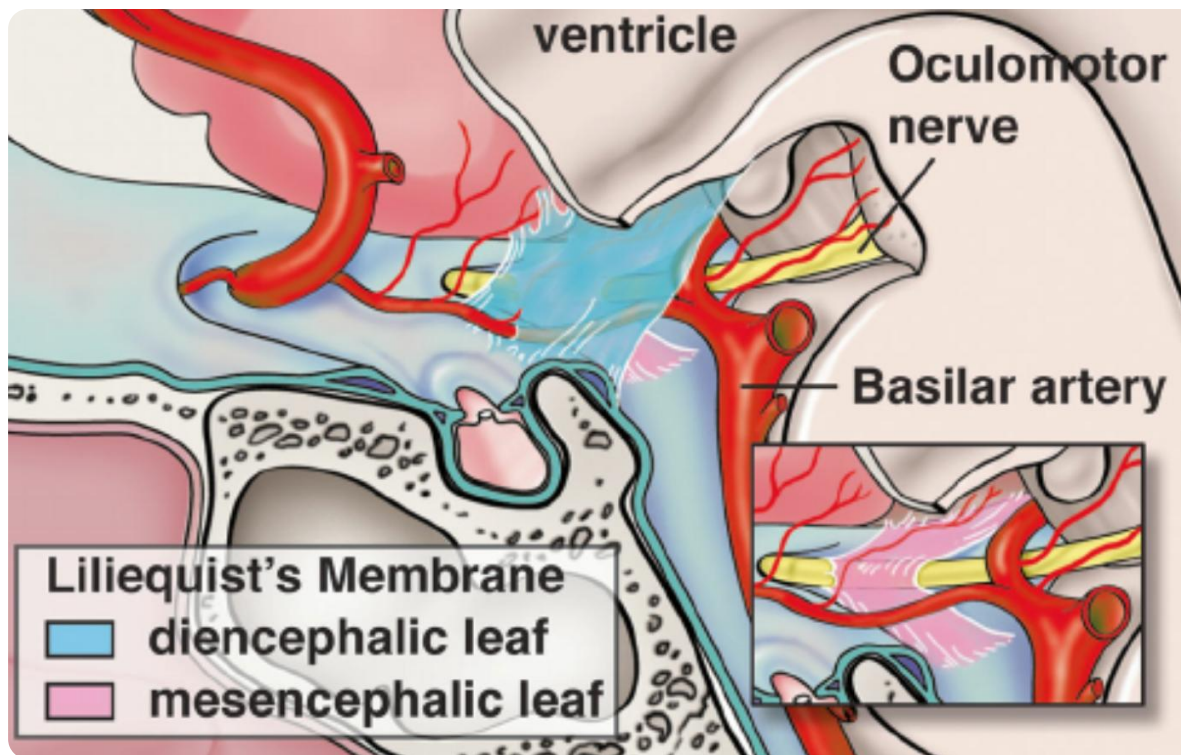


ABB. — Liliequist-Band

Wenn das Ligament herabsteigt, erzeugt es eine **Spannungsachse**, die das **ventrikuläre System** beeinflusst. Der dritte Ventrikel, der vierte Ventrikel sowie die **Seitenventrikel** sind alle durch diese Dynamik miteinander verbunden. Es entsteht ein Spannungsmuster, das einen signifikanten Einfluss auf den Raum hat, in dem sich die **Hypophyse** befindet.

Oberhalb der Hypophyse befindet sich das **Chiasma opticum**, das um etwa 30 Grad ausgerichtet ist, mit einer posturalen Bewegung von 5 Grad. Diese Bewegung ist essenziell für die **Drainage** zwischen dem dritten Ventrikel, dem Keilbein und den umgebenden **Mikrogefäßen**. Die in den Mikrokapillaren vorhandenen **Perizyten** interagieren mit den Nerven und bilden **Blut-Hirn-Schranken-Räume**, die als tiefer Stützpunkt dienen.

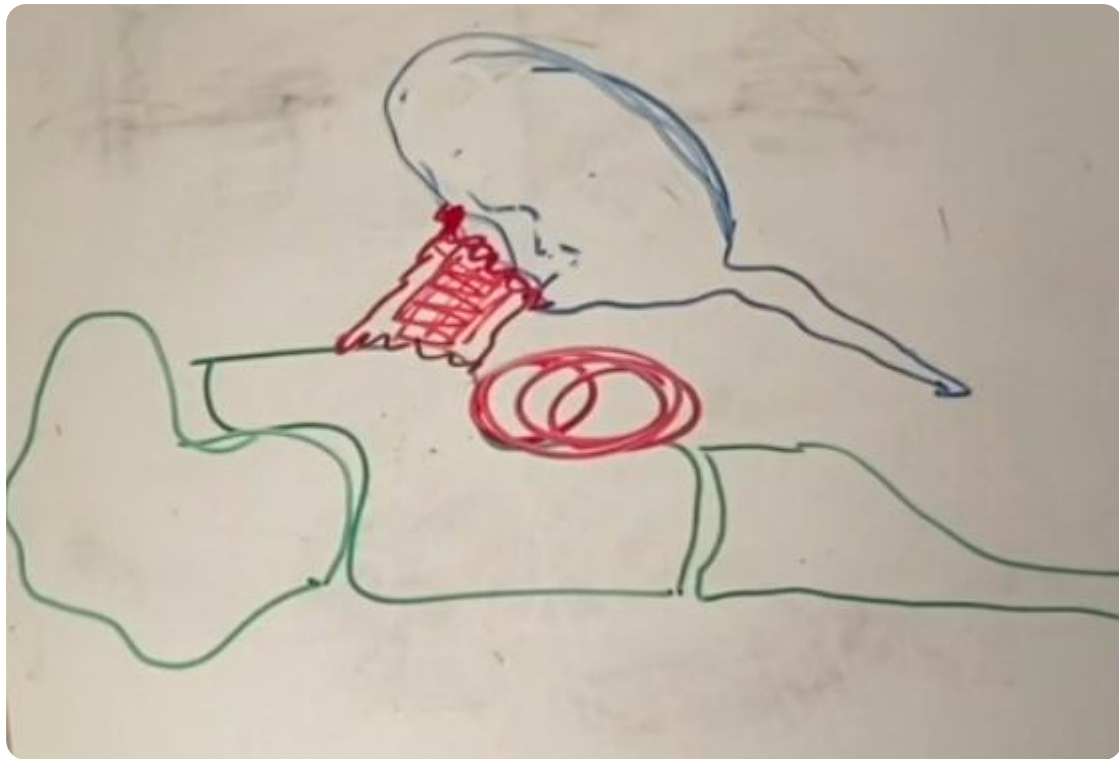


ABB. — Ventrikelsystem

Bei der Untersuchung der **Präspinoide**, die dem **Hinterhaupt** entsprechen, beobachtet man einen Gleichgewichtsraum auf der Lilliequist-Membran. Diese membranöse Spannung beeinflusst sowohl die Nerven als auch die Blutgefäße und befindet sich in der Nähe der Hypophyse, wo das Nervensystem über die **hypothalamisch-hypophysär-thyreoidal-adrenal-gonadale Achse** mit dem Hormonsystem kommuniziert.

Die kraniale Bewegung ist ebenfalls wichtig zu berücksichtigen. Bei der Betrachtung eines Schädels kann man die verschiedenen Bewegungen an den **Parietalen** und anderen Strukturen feststellen. Diese Bewegungen folgen spezifischen Kraftlinien. Zum Beispiel stellt die **Flexionsbewegung** im Stirnbereich, verbunden mit der **Sutura metopica**, zwei Gleichgewichtspunkte dar, die die Augenbewegung beeinflussen.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass das **Gehirn** das **ventrikuläre System** und das **Gesichtssystem** sowohl auf der Ebene des **Chondrocraniums** (Knorpel) als auch des **Desmocraniums** (Membran) konditioniert. Während der Entwicklung, wenn das **Hinterhaupt** herabsteigt, steigt auch das **Kreuzbein** herab, und die **Schläfenbeine** spielen eine Schlüsselrolle in dieser Dynamik.

Das **Brustbein** steigt als Reaktion auf diese Bewegungen auf und konvergiert zur vorderen Mittellinie. All dies ist im Auge eingeschrieben, und es ist unerlässlich, Elemente bezüglich des Gesichtssystems und des Kapselsystems des Auges hinzuzufügen, die sich um das Ganze herum einfügen und es mit einer Gegenrotation bei der Entwicklung der Orbita organisieren.

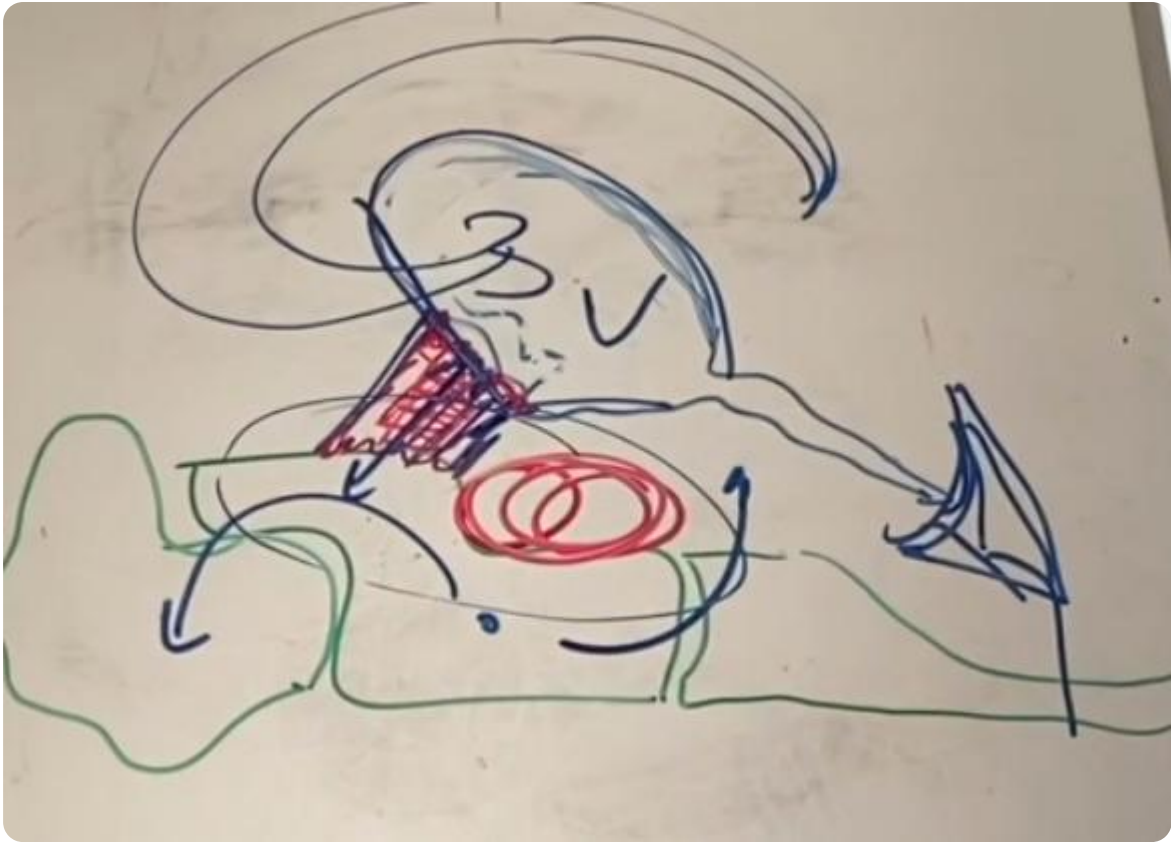


ABB. — Kopf-Bewegungen

Die kranio-sterno-sakralen und mandibulären Bewegungen sind miteinander verbunden. Die Eckzahnachsen sind ebenfalls wichtig, da sie die **Okklusion** beeinflussen. Wenn die obere und untere Eckzahnbegegnung nicht korrekt ist, führt dies zu einem Informationsverlust im Gehirn, da diese elektrischen Felder sich vereinigen müssen.

Die **Okklusion** ist somit ein Spiegelbild der Spannungen, die auf der **Symphysis sphenobasilaris** vorhanden sind. Durch die Beobachtung der Zähne ist es möglich, das Vorhandensein von **Strain** (Spannung) zu bestimmen, sei es vertikal, lateral oder anders. Dies ermöglicht es, die Belastungen zu verstehen und die notwendigen Behandlungen anzupassen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.

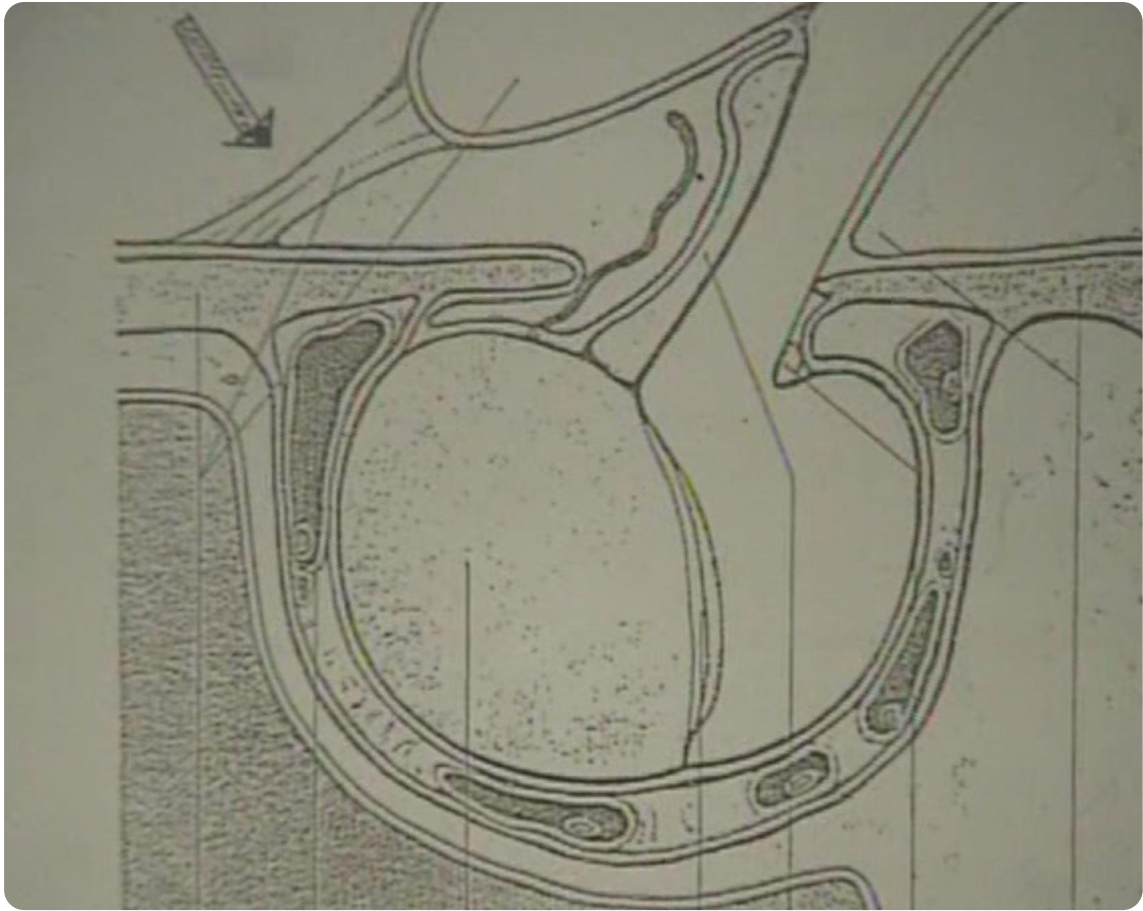


ABB. — *Koordinierte Bewegungen von Schädel, Sternum und Sakrum*

22. PRAXIS: DIE KRAFTLINIEN

DAUER : 08:41

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video tauchen wir in die Untersuchung der Kraftlinien durch die koronale Duralscheide, die Symphyse und den Oberkiefer ein, wobei wir einen elektrischen Ansatz verfolgen, um Sehnen und Sehnenentzündungen effektiv zu behandeln. Die Verbindungen zwischen Neurokranium und Viszerokranium werden erforscht, wobei die Bedeutung der Koronarnaht und ihre Rolle für die Vitalität des Körpers hervorgehoben werden. Die Teilnehmer lernen, Energieverluste zu palpieren und zu erkennen, an Herz- und Endothelsystemen zu arbeiten und Induktionstechniken einzusetzen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese Sitzung lehrt, wie die verschiedenen Strukturen harmonisiert werden können, um die Energiezirkulation zu verbessern und das Wohlbefinden des Patienten zu fördern.

PRAXIS: DIE KRAFTLINIEN

In dieser Sitzung werden wir die **Kraftlinien** in Bezug auf die **koronale Duralscheide**, die **Symphyse** und den **Oberkiefer** untersuchen. Es ist unerlässlich, sich auf eine **elektrische Ebene** zu begeben, um zu verstehen, wie diese Felder interagieren. Dieser Ansatz ist auch auf die Behandlung von **Sehnen** und **Sehnenentzündungen** anwendbar.

VERBINDUNG ZWISCHEN NEUROCRANIUM UND VISCEROCRANIUM

Die Etablierung der Schädelbasis, die das **Neurocranium** und das **Viscerocranium** umfasst, ist entscheidend. Man kann sich vorstellen, dass das gesamte viszerale System an der Schädelbasis gestützt wird, während sich das Gehirn darüber befindet. Die **Duramembranen** der Spannung heften sich an diese Basis und bilden ein komplexes Netzwerk.

Wir beginnen mit der **Kranznaht** und dem Teil des **Oberkiefers**. Indem man sich auf die **maxillo-zygomatischer** Ebene begibt, kann man beobachten, wie sich die Kraftlinien treffen. Diese Verbindungen müssen in Harmonie sein, wie sich ausrichtende **Ringe**.

BEDEUTUNG VON VITALITÄT UND ENERGIE

Es ist wichtig zu beachten, dass die Kranznaht relativ niedrig liegt, und es ist unerlässlich, an diesem Bereich zu arbeiten, insbesondere an der Stelle von **Bregma**. Vitalität ist mit dem Wärmeaustausch verbunden, und eine empfundene Wärme weist auf eine gute

Energiezirkulation hin.

Durch das Abtasten dieses Bereichs können **Energieverlustpunkte** erkannt werden. Durch die Verbindung mit diesen Bereichen kann ein Unterschied in der Vitalität beobachtet werden, was auf Müdigkeit oder einen Kampf auf der Ebene der **Nebennieren** hinweisen kann. Es ist daher entscheidend, diese Bereiche **aufzuladen**, um den Allgemeinzustand des Patienten zu verbessern.

ENERGETISCHER ANSATZ UND VERBUNDENE SYSTEME

Während der Konsultation ist es möglich, an den **Herz-** und **Endothelsystemen** zu arbeiten. Vier Eingangstore sind zu berücksichtigen: die **inneren Halsschlagadern** und die **Wirbelarterien** sowie das **Basilarissystem**. Durch korrektes Berühren dieser Bereiche können Spannungen gelöst und die Durchblutung zum Herzen verbessert werden.

Wir nutzen verschiedene Energien, insbesondere die der **Schwerkraft** und der **Gravitation**, um einen gerechten Kontakt wiederherzustellen. Manche Patienten können zu schwer oder zu leicht sein, was ihr energetisches Gleichgewicht beeinflusst.

PALPATIONS- UND INDUKTIONSTECHNIKEN

Durch das Abtasten der **Kranznaht** können Wärme- und Vibrationsschwankungen wahrgenommen werden, was auf ein gutes Gleichgewicht hinweist. Durch die Arbeit an der **Stirnbeule** und der Linie **Jochbein-Stirnbeule** können Ungleichgewichtsbereiche identifiziert werden.

Es ist unerlässlich, die Atmung des Patienten während dieser Manipulationen zu beobachten. Durch den Einsatz von **Induktions-** oder **erleichterten Bewegungstechniken** kann der Körper in seinen natürlichen Bewegungen begleitet werden. Die Beobachtung der **expiratorischen** Aktivität kann auch Polaritätsänderungen aufzeigen, die auf einen **Redoxprozess** hinweisen.

FAZIT

Diese Techniken ermöglichen es, das energetische Gleichgewicht wiederherzustellen und die Heilung zu fördern. Durch die Arbeit an den Kraftlinien und die Herstellung von Verbindungen zwischen den verschiedenen Strukturen können wir die Vitalität und das Wohlbefinden des Patienten verbessern.

23. ANATOMIE DER

DAUER : 21:58

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine eingehende Untersuchung der Anatomie des Auges und des Neurokraniums, wobei die Beziehungen zwischen den verschiedenen Strukturen wie Neurokranium, Viszerokranium und deren integrierten Funktionen erläutert werden. Sie lernen die Schlüsselmerkmale der Augenhäute kennen, insbesondere die Sklera, die Uvea und die Netzhaut, sowie die Bedeutung der Augenmuskeln und ihrer Innervation. Die Diskussion umfasst auch die komplexe Vaskularisation des Auges, die für die Erhaltung seiner Gesundheit unerlässlich ist. Dieses Wissen ist für Angehörige der Gesundheitsberufe, insbesondere Osteopathen, von entscheidender Bedeutung, die die anatomischen Grundlagen des Sehens und deren Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit besser verstehen möchten.

ANATOMIE DES AUGES UND DES NEUROKRANIUMS

Die Anatomie des Auges und des Neurokraniums ist ein faszinierendes Thema, das ein tiefgreifendes Verständnis der Strukturen und ihrer Funktion erfordert.

NEUROKRANIUM UND VISZEROKRANIUM

Das **Neurokranium** ist ein metabolisches Feld der Detraktion, während das **Viszerokranium** aus embryologischen Derivaten besteht. Die dreidimensionale Form des **Jochbeins** ist besonders interessant, mit seinen kleinen Facetten und Furchen, insbesondere der **großen Furche** darüber, die als **Fissura orbitalis superior** bezeichnet wird, durch die der Nervus **oculomotorius** (Nerv III) und die Trigeminusäste verlaufen. Der **Canalis opticus** ist entscheidend, da er den Sehnerv und die Arteria ophthalmica beherbergt.

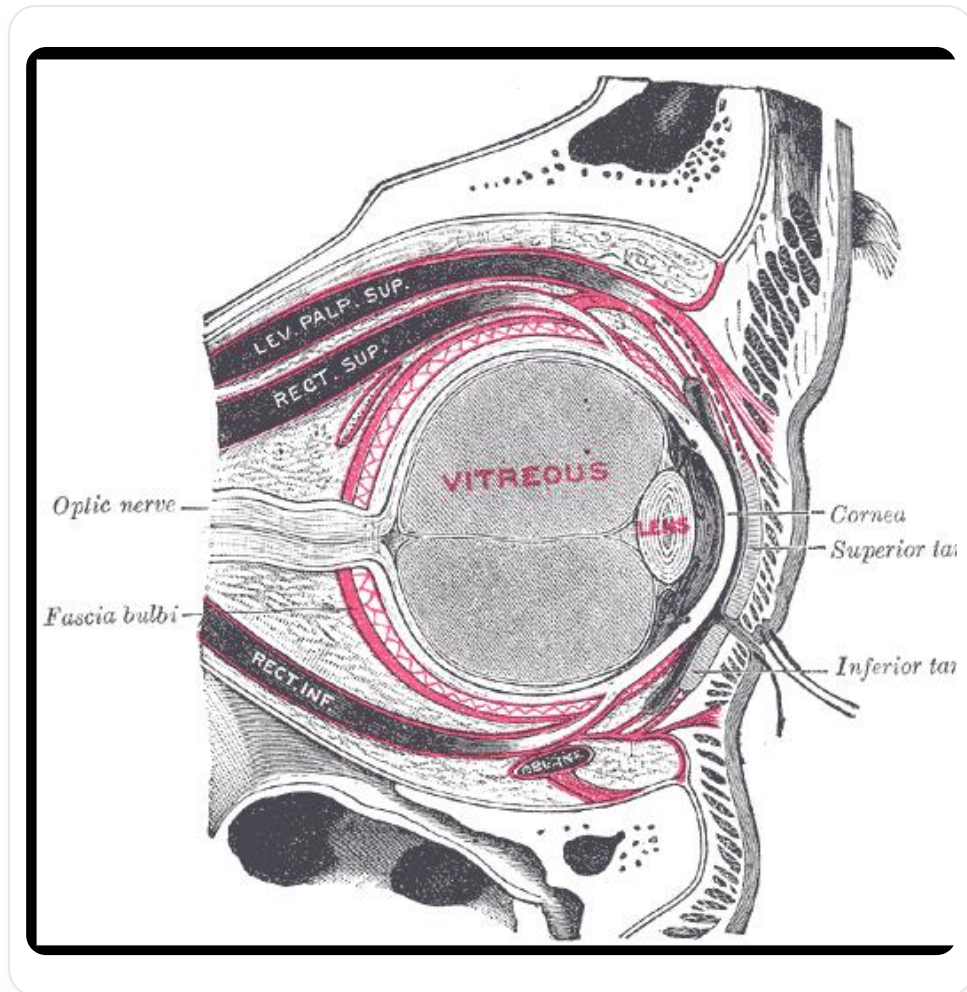


ABB. — Sphenoidalfissur

Das **Gaumenbein** spielt, obwohl es ein kleiner Fortsatz ist, eine wichtige Rolle im Gleichgewicht der Flexionsbewegung des Embryos während der Gaumenbildung. Es ist mit dem **Jochbein** und dem **Oberkiefer** verbunden, die ebenfalls dreidimensionale Knochen sind. Die Fossa lacrimalis, das Tränenbein, das **Siebbein**, das **Nasenbein**, das **Stirnbein** und das **Keilbein** bilden eine Konzentration knöcherner Informationen.

AUGENHÄUTE

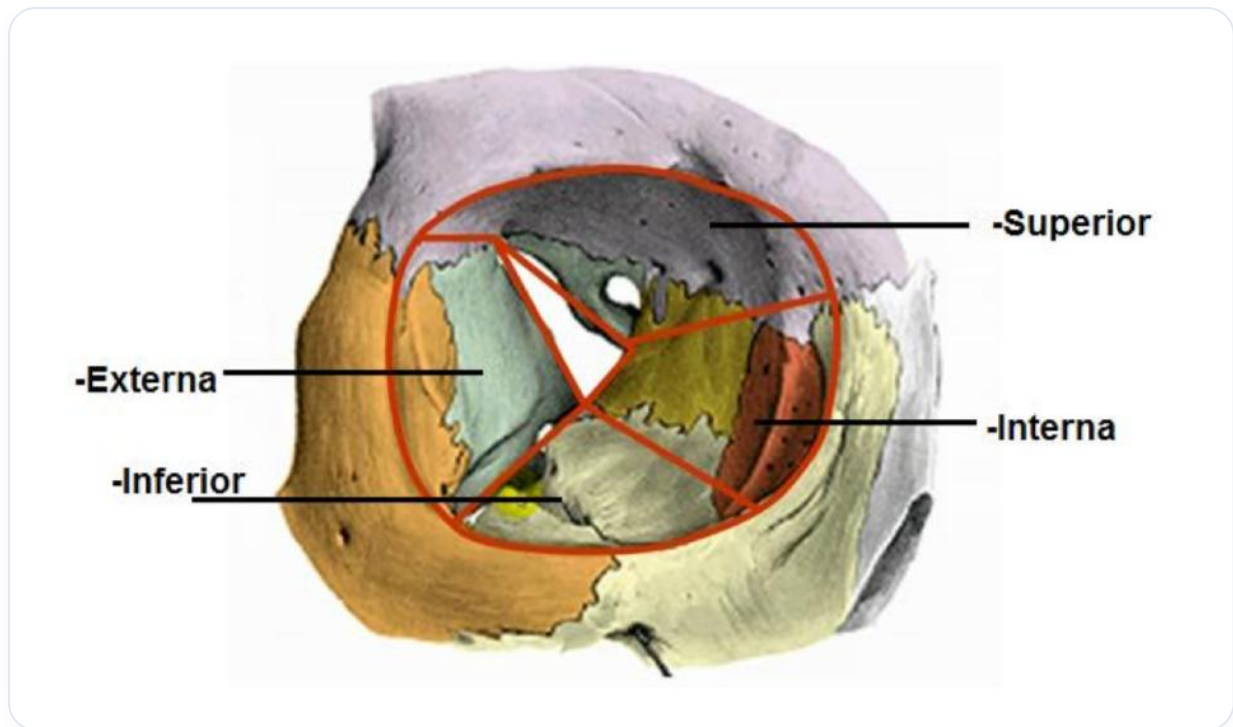


ABB. — Neurokranium und Viszerokranium, insbesondere die erwähnte Bedeutung des Gaumenbeins und des Jochbeins

Das Auge besteht aus drei großen Häuten:

1. **Sklera** (Lederhaut): Die Sklera ist die äußere Schicht, die sich vorne in der **Kornea** (Hornhaut), einer transparenten Sklera, fortsetzt. Das Weiße des Auges ist eine nicht-transparente Sklera.
2. **Uvea**: Besteht aus mehreren Teilen, darunter die **Aderhaut**, die reich vaskularisiert ist, die **Iris** vorne und der **Ziliarkörper** dazwischen. Der Ziliarkörper enthält Bänder und Muskeln, die als **Zonulafasern** bezeichnet werden und die Linse halten.

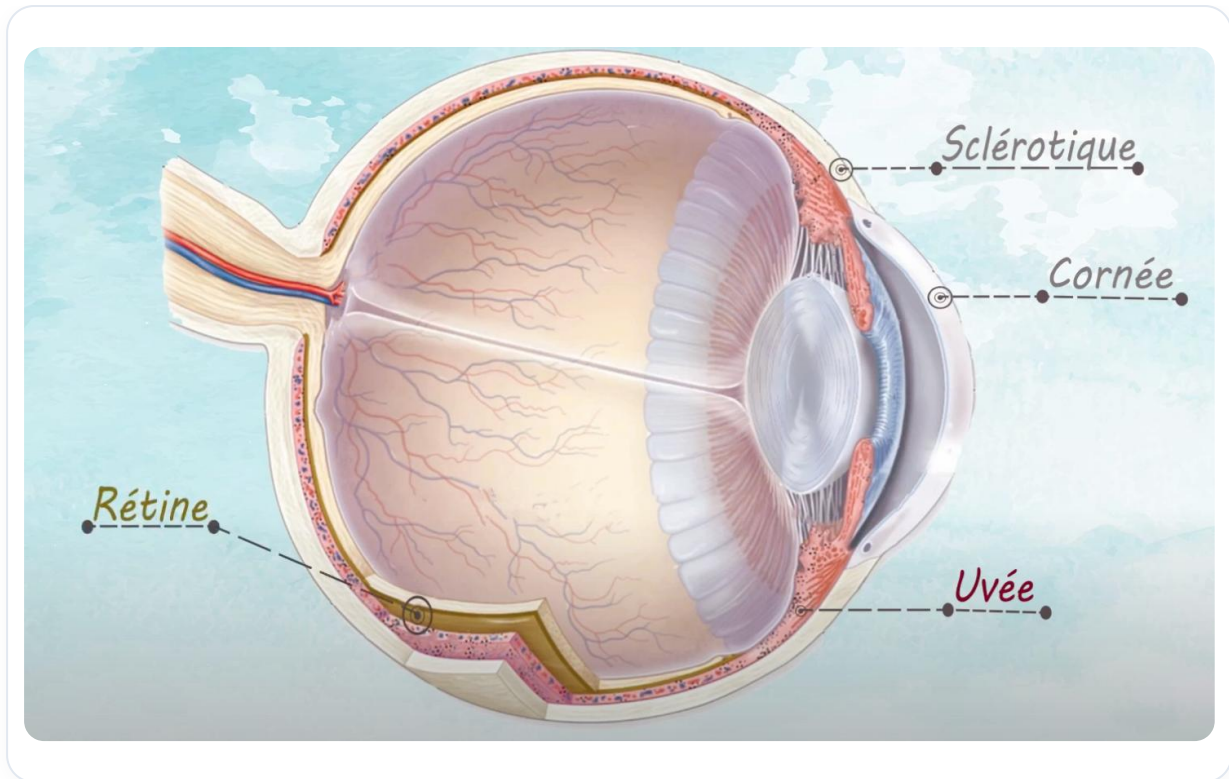


ABB. — Gesamtansicht der Augenhäute

3. **Retina** (Netzhaut): Die Retina enthält den **Cloquet-Kanal** oder den **Hyaloidkanal** sowie die **Ora serrata**. Sie ist reich an Photorezeptoren, insbesondere den **Zapfen** (Tagessehen) und den **Stäbchen** (Nachtsehen).

La cornée

TRANSPARENTE ET ANTERIEURE

1) Epithélium de revêtement pluristratifié pavimenteux épidermoïde :

Nombre variable de couches, nombreuses terminaisons sensibles, forte capacité de régénération

2) Membrane de BOWMAN (=membrane basale)

Epaisseur : 10-12 μm

Fibrilles de collagène IV

3) Stroma cornéen : Tissu conjonctif dense régulier LAMELLAIRE, NON vascularisé

- Faisceaux de fibres collagène I disposés perpendiculairement l'un à l'autre d'orientation régulière

- Fibroblastes

- Substance fondamentale riche en chondroïtine- et keratan-sulfate (hydrophilie)

4) Membrane de DESCOMET (=membrane basale)

5) Endothélium (=ERU pavimenteux)

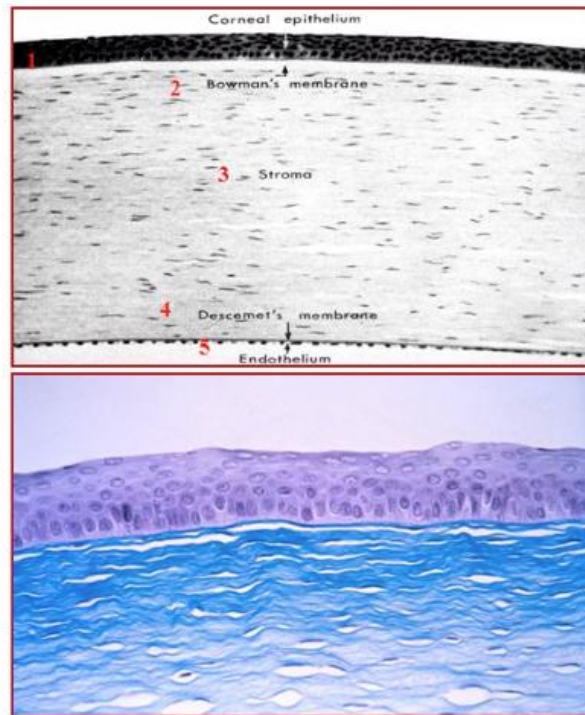


ABB. — Dieses Bild kann die Struktur der Hornhaut und ihrer Frequenzen veranschaulichen

Cornée

- Membrane transparente, en dôme, qui couvre le devant de l'œil.
- Elle est avasculaire, et richement innervée.

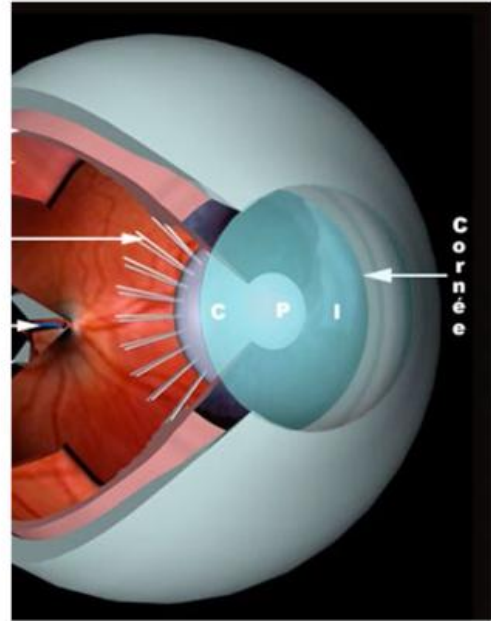


ABB. — Augenschnitt

ANATOMIE DER KORNEA UND SKLERA



ABB. — Dieses Bild kann die Vaskularisation in Bezug auf die Choroidea und die Informationsintegration im Auge veranschaulichen

Der **Limbus** ist die Verbindung zwischen Kornea und Sklera, auch als **Corneosklerallimbus** bezeichnet. Der **Schlemm-Kanal** ist wesentlich für die Resorption der Flüssigkeit aus der vorderen Augenkammer. Die **vordere Augenkammer** und die **hintere Augenkammer** des Auges sind durch die Pupille getrennt.

Das **Kammerwasser**, eine Nährflüssigkeit, wird von den Ziliarfortsätzen sezerniert, durch das Trabekelwerk gefiltert und durch den Sinus venosus sclerae und den Schlemm-Kanal resorbiert. Es hält das Gleichgewicht aufrecht und ernährt die Kornea und die Iris.

AUGENMUSKULATUR

Iris

- Zone colorée de l'œil.
- C'est un diaphragme circulaire, percé en son centre d'un orifice: **la pupille**.
- Constitué de 2 types de fibres musculaires lisses:
 - Fibres circulaires: **muscle sphincter de la pupille**.
 - Fibres étalées: **muscle dilatateur de la pupille**.

ABB. — Pupille und ihre Funktion der Lichtregulierung

Die Augenmuskeln, wie der **Musculus rectus superior**, der **Musculus rectus inferior** und die schrägen Muskeln, sind für die Augenbewegung unerlässlich. Der **Musculus levator palpebrae superioris** ist ebenfalls wichtig, und Ptosen des Augenlids können auf Gesundheitsprobleme hinweisen.

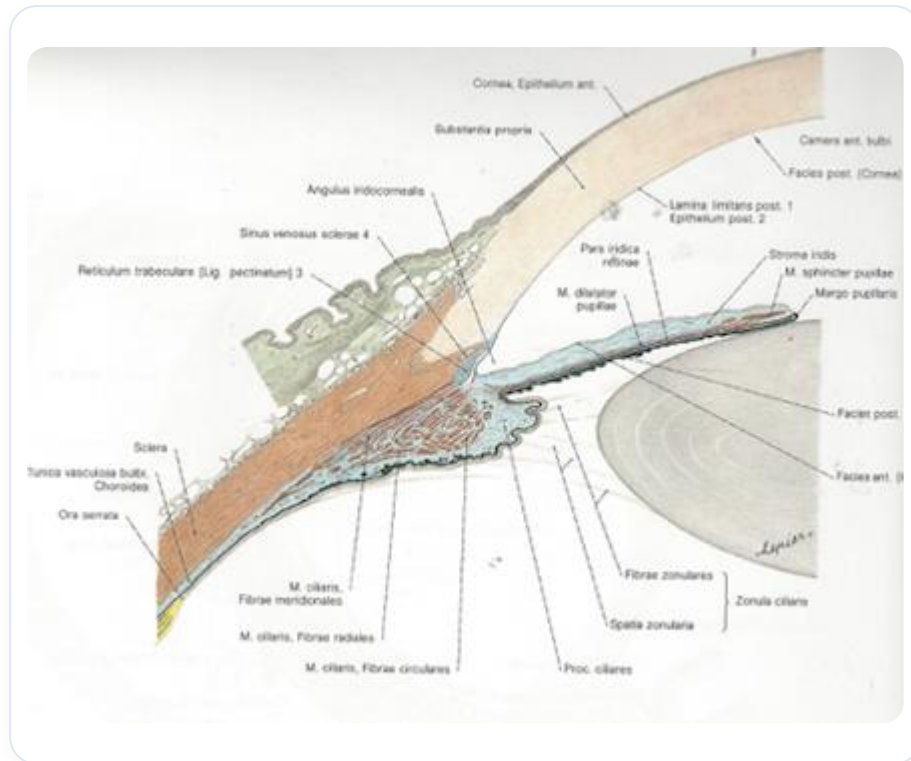


ABB. — Dieses Bild kann eine detailliertere Ansicht des Schlemm-Kanals und der Regulierung des Kammerwassers zeigen

Der **Zinn-Ring** ist der Ansatzpunkt der Augenmuskeln, die mit den Nackenmuskeln in Verbindung stehen. Die Sehnerven und die Arteriae ophthalmicae spielen eine entscheidende Rolle bei der Vaskularisation und Innervation des Auges.

VASKULARISATION UND INNERVATION

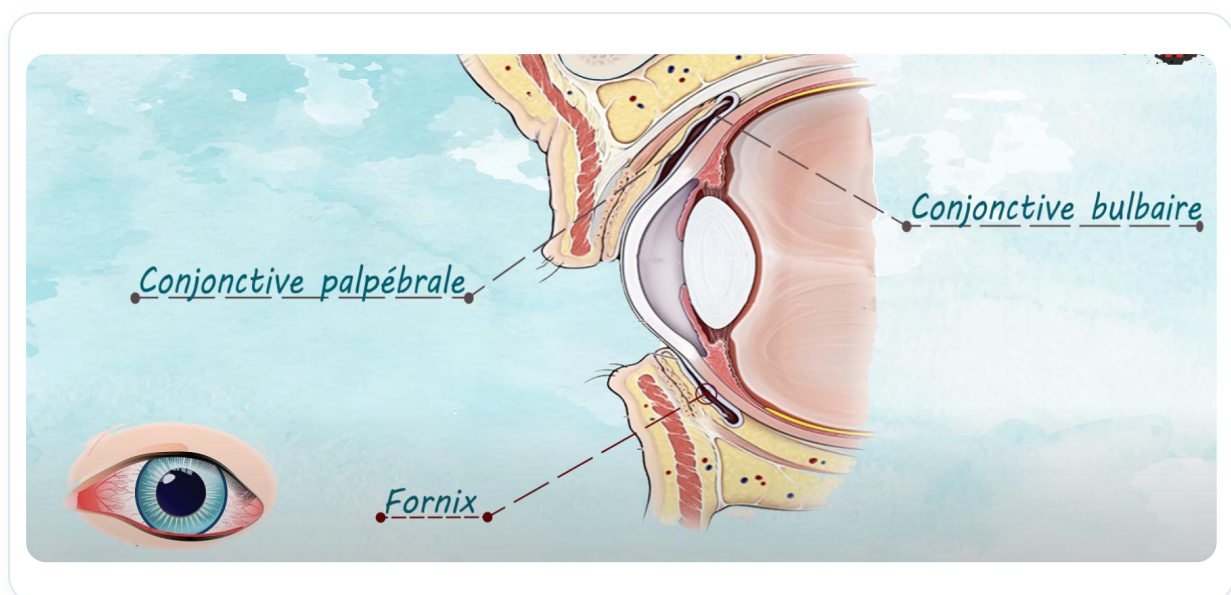


ABB. — Bindehautverbindung

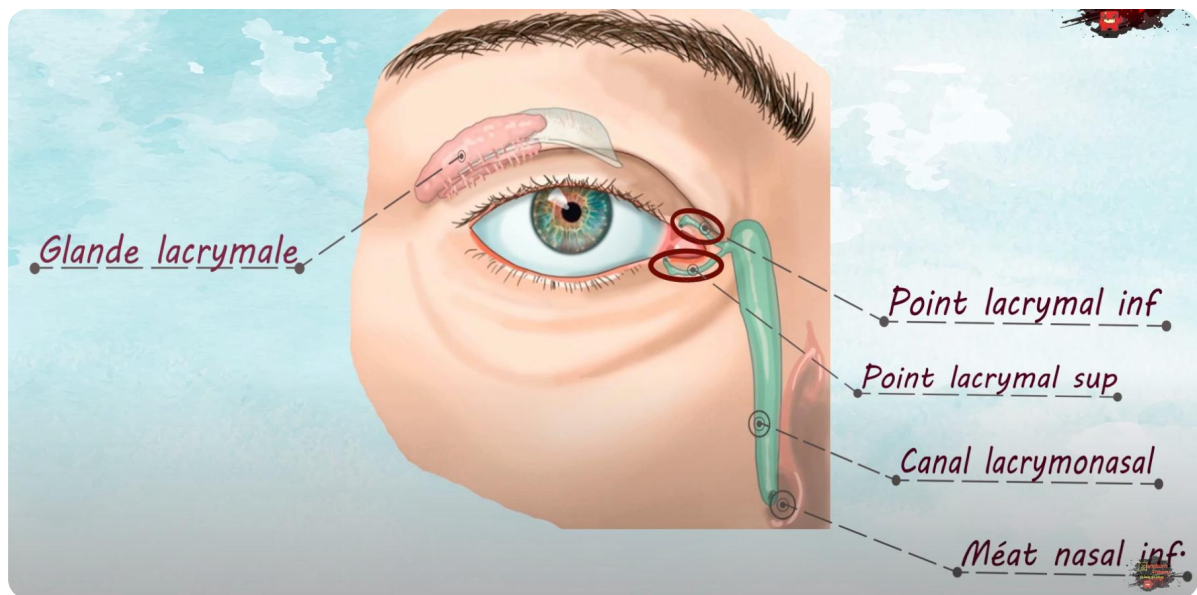


ABB. — Tränendrüse und ihr Drainagesystem

 Sekretionsdrüsen und die Kontinuität des Tarsus mit dem Muller-Muskel

ABB. — Sekretionsdrüsen und die Kontinuität des Tarsus mit dem Muller-Muskel

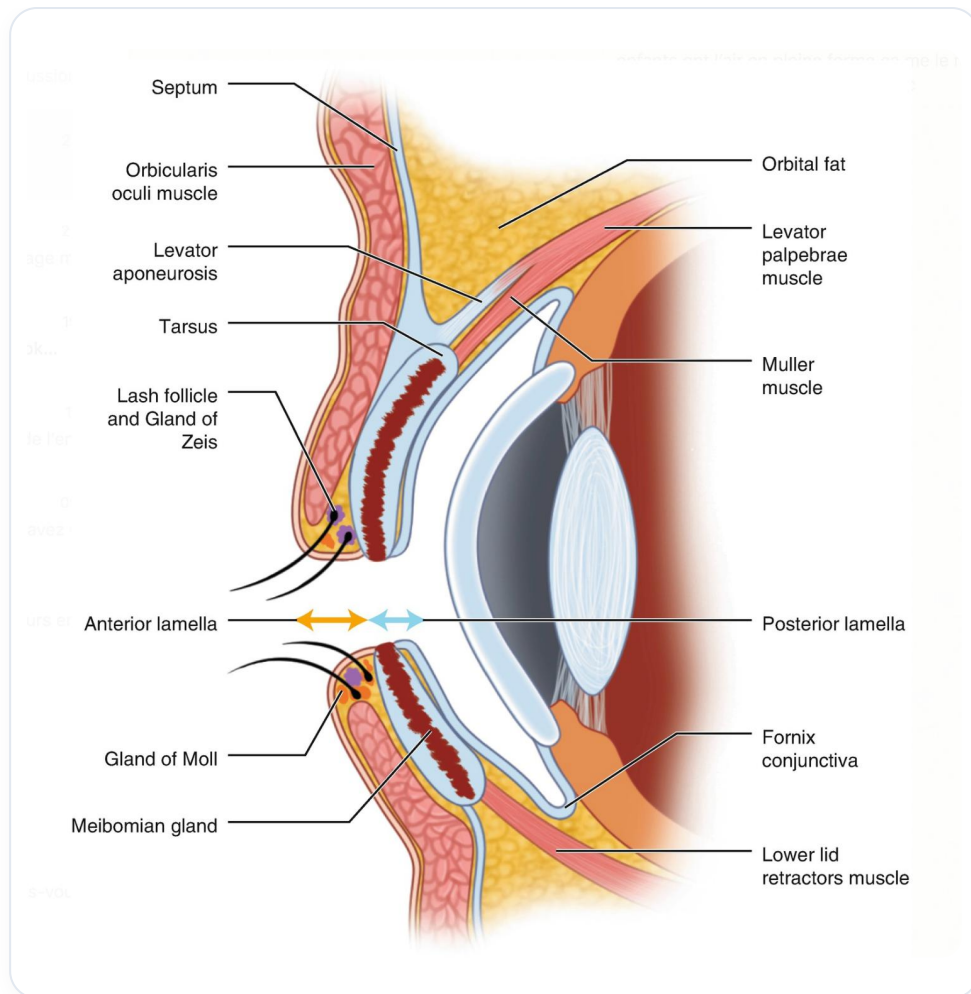


ABB. — Face muqueuse de la paupière (conjonctive)

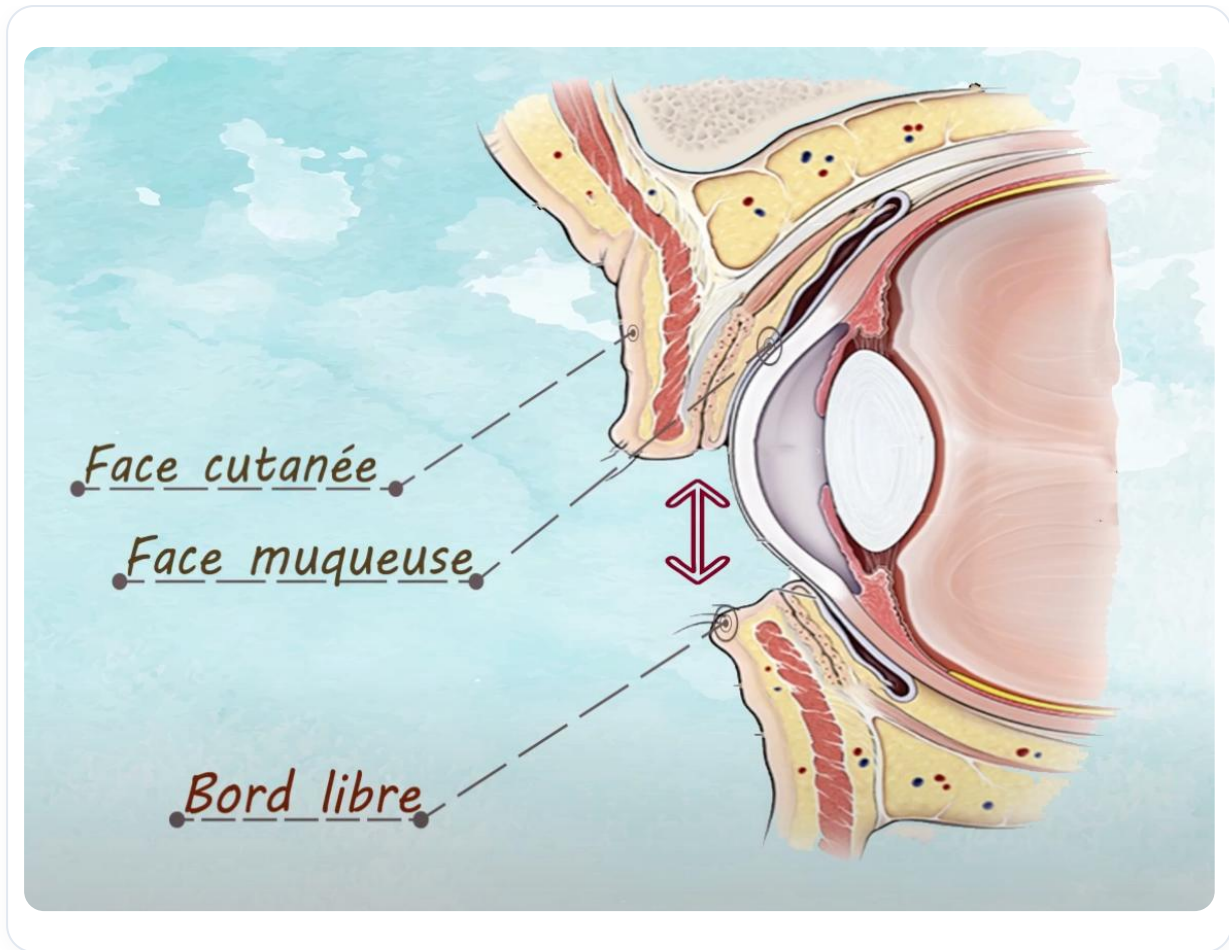


ABB. — Anatomie des Augenlids

Die Vaskularisation des Auges stammt von der Karotis, mit Arteriae ophthalmicae und Ästen für die Vaskularisation der Retina. Die **Perizyten** oder Rouget-Zellen modulieren die Information auf Kapillarebene, insbesondere in der Retina.

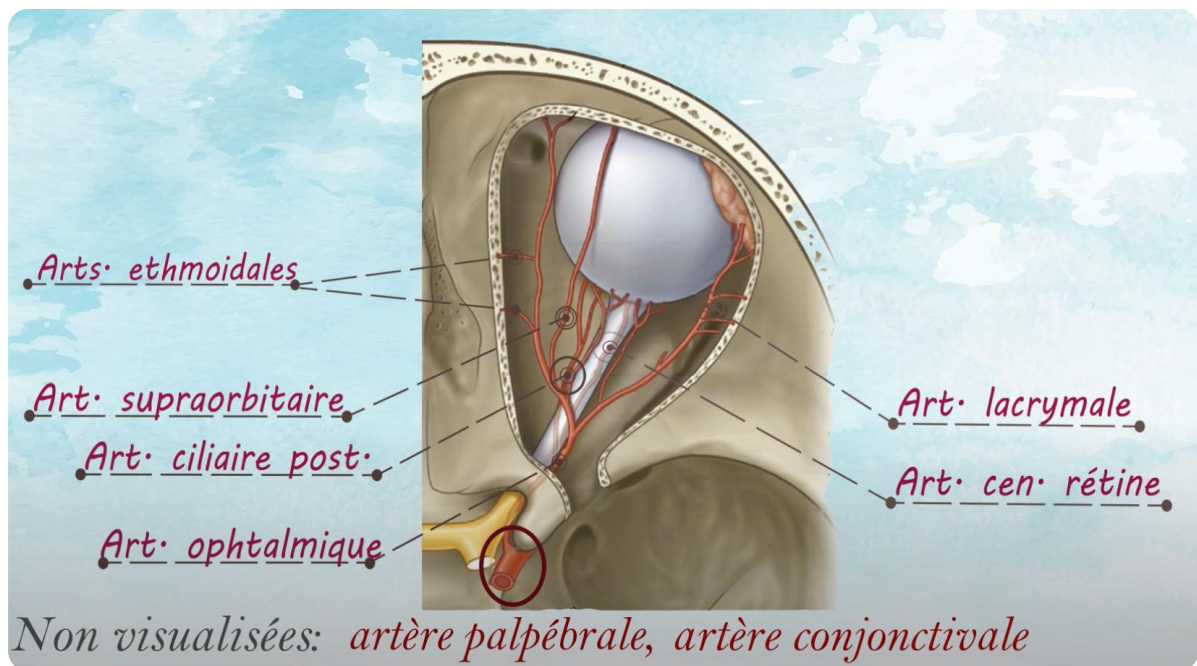


ABB. — Beziehung der Tenon-Kapsel zu den Körperfaszien

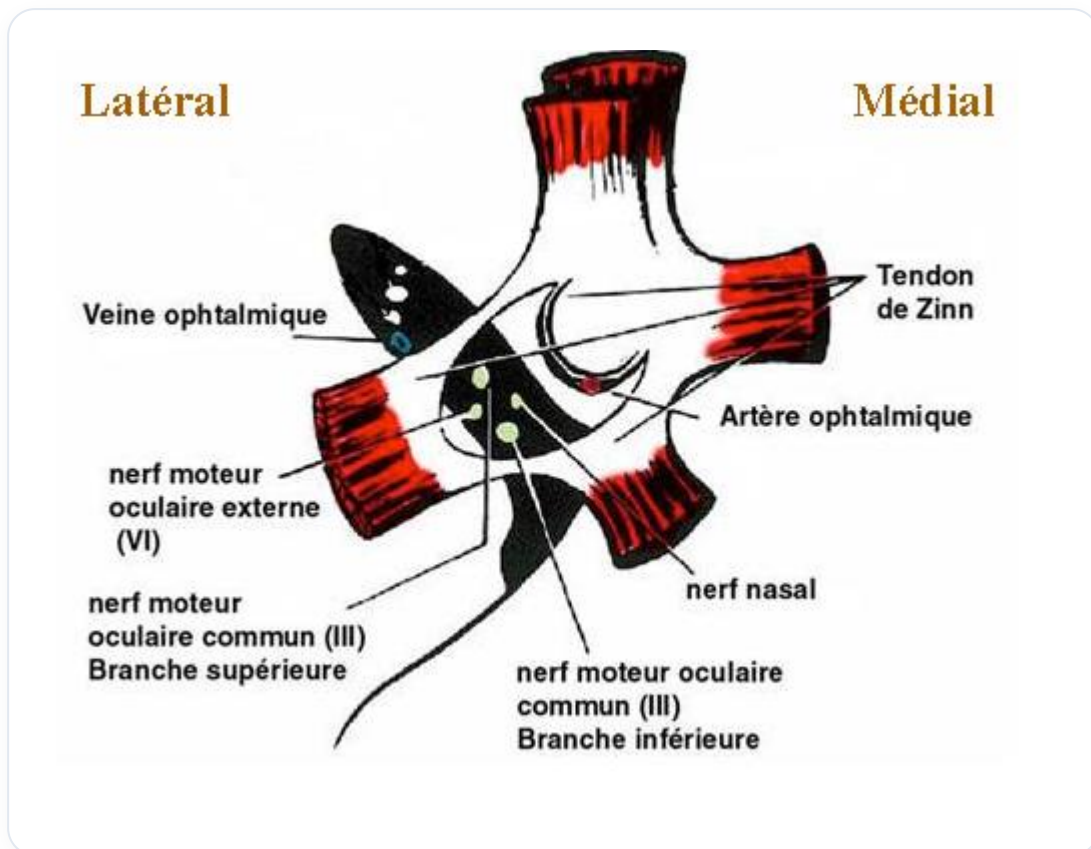


ABB. — Muscles oculomoteurs



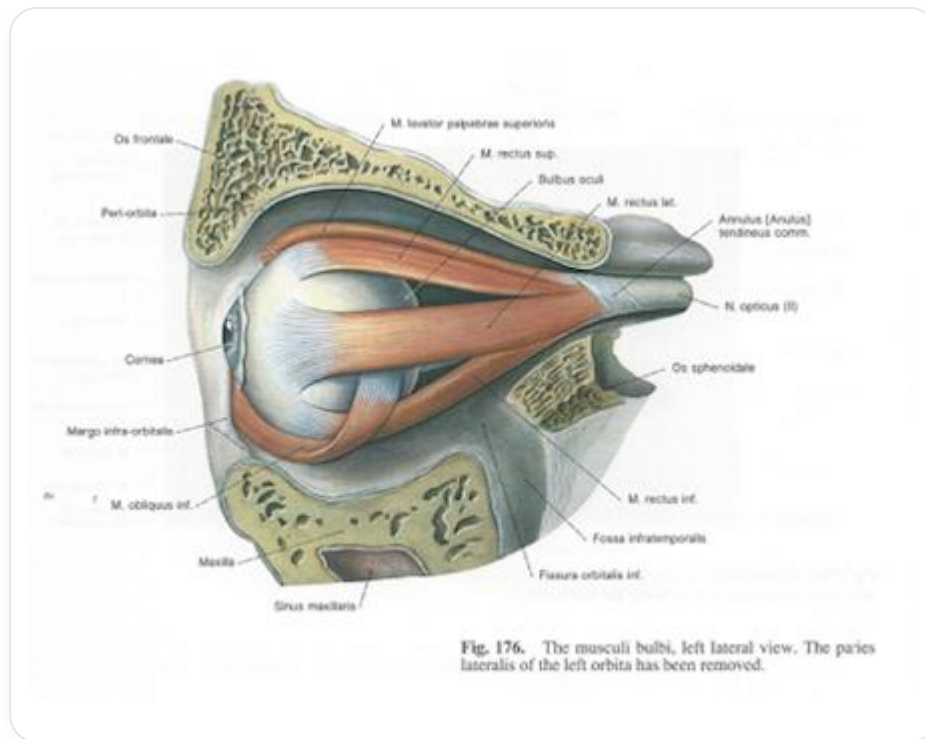


ABB. — Muscles oculomoteurs

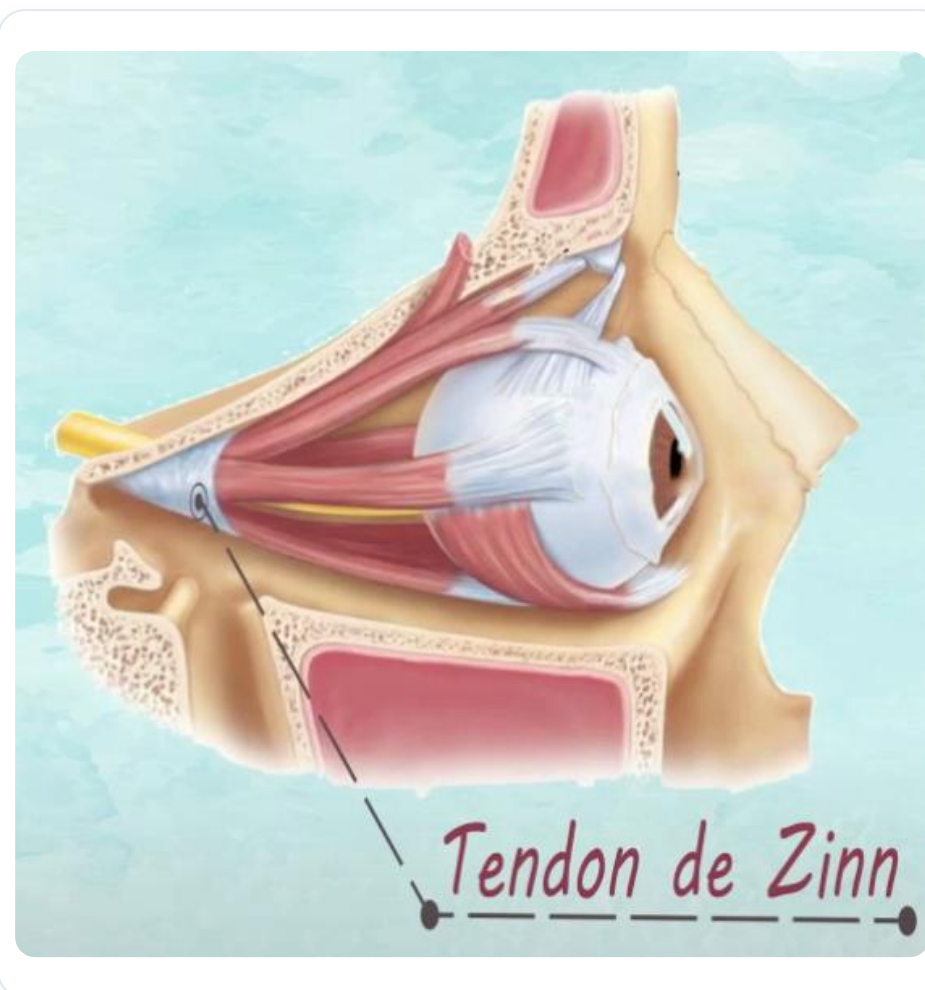


ABB. — Muscles oculomoteurs

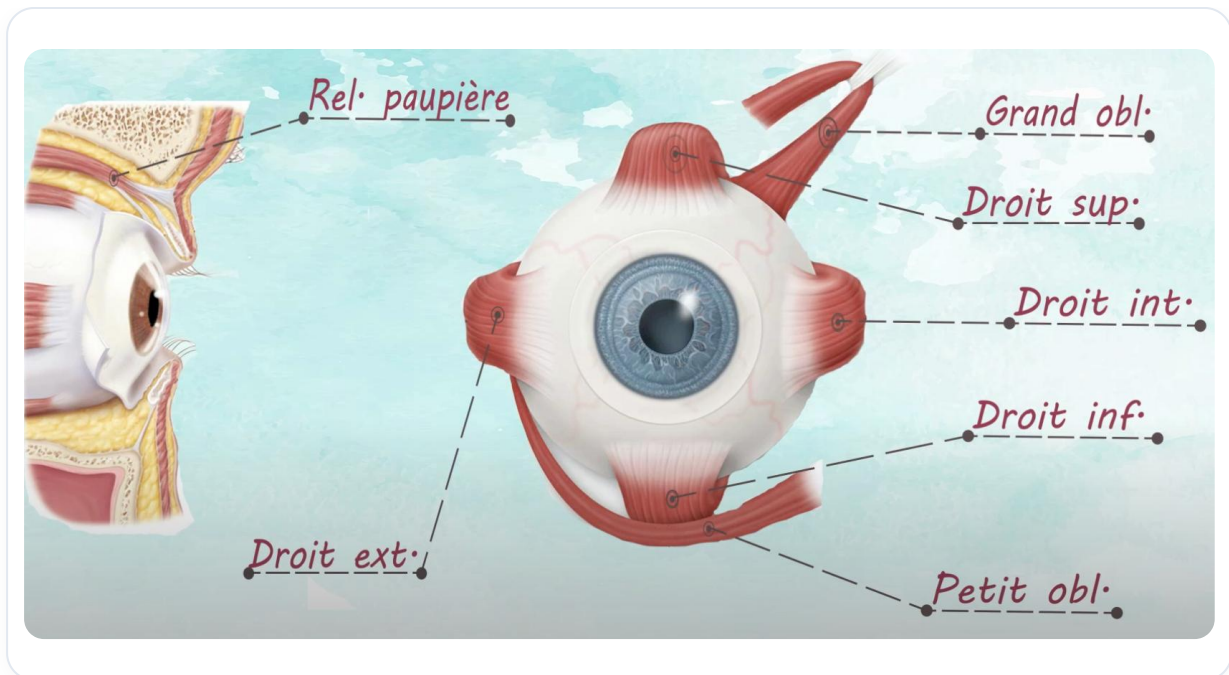


ABB. — Augenmuskulatur und der Ansatzpunkt der Zinnschen Sehne

Die Innervation des Auges umfasst sensible, motorische und vegetative Bahnen, wobei der Sehnerv die visuelle Information aufnimmt. Das Zusammentreffen dieser Systeme auf der Ebene der Retina bildet den Sehnerv, der die sensorische Information überträgt.

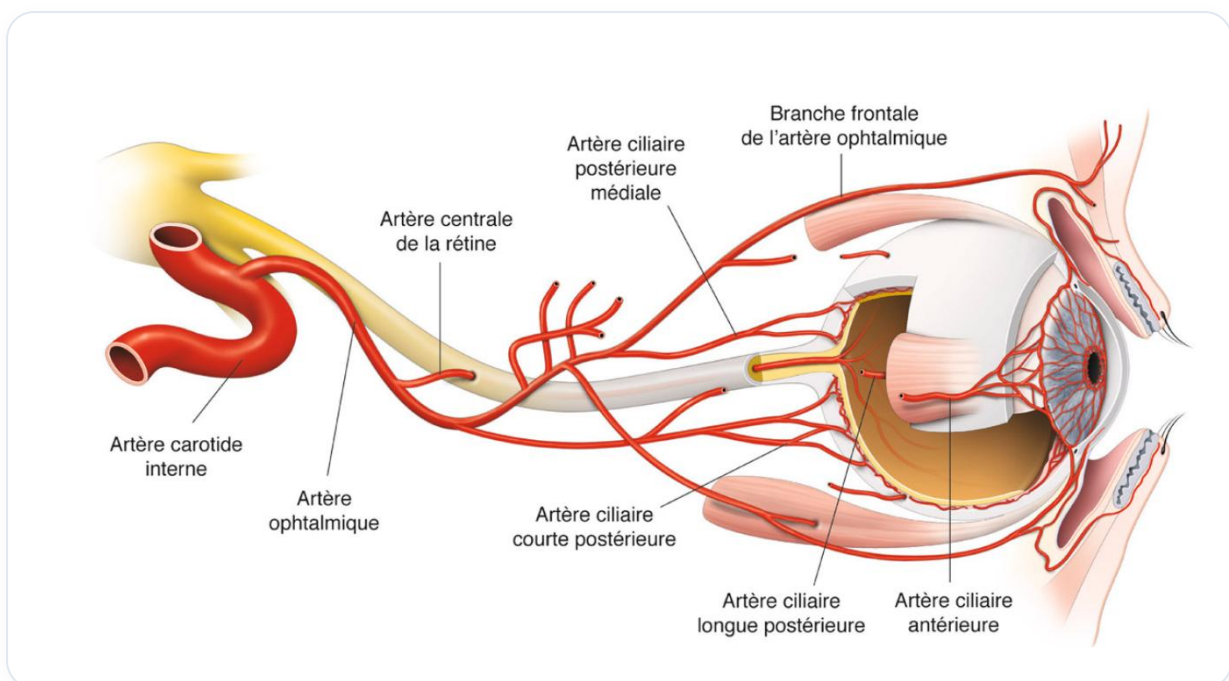


ABB. — Beziehung zwischen Karotis und Sehnerv

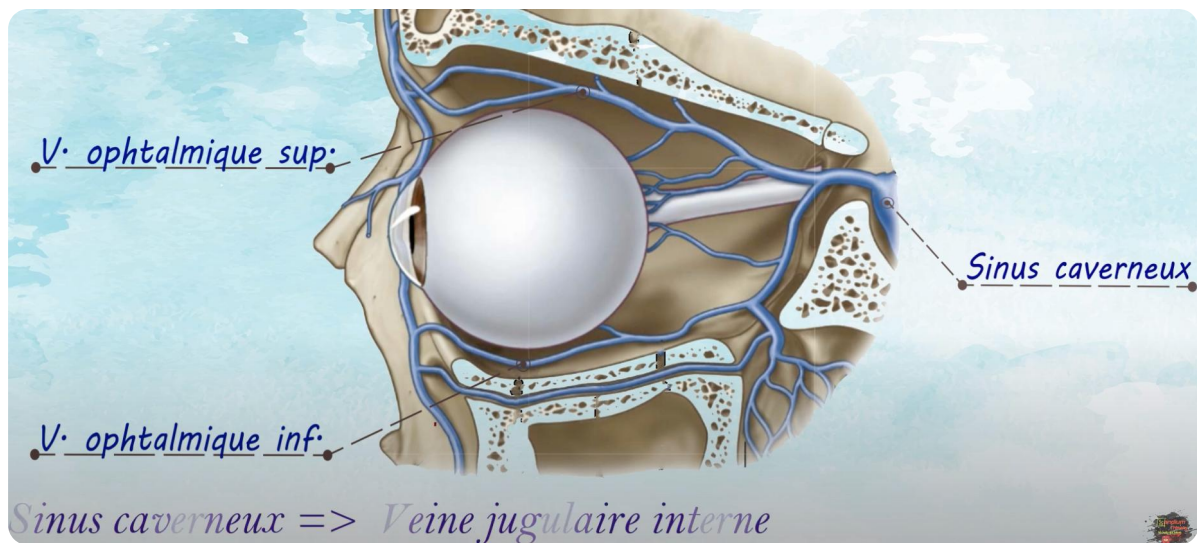


ABB. — Dieses Bild kann eine venöse Sinus oder einen Aspekt der Vaskularisation veranschaulichen

FAZIT

Die Anatomie des Auges und des Neurokraniums ist komplex und miteinander verbunden, wobei verschiedene Strukturen eine wesentliche Rolle bei der Sehkraft und der neurologischen Funktion spielen. Das Verständnis dieser Elemente ist für Angehörige der Gesundheitsberufe, insbesondere in der Medizin und Osteopathie, von grundlegender Bedeutung.

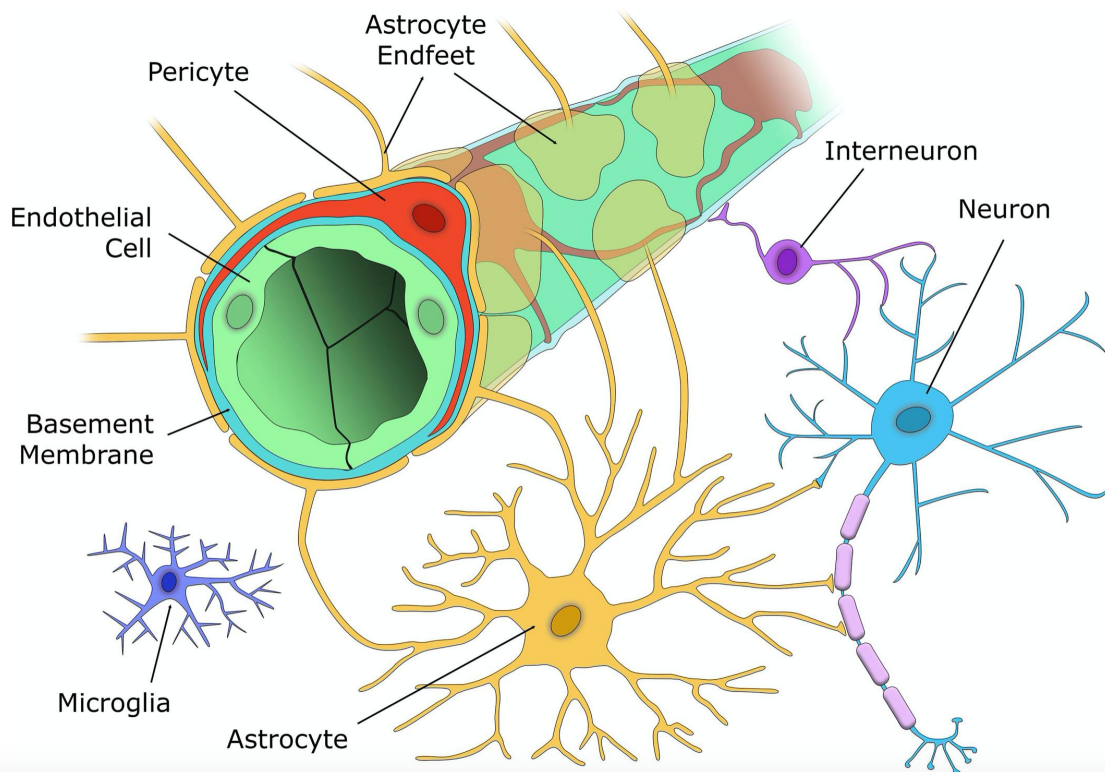


ABB. — Vaskularisation des Auges, beginnend mit der Halsschlagader

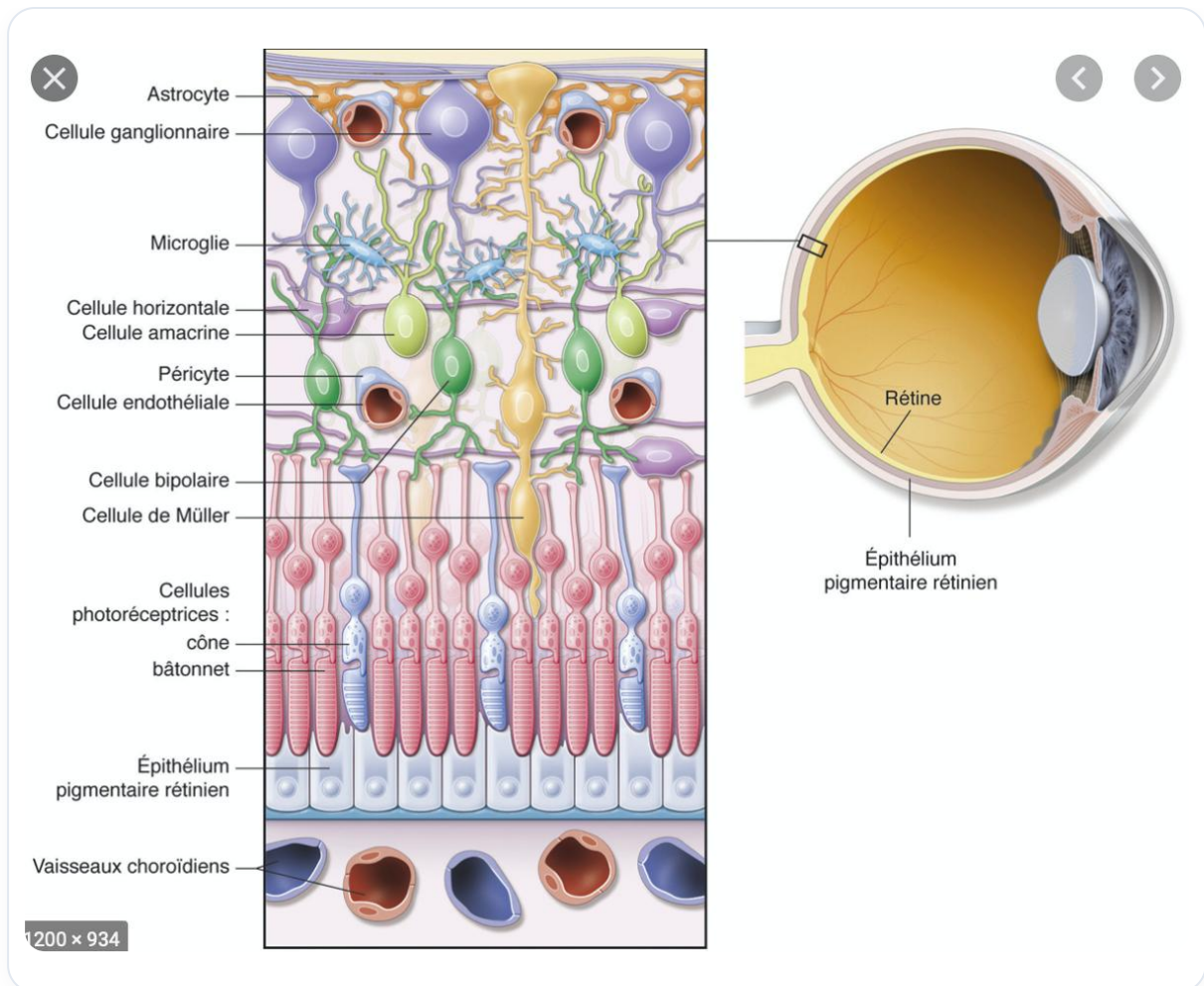


ABB. — Perizyten und ihre Rolle bei der Informationsmodulation

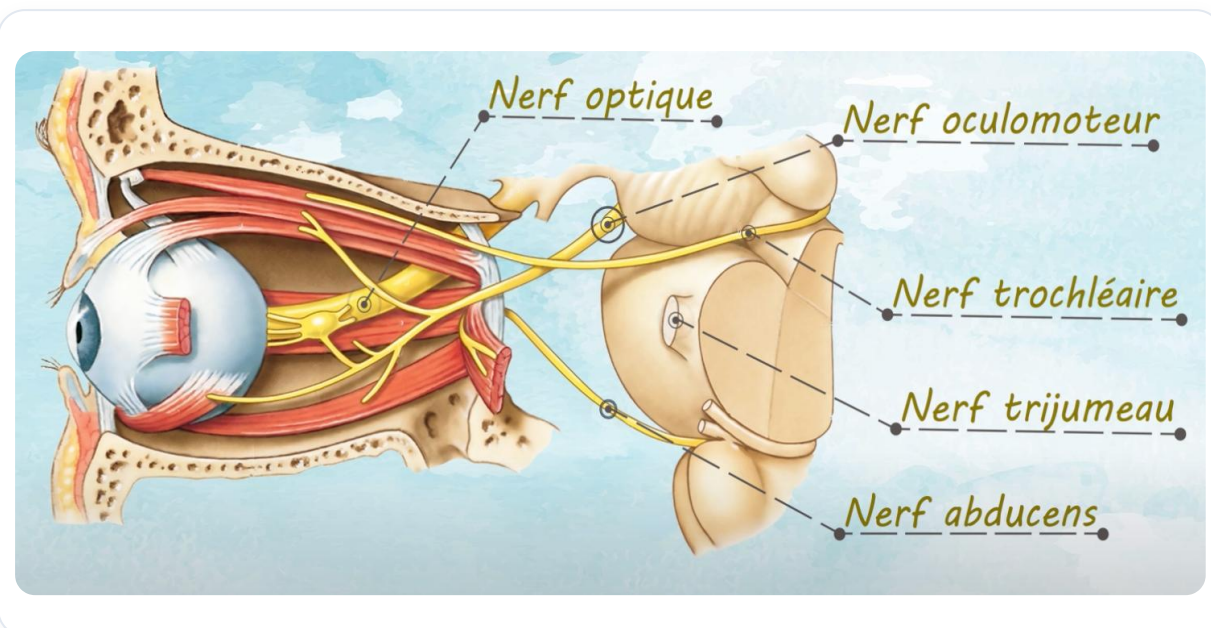


ABB. — Die Innervation und die Vereinigung der Informationen im optischen Kanal

Nerfs

- **Nerf sensoriel:** nerf optique (II).
- **Nerfs moteurs:** III, IV et VI.
- **Nerf sensitif :** nerf ophtalmique.
- **Un centre végétatif :** ganglion ophtalmique.

ABB. — Dieses Bild kann die Darstellung der Innervation und Informationsübertragung über den Sehnerv ergänzen

24. DIE WELT DER INTENTION

DAUER : 08:26

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video behandelt der Lehrer den Begriff des Leidens, das mit Fixierung verbunden ist, und die Bedeutung der Freiheit des Seins. Die Fünf Aggregate – Form, Empfindungen, Wahrnehmungen, Willensbildung und Bewusstsein – werden eingehend untersucht, wobei jedes Aggregat eine Dimension unserer Existenz und unserer subjektiven Erfahrung darstellt. Indem sie sich dieser Elemente bewusst werden, lernen die Schüler, loszulassen und ihre Empfindungen und Emotionen besser zu bewältigen, indem sie die Anhaftung vermeiden, die zu Leid führt. Schlüsselkonzepte wie Vergänglichkeit, Interdependenz und persönliche Verantwortung werden ebenfalls erforscht, wobei die Bedeutung der Reflexion über die eigenen Absichten hervorgehoben wird, um eine besser ausgerichtete und harmonischere Existenz zu schaffen.

DIE WELT DER ABSICHT

Leiden ist oft mit unserer Tendenz verbunden, Dinge zu fixieren, wodurch die natürliche **Bewegung** des Lebens behindert wird. Es ist wesentlich, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, der **Freiheit** Ausdruck zu verleihen.

DIE FÜNF AGGREGATE

1. DIE FORM

Das erste Aggregat ist die **Form**, die die **Phänomenologie** umfasst. Es ist die physische Manifestation unserer Existenz.

2. DIE EMPFINDUNGEN

Das zweite Aggregat betrifft die **Empfindungen**. Sobald der Körper präsent ist, wird er eingeladen zu fühlen. Der Buddha lehrte, dass der Körper **unbeständig** und **interdependent** ist. Man kann sich unsere Existenz als ein riesiges Spiel vorstellen, so groß wie die Erde, was eine gewisse **Verantwortung** impliziert.

Empfindungen können angenehm oder unangenehm sein. Manchmal kann eine angenehme Empfindung mit der Zeit unangenehm werden und umgekehrt. Der Buddha illustriert dies mit dem Bild der **Seifenblasen**: sie erscheinen und verschwinden dann. Wir neigen dazu, uns an diese Empfindungen zu klammern und so eine **Anhaftung** an das zu schaffen, was nicht mehr existiert.

Es ist häufig, dass Menschen unangenehme Ereignisse der Vergangenheit reaktivieren, als ob sie eine **Kuppel** öffneten, um einen schlechten Geruch wiederzuerleben. Dieser Prozess der Anhaftung oder Ablehnung ist eine Form der Fixierung. Das **Loslassen** darf nicht mit Aufgeben verwechselt werden; es geht darum zu akzeptieren, dass Empfindungen nicht von Dauer sind.

3. DIE WAHRNEHMUNGEN

Das dritte Aggregat ist das der **Wahrnehmungen**. Diese können mit einer **Fata Morgana** verglichen werden, bei der wir unsere eigenen Befriedigungsmuster auf andere projizieren. Zum Beispiel kann bei einer Meditation das verspätete Eintreffen einiger Teilnehmer Frustration hervorrufen. Indem wir uns dieser Wahrnehmungen bewusst werden, können wir wählen, sie als **Lärm** zu betrachten.

4. DIE WILLENSBILDUNG

Das vierte Aggregat betrifft die **Willensbildung** oder die **mentalen Faktoren**. Es ist entscheidend, sich unserer **Absichten** bewusst zu werden, da sie unsere karmische Welt formen. Bevor wir handeln oder sprechen, ist es wesentlich, über unsere Absichten nachzudenken. Der Buddha illustrierte dies, indem er seine Absichten in zwei Pakete teilte: die, die vorteilhaft sind, und die, die es weniger sind.

5. DAS BEWUSSTSEIN

Das letzte Aggregat ist das des **Bewusstseins**. Dieses Bewusstsein kann als ein **Magier** wahrgenommen werden, der die große Illusion darstellt. Es wird oft zur ultimativen Zuflucht des Egos.

FAZIT

Die Aggregate – der Schaum, die Blasen, die Wahrnehmungen, der Bananenbaum und das Bewusstsein – sind miteinander verbunden und überlagern sich ständig. Es ist vorteilhaft, sich die Zeit zu nehmen, über jedes dieser Aggregate nachzudenken, selbst wenn man einen einwöchigen oder einmonatigen Retreat ihrem Studium widmet. Dies ermöglicht es, unser Verständnis von uns selbst und unserer Erfahrung zu vertiefen.

25. REVISION

DAUER : 01:05

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt ausführlich die Anatomie der Netzhaut, indem es deren Umhüllung erklärt, die die Uvea, die Aderhaut, die Iris und die Ziliarkörper umfasst. Sie erfahren, wie sich die Netzhaut, bestehend aus der äußeren und inneren Netzhaut, aus dem primitiven Augenbecher und seiner juxtakrinen Interaktion mit dem Epiblasten entwickelt. Einer der wichtigsten Punkte ist die Netzhautablösung, ein Phänomen, das sowohl theoretisch als auch im klinischen Kontext von wesentlicher Bedeutung ist. Darüber hinaus wird betont, dass die Netzhaut ein vom Gehirn abgeleitetes Gewebe ist, eine Vorstellung, die Ihr embryologisches Verständnis bereichert und Perspektiven für Augenerkrankungen eröffnet.

REVISION DER ANATOMIE DER NETZHAUT

Die **Hülle** des Auges umfasst die **Uvea**, die aus der **Aderhaut**, der **Iris** und den **Ziliarkörpern** besteht. Wenn wir diese Hülle entfernen, gelangen wir zur **Netzhaut**, die aus zwei großen Hauptschichten besteht: der **äußeren Netzhaut** und der **inneren Netzhaut**.

Auf der Höhe der Netzhaut kommt es zur **Ablösung**, einem wichtigen Phänomen, das man kennen sollte. In diesem Stadium bildet sich die **primitive Augenbecher** und stellt eine **juxtakrine** Verbindung mit der oberflächlichen **Epiblaste** her. Diese Interaktion führt zu einer Verdickung der Epiblaste, wodurch die **äußere Augenplakode** entsteht, die an Ort und Stelle gehalten wird, während sich die umgebende Struktur entwickelt.

Diese Dynamik führt zur Entstehung einer **primitiven Vertiefung**. Die Netzhaut umgibt sich bei ihrer Entwicklung und bildet die sogenannte **äußere Netzhaut** und die **innere Netzhaut**. Hier kommt es zur Netzhautablösung, einem Problem, das viele Menschen bereits erlebt haben.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Netzhaut tatsächlich ein Gewebe ist, das vom **Gehirn**, genauer gesagt vom **ventrikulären Gewebe**, abstammt.

26. NEUROPHYSIOLOGIE DES AUGES: EINFÜHRUNG

DAUER : 04:43

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Einführung in die Neurophysiologie des Auges erforscht die Zusammenhänge zwischen Leid, Wahrnehmung und den anatomischen Besonderheiten des Auges. Sie erfahren, wie Augenbewegungen und die Geometrie der Iris emotionale Zustände anzeigen können, sowie die Unterschiede zwischen Sehkraft, Hellsehen und Polysehen. Das Video beschreibt dann die verschiedenen Strukturen des Auges, von der Bindehaut bis zur Netzhaut, und erklärt, wie Licht in elektrische Signale umgewandelt wird. Durch die Integration von Konzepten wie der Bedeutung der Augenausrichtung und der Photonentransduktion bereichert diese Präsentation Ihren theoretischen und praktischen Ansatz in der Osteopathie und Biodynamik.

NEUROPHYSIOLOGIE DES AUGES: EINFÜHRUNG

Wenn ein Mensch **Leid** erfährt, sei es **körperlicher**, **emotionaler** oder anderer Natur, kann sich dies in seinen Augen widerspiegeln. Das Auge kann spezifische Bewegungen ausführen, und es gibt eine **Geometrie** in der Iris, die sich auf verschiedene Weisen manifestieren kann.

Das Auge ist auch ein Initiationspunkt in Verbindung mit der **Christagalie**. Ursprünglich ist diese Struktur flach, aber durch den Prozess der **Telencephalie** entwickelt sie sich. Dieser Konzentrationspunkt wird oft als das **Auge der Hellsichtigkeit** bezeichnet.

Es gibt verschiedene Ebenen der Wahrnehmung:

- **Wahrsagerei:** Nutzung der Emotionen anderer.
- **Hellsichtigkeit:** Fähigkeit, die akashische Welt des anderen wahrzunehmen, um dessen Funktionsweise zu verstehen.
- **Polyvoyance:** Vision der Göttlichkeit, die in allem gegenwärtig ist.

Das Auge empfängt **Lichtinformationen** in Form von Photonen. Die erste Schicht, die durchquert wird, ist die **Bindehaut**, gefolgt von der **Hornhaut**, die der transparente Teil der Sklera ist. Danach passiert das Licht die **Pupille**.

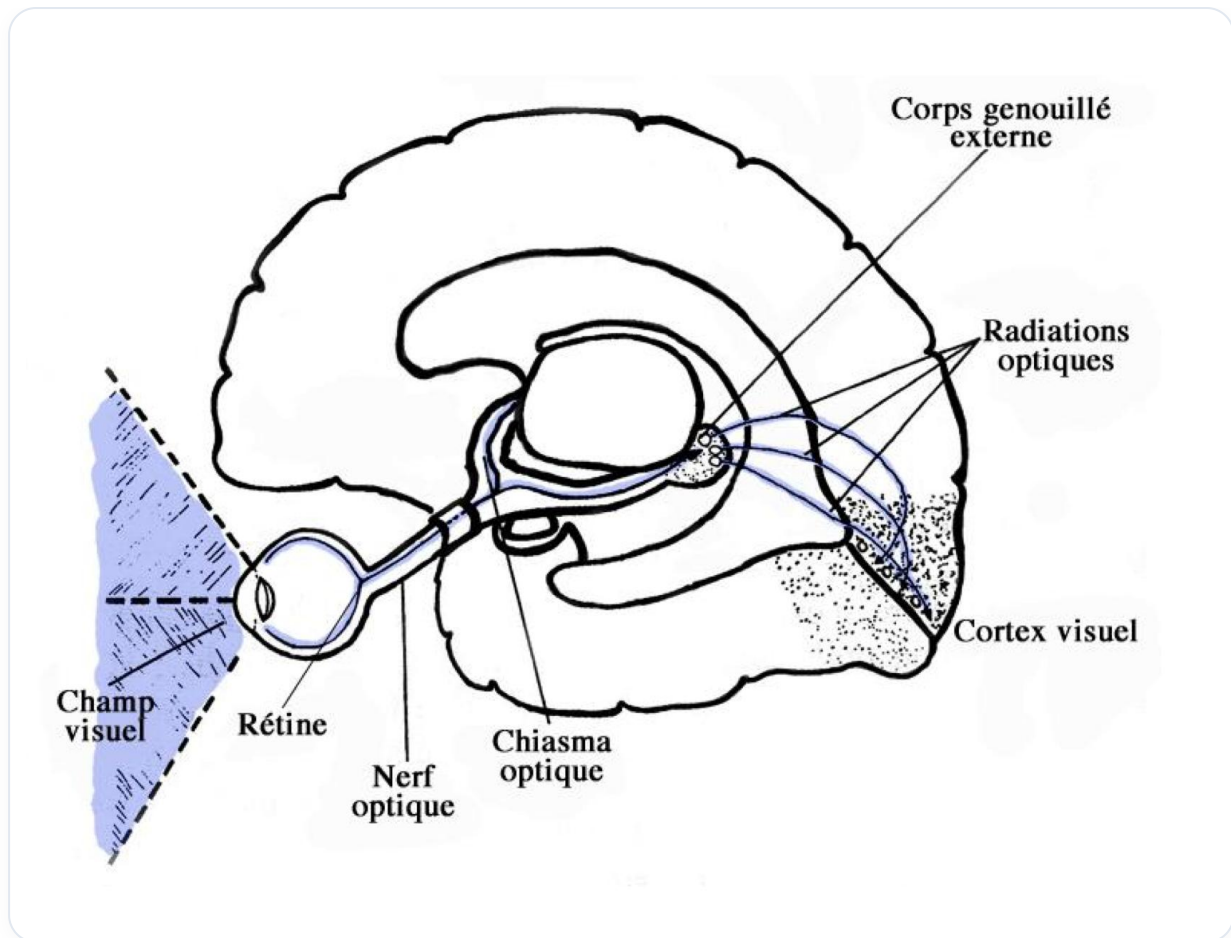


ABB. — Schichten des Auges

Die vordere Kammer, die **Kammerwasser** enthält, wird von der hinteren Kammer gefolgt, die ebenfalls diese Flüssigkeit enthält. Die **Ziliarfortsätze** vorne produzieren Flüssigkeit, während der **Schlemm-Kanal** hinten diese Flüssigkeit wieder aufnimmt. Dieser Prozess ermöglicht eine kontinuierliche Zirkulation von Flüssigkeit, die das Auge ernährt.

Das Licht durchquert dann die **Linse** und den **Glaskörper**, um die **Netzhaut** zu erreichen, die aus mehreren Schichten besteht. Das Auge ist in der Lage, eine kleine Menge Licht, sogar ein einzelnes Photon, einzufangen, während es gleichzeitig eine zentrale und eine periphere Sicht hat.

Es ist wesentlich, zu lernen, diese beiden Arten von Visionen zu nutzen. Die Frequenz, die Welle und das Lichtspektrum variieren, und die Ausrichtung des Auges beträgt oft **23 Grad**, ein Wert, der mit der Ausrichtung des Herzens, der Erde und der Innenohren in Resonanz steht.

Diese spezifische Ausrichtung beeinflusst die **Netzhaut**, wo das Phänomen der **Transduktion** stattfindet. Photonen werden in elektrische Signale umgewandelt, die als Nervenimpulse nach links und rechts gesendet werden. Jedes Auge übermittelt diese Informationen an den **Corpus geniculatum laterale (CGL)**, der sie über **kagnocelluläre** und **magnocelluläre** Zellen interpretiert.

Nach der Integration gelangen diese Informationen über die **Sehstrahlung** zum **visuellen Kortex**, der sich oberhalb und unterhalb des Auges, nahe der **Fissura calcarina**, befindet. Dieser Weg des Auges und die Interpretation der visuellen Signale sind entscheidend für das Verständnis der Neurophysiologie des Sehens.

27. MECHANISMUS DER TRANSDUKTION

DAUER : 08:39

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit dem Mechanismus der visuellen Transduktion und beschreibt den Weg des Lichts durch die verschiedenen Schichten der Netzhaut, von den Photorezeptoren bis zum Sehnerv. Die verschiedenen Zellen der Netzhaut, insbesondere Zapfen, Stäbchen, bipolare Zellen und Ganglienzellen, werden untersucht, um ihre Rolle bei der Verarbeitung visueller Informationen zu verstehen. Die chemische Umwandlung von Rhodopsin und Iodopsin bei Lichtabsorption sowie die Bedeutung von Vitamin A werden ebenfalls erörtert, wobei die Folgen eines Mangels für das Sehvermögen beleuchtet werden.

MECHANISMUS DER TRANSDUKTION

Lichtstrahlen durchqueren zunächst alle Schichten der Netzhaut, um die **Photorezeptoren** zu erreichen. Diese Photorezeptoren sind aktiv dank ihrer Lokalisation in einem Bereich, der als **Pigmentzone** bezeichnet wird und die erste Schicht bildet. Die Photorezeptoren teilen sich in zwei Typen: die **Zapfen** und die **Stäbchen**.

Nachdem das Licht diese erste Schicht durchquert hat, erreicht es die **bipolaren Zellen** und dann die **Ganglienzellen**. Letztere bündeln ihre Axone, um den **Sehnerv** zu bilden, wo die Transduktion stattfindet.

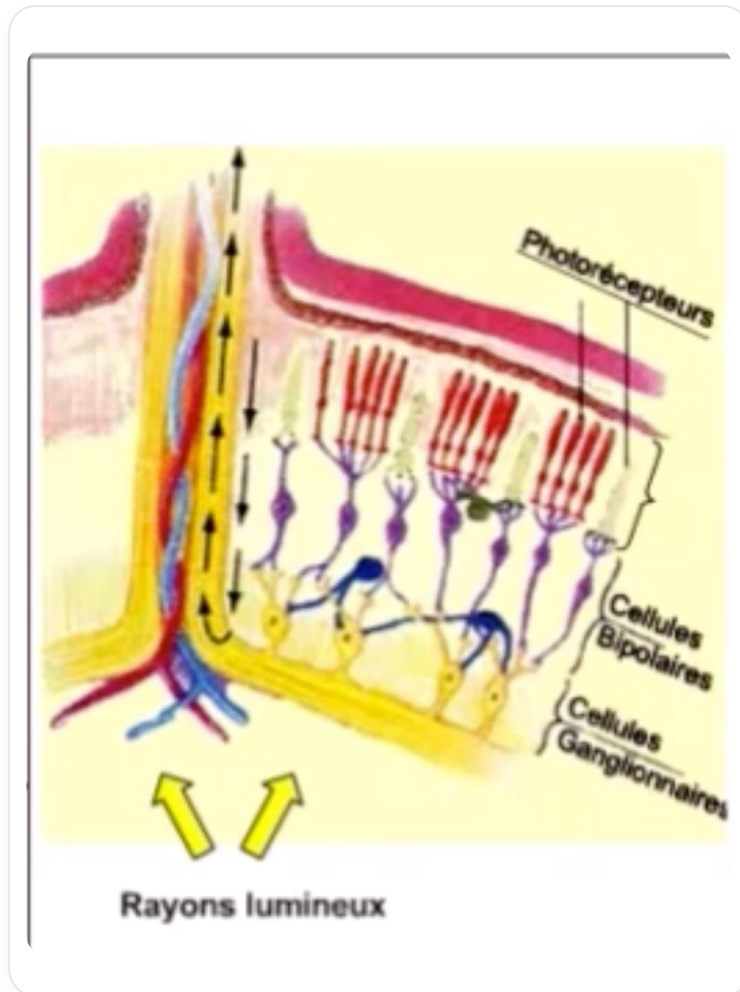


ABB. — Lichtweg bis zum Sehnerv

Bei genauerer Betrachtung beobachten wir auch **Horizontalzellen**, die Informationen aufnehmen und an die bipolaren Zellen weiterleiten. Darunter befinden sich die **Amakrinzellen**, die Informationen sammeln, bevor sie diese an die Ganglienzellen weiterleiten. Dieses komplexe System ermöglicht die Verarbeitung einer großen Menge visueller Informationen.

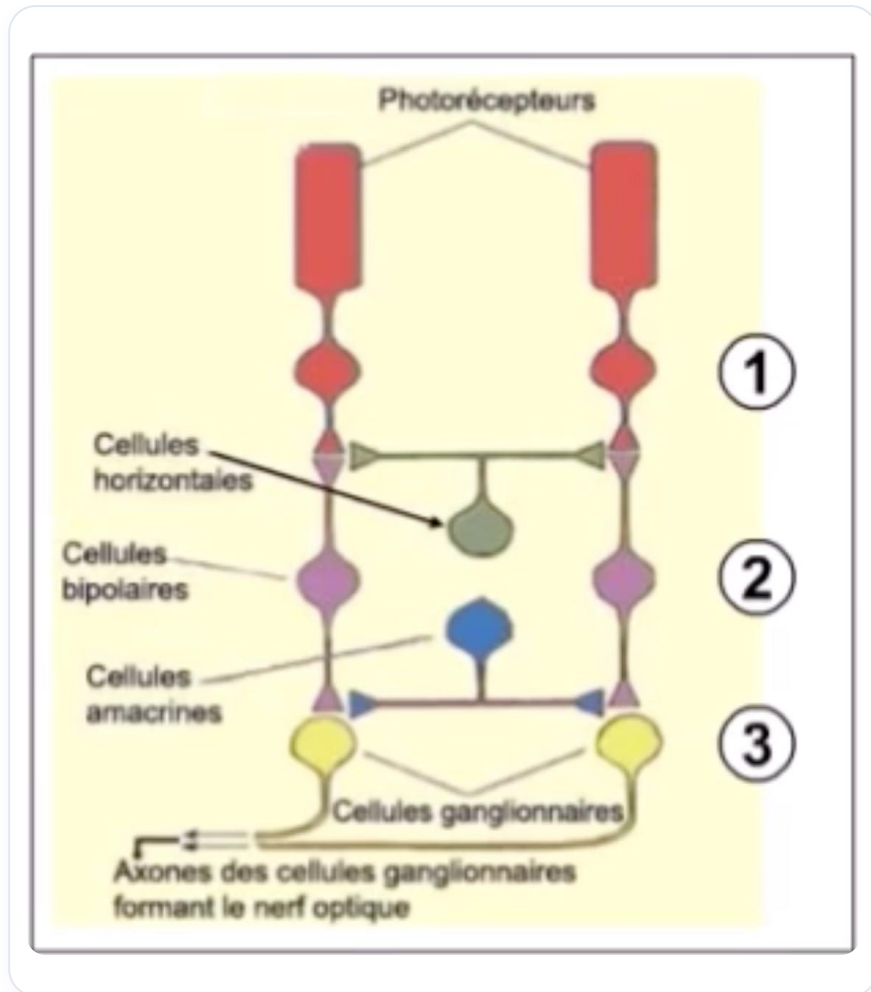


ABB. — Rolle der Horizontal- und Amakrinzellen

Nehmen wir das Beispiel eines zapfenförmigen Photorezeptors. Dieser besteht aus einem **Außensegment**, einem **Innensegment**, einem **Zellkern** und einer **synaptischen Endigung**. Im Außensegment befinden sich **Plasmamembranen** und eine Stapelung kleiner Scheiben, die ein Protein namens **Opsin** enthalten. Bei den Stäbchen wird dieses Opsin **Rhodopsin** genannt, während es bei den Zapfen **Iodopsin** heißt.

Auf der Ebene der Stäbchen ist ein kleines Molekül namens **Retinal** an das Rhodopsin gebunden. Wenn Licht auf diese Scheiben trifft, ändert das Retinal seine Form und wandelt das Rhodopsin in **Metarhodopsin** um. Diese Transformation löst eine Reihe chemischer Kaskaden auf der Zellmembran aus, die den Eintritt von Natrium verhindern und eine ionische Veränderung bewirken.

Diese Veränderung der Membranpermeabilität führt zu einem **Membranpotential**, das einen **Nervenimpuls** erzeugt. So aktiviert das Licht, indem es die Schichten durchquert, ein Pigment, das Beta-Carotin, das in Vitamin A vorhanden ist und für die Aktivierung von Rhodopsin und Iodopsin unerlässlich ist.

Die Stäbchen, die hauptsächlich in der peripheren Netzhaut lokalisiert sind, ermöglichen eine wenig detaillierte, aber sehr lichtempfindliche Sicht ohne Farbwahrnehmung. Im Gegensatz dazu bieten die Zapfen eine detaillierte und farbige zentrale Sicht, mit spezifischen Typen für

Blau, Rot und Grün, die verschiedenen Wellenlängen entsprechen.

Die Stäbchen bestehen aus drei Teilen: dem Außensegment, dem Innensegment und der synaptischen Endigung. Das Außensegment enthält kleine Opsin-Scheiben, die im Falle der Stäbchen Rhodopsin sind.

Wenn Licht auf diese Scheiben trifft, wandelt sich Rhodopsin in Metarhodopsin um, was eine chemische Kaskade auslöst, die die Polarität der Membran verändert und sie für Natrium undurchlässig macht. Diese Veränderung erzeugt einen elektrischen Strom, der für die Übertragung visueller Informationen unerlässlich ist.

Die **Transduktion** der Lichtenergie findet in den Photorezeptoren durch die Absorption von Licht durch das Opsin statt, das seine Form je nach empfangenem Licht ändert. Dieser Prozess ist entscheidend für das Sehen, und Vitamin A spielt eine grundlegende Rolle bei der Synthese von Retinal. Ein Mangel an Vitamin A kann zu einem Verlust des Sehvermögens führen, insbesondere in der Nacht.

28. DER CORPUS GENICULATUM LATERALE

DAUER : 17:52

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Studie der Rolle des Corpus geniculatum laterale bei der Verarbeitung visueller Informationen über seine parvozellulären und magnozellulären Schichten (Farb- und Bewegungsverarbeitung). Analyse der synaptischen Übertragung über den Sehnerv zu den kortikalen Arealen und der Interaktion mit dem Pulvinar. Die Präsentation veranschaulicht die multisensorische Integration und ihre Verbindungen zum Papez-Kreislauf, wobei gezeigt wird, wie die visuelle Wahrnehmung durch mnestiche Schemata moduliert wird.

DER CORPUS GENICULATUM LATERALE: INTEGRATION UND VERARBEITUNG VISUELLER INFORMATIONEN

Der **Corpus Geniculatum Laterale** (CGL) spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung visueller Informationen. Er empfängt Nervenimpulse von der Netzhaut und sortiert diese Informationen, bevor er sie an die visuellen Areale weiterleitet.

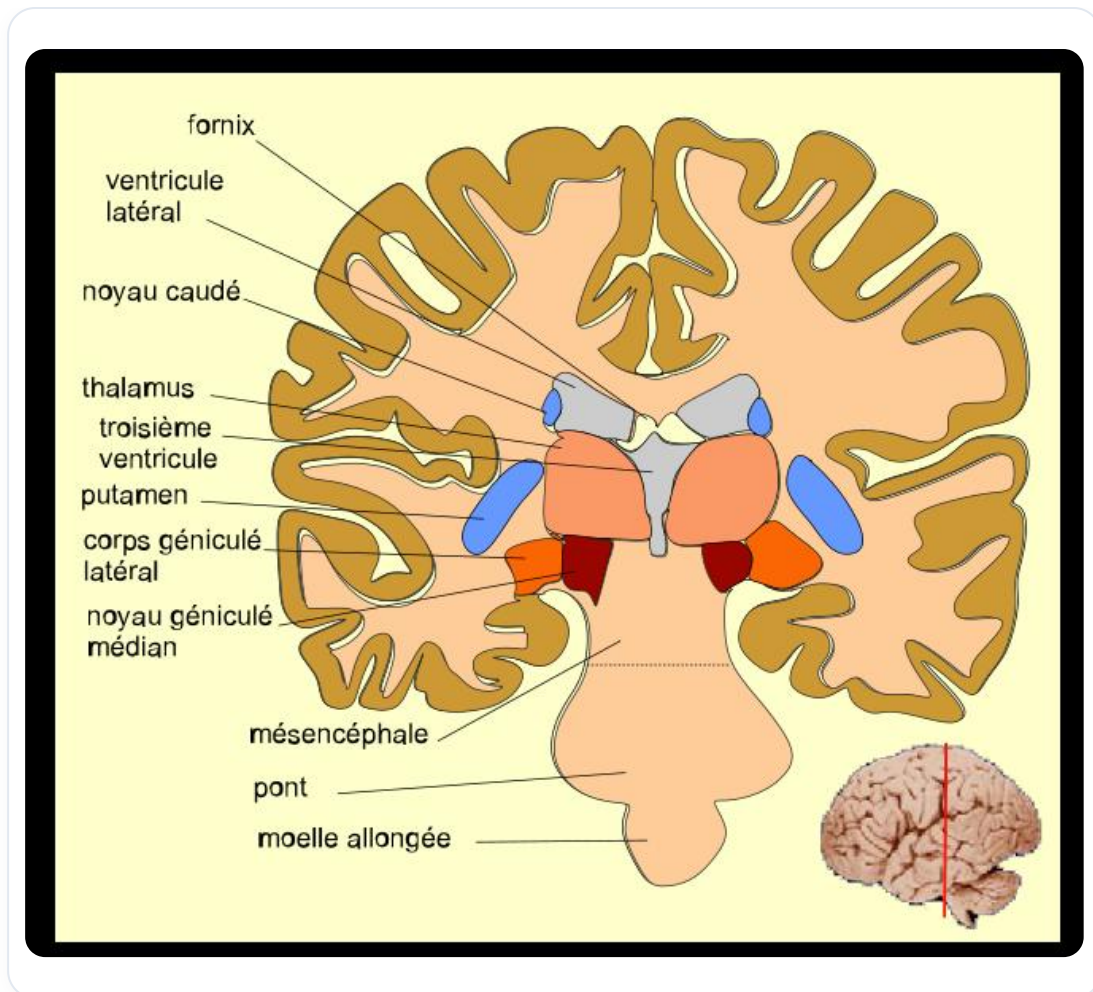


ABB. — Corpus Geniculatum Laterale (CGL)

STRUKTUR UND FUNKTION

Der Corpus Geniculatum Laterale besteht aus mehreren Schichten, von denen jede auf die Verarbeitung spezifischer Informationen spezialisiert ist. Man unterscheidet hauptsächlich drei Zelltypen:

- **Parvozelluläre Zellen:** Sie verarbeiten Informationen bezüglich **Farbe** und **Form**.
- **Magnozellanre Zellen:** Sie sind verantwortlich für die Erkennung von **Bewegung** und **Orientierung**.
- **Koniocelluläre Zellen:** Sie konzentrieren sich auf **räumliche Frequenzen**.

Jede Schicht des Corpus Geniculatum Laterale trägt zur Bildung eines Bildes bei, indem sie diese verschiedenen Informationen integriert.

INFORMATIONSÜBERTRAGUNG

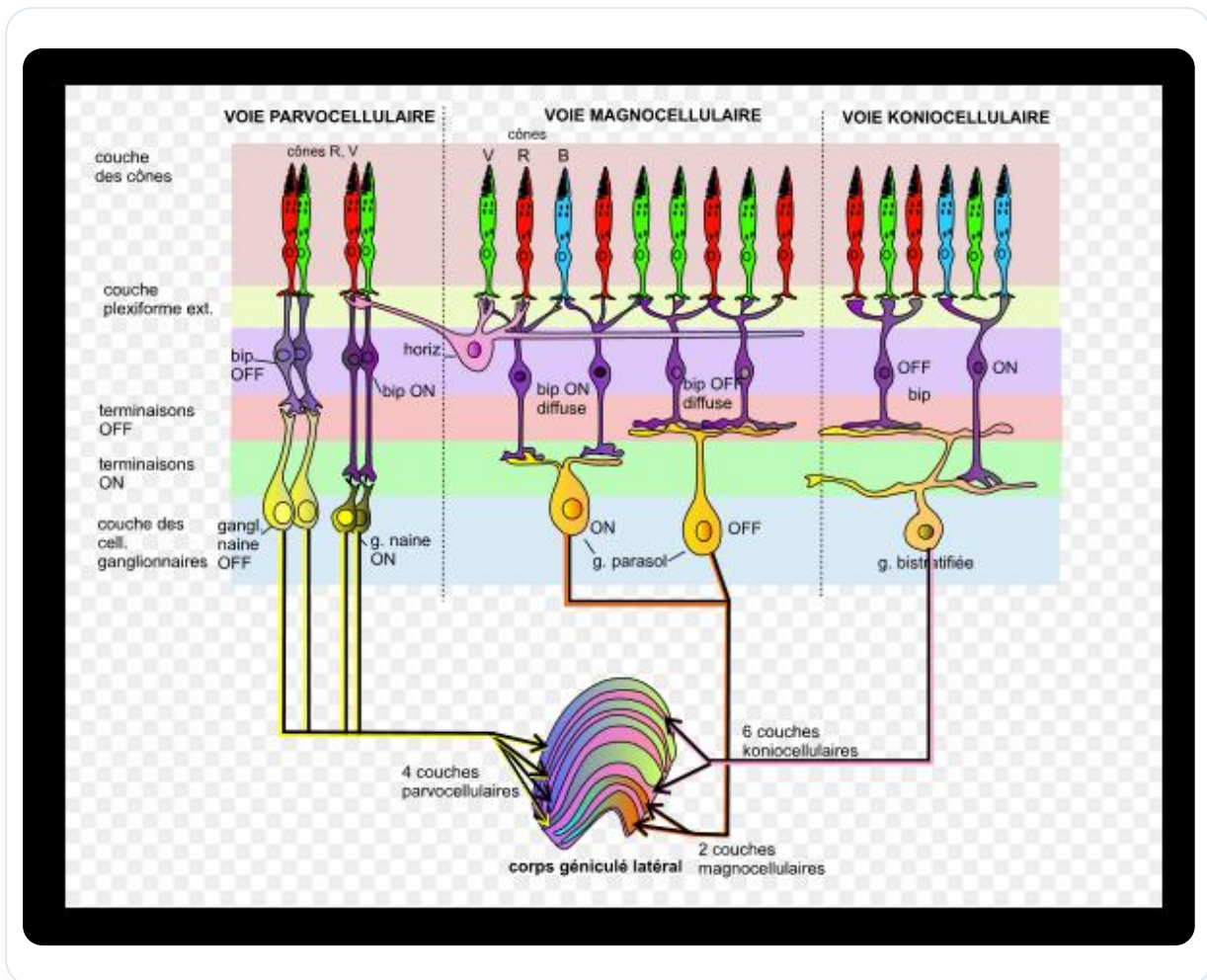


ABB. — Parvozelluläre und Magnozellanen Zellen

Die visuellen Informationen werden über den Sehnerv übertragen und erreichen den Corpus Geniculatum Laterale, wo sie sortiert werden, bevor sie zum Thalamus und den visuellen Arealen gesendet werden. Etwa **80%** der vom Corpus Geniculatum Laterale verarbeiteten Informationen werden direkt an die visuellen Areale gesendet, während **20%** über den Pulvinar, eine andere thalamische Struktur, für eine subtilere Verarbeitung geleitet werden.

Der Pulvinar empfängt auch Informationen von anderen Kernen, wie dem **Colliculus superior** und den **Olivenkernen**, die für die Integration auditiver und visueller Informationen unerlässlich sind.

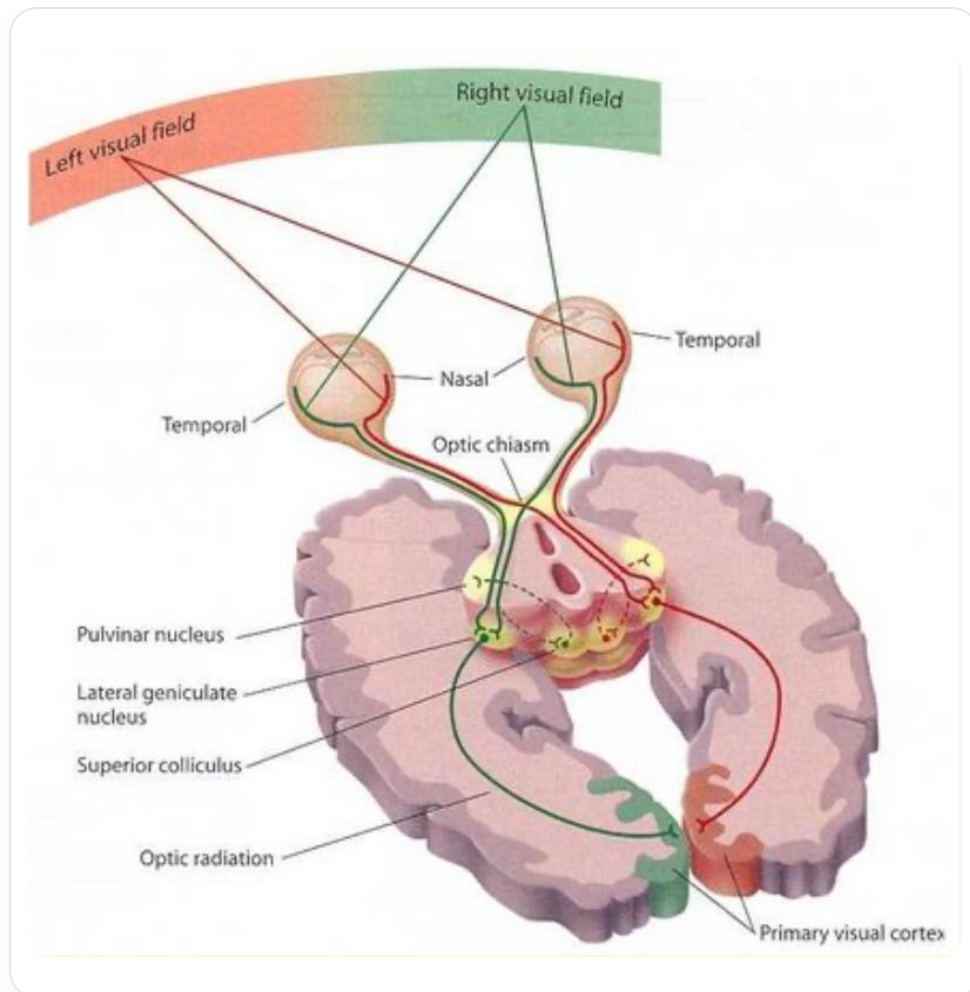


ABB. — Verteilung der Information vom CGL zum Pulvinar

MULTISENSORISCHE INTEGRATION

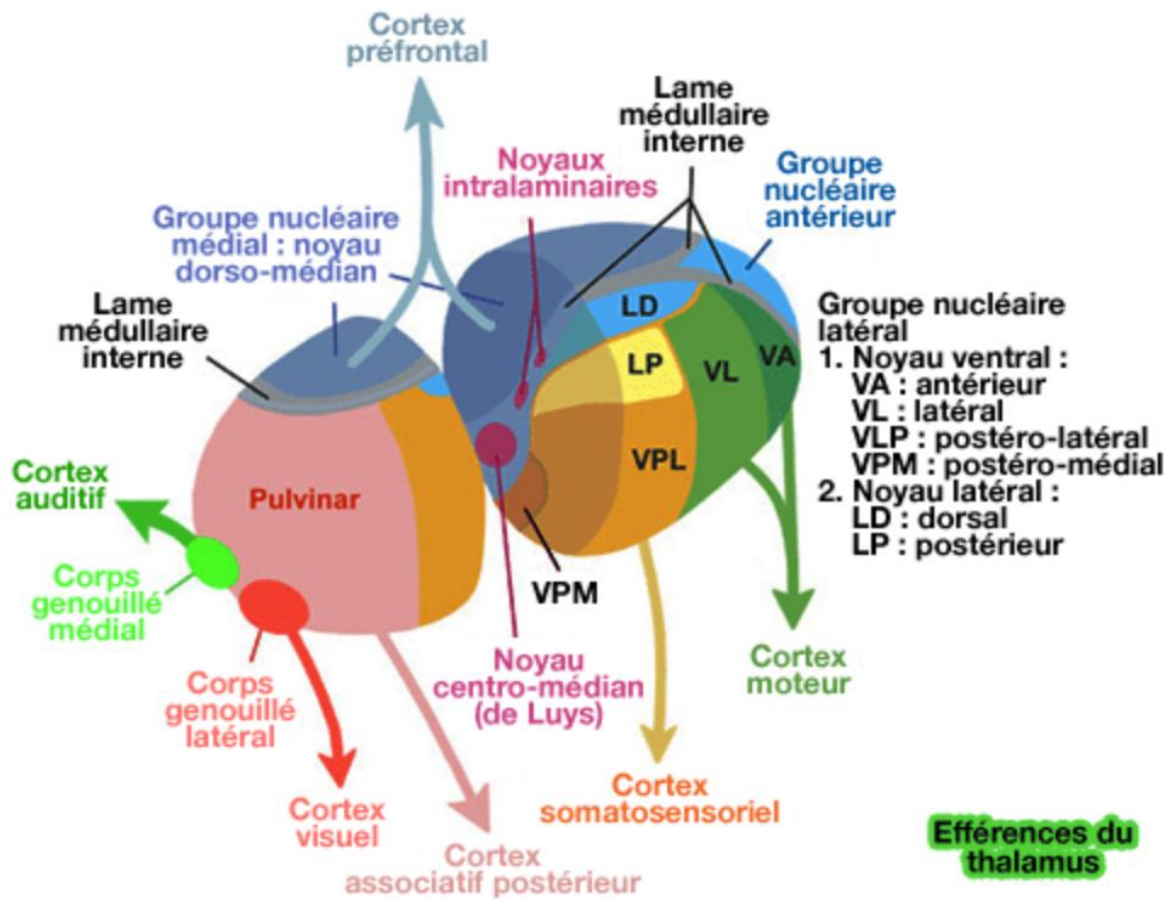


ABB. — Verbindungen des Pulvinars

Champ visuel gauche

Champ visuel droit

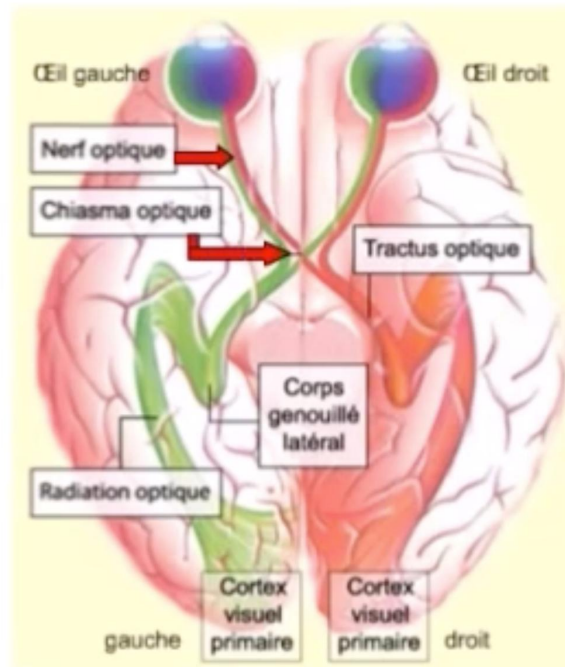


ABB. — Verlauf der visuellen Information zum CGL

Der Corpus Geniculatum Laterale verarbeitet nicht nur visuelle Informationen, sondern ist auch mit auditiven und vestibulären Systemen verbunden. Dies ermöglicht eine Integration von Informationen aus den Augen, Ohren und der Körperposition im Raum. Dieser Prozess ist wesentlich für Aktionen wie **Sakkaden** (schnelle Augenbewegungen) und die Kopfausrichtung.

PAPEZ-SCHALTKREIS UND GEDÄCHTNIS

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

ABB. — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

Der Corpus Geniculatum Laterale ist auch mit dem **Papez-Schaltkreis** verbunden, der eine Rolle im Gedächtnis spielt. Dieser Schaltkreis umfasst Strukturen wie die **Corpora mamillaria**, den **vorderen Thalamus** und den **Gyrus cinguli**. Er ist an der Speicherung und dem Abruf von Erinnerungen beteiligt und verknüpft visuelle Informationen mit vergangenen Erfahrungen.

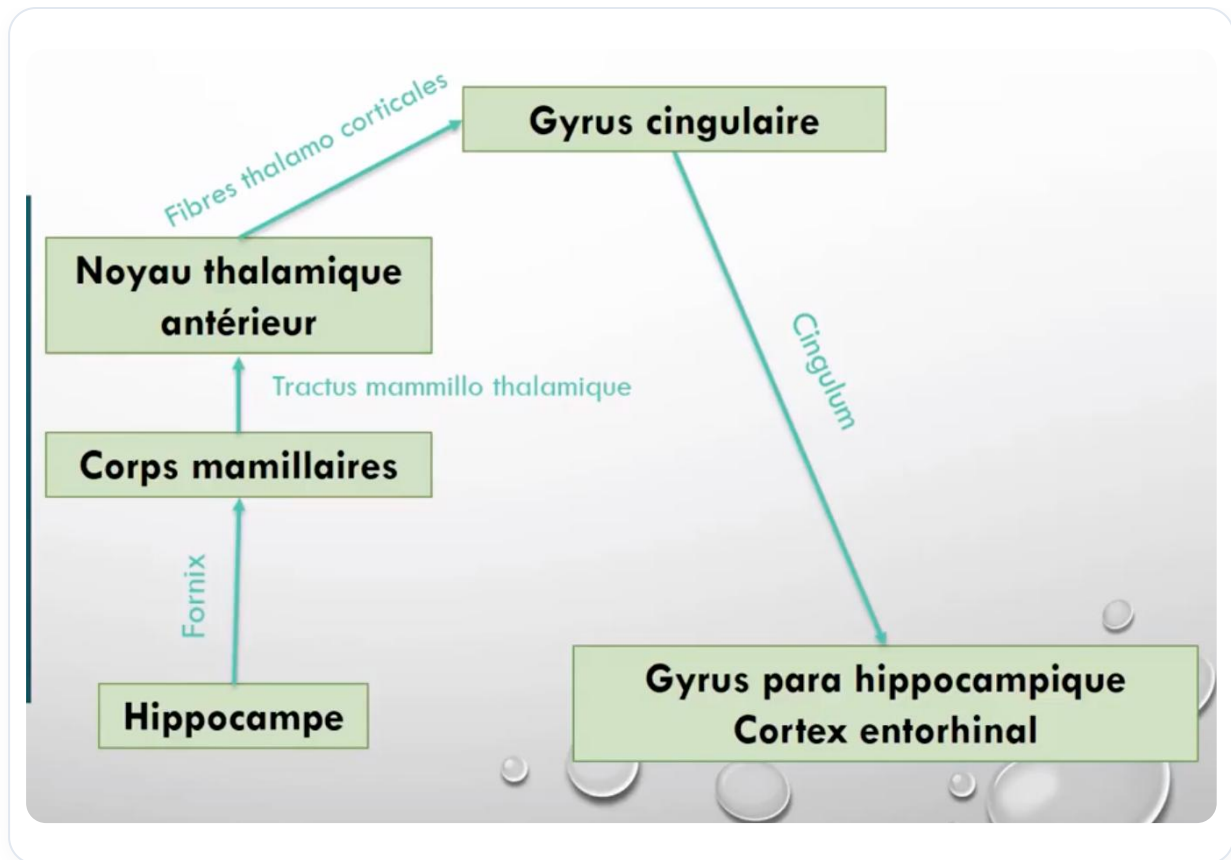


ABB. — Rolle bei Sakkaden und Kopfhaltung

INTERPRETATION DER REALITÄT

Es ist wichtig zu beachten, dass wir, wenn wir Informationen wahrnehmen, nur einen Bruchteil der Realität erhalten. Tatsächlich sind nur **20%** der wahrgenommenen Informationen real, der Rest ist eine Neuinterpretation, die auf unseren Erfahrungen, Emotionen und früheren Erlebnissen basiert. Dieser Interpretationsprozess wird durch die Verbindungen zwischen den visuellen Arealen und dem Corpus Geniculatum Laterale beeinflusst.

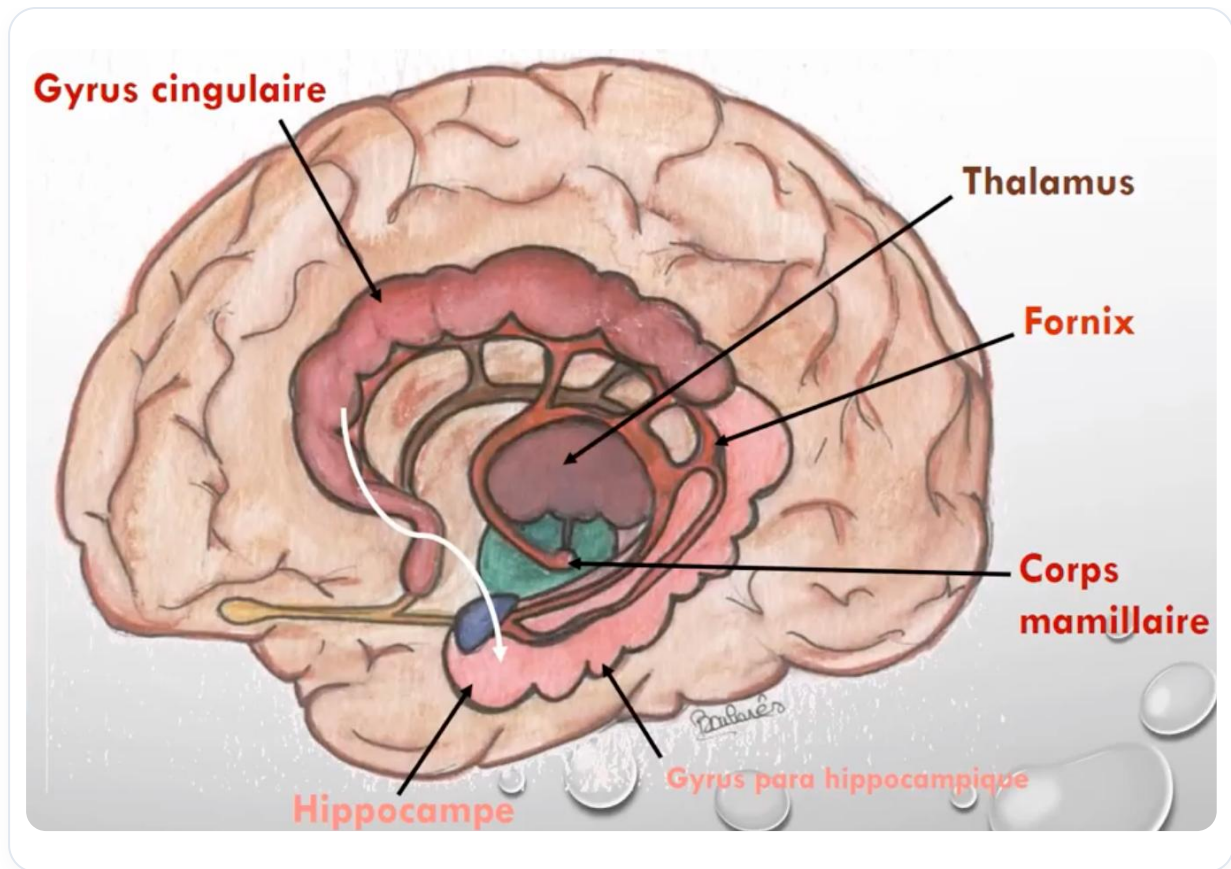


ABB. — Papez-Schleife und Gedächtnis

FAZIT

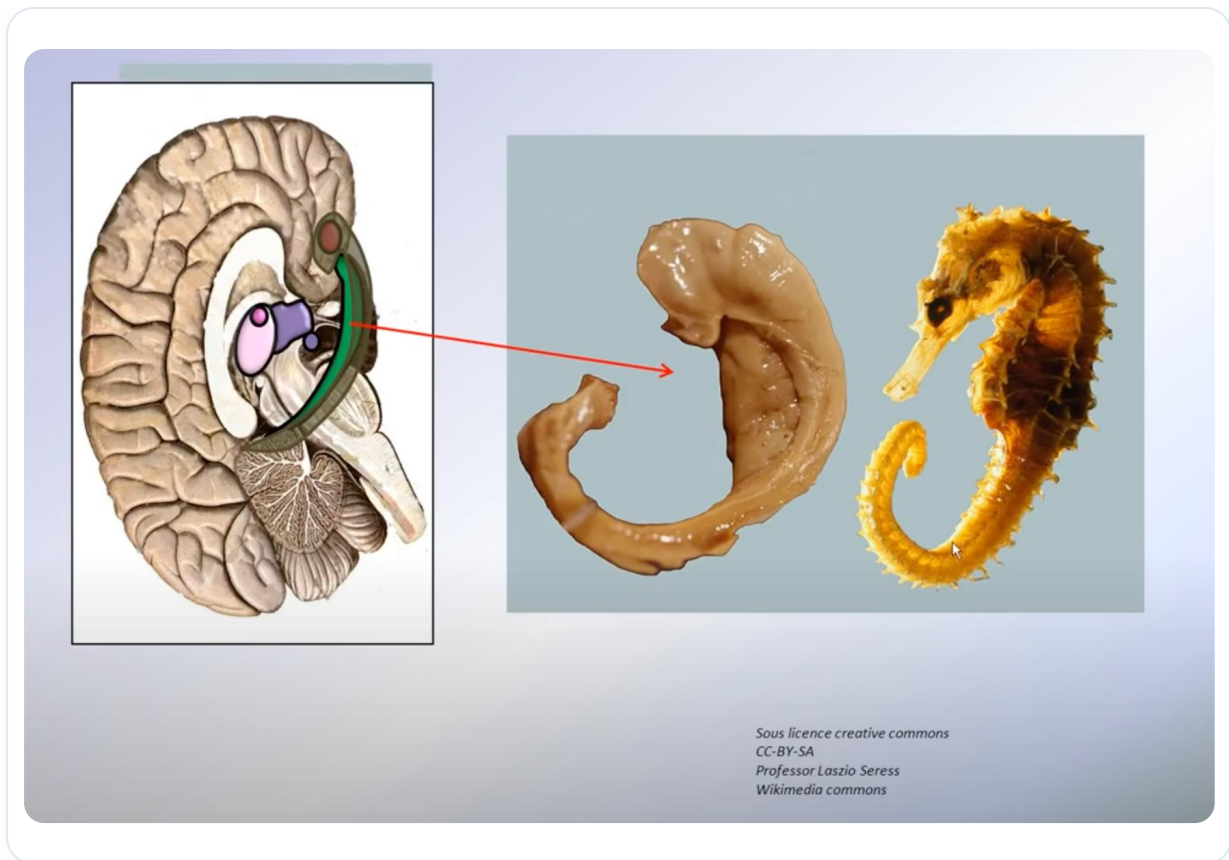


ABB. — Papez-Schleife: Gedächtniskonsolidierung

Der Corpus Geniculatum Laterale ist eine Schlüsselstruktur bei der Verarbeitung visueller Informationen, die Daten aus verschiedenen sensorischen Quellen integriert und eine entscheidende Rolle für unsere Wahrnehmung der Realität spielt. Seine Fähigkeit, Informationen zu sortieren und zu interpretieren, ist für unsere Interaktion mit der uns umgebenden Welt unerlässlich.

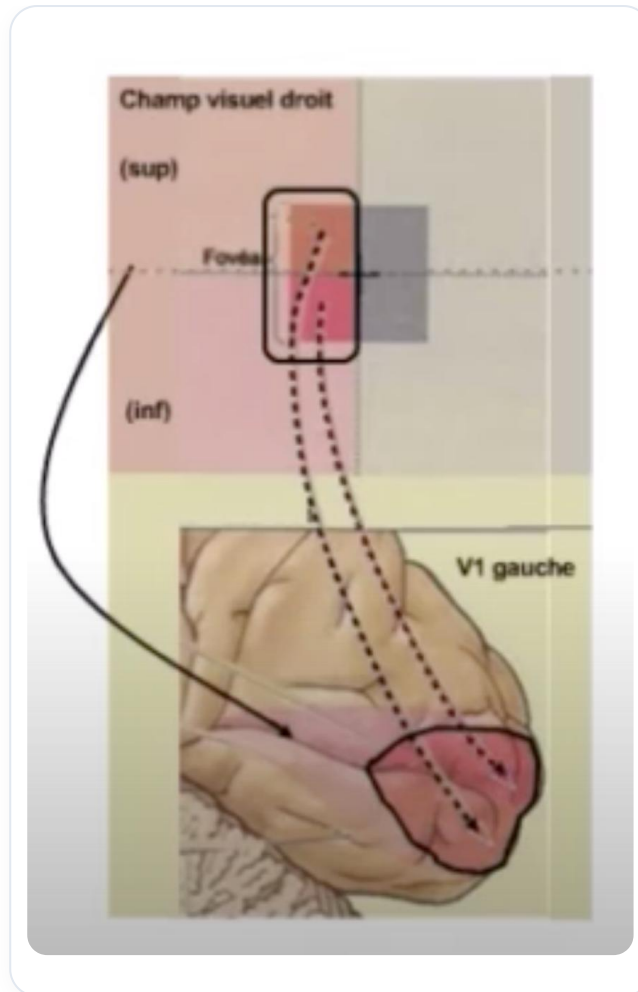


ABB. — Neuinterpretation der wahrgenommenen Information

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

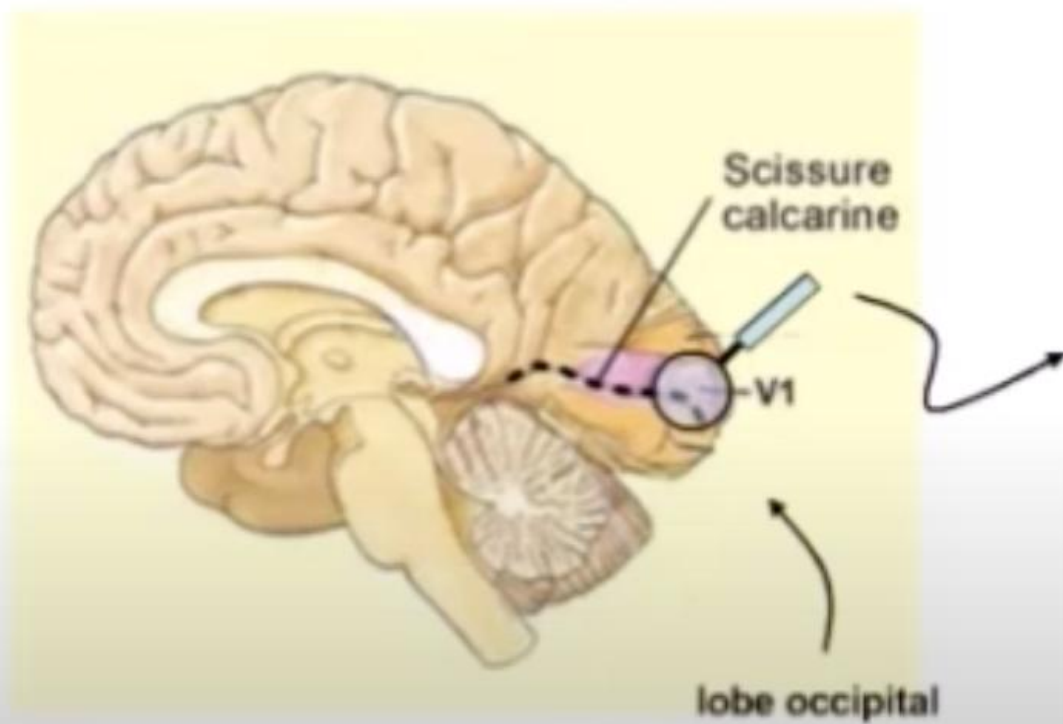


ABB. — Interpretation der Realität

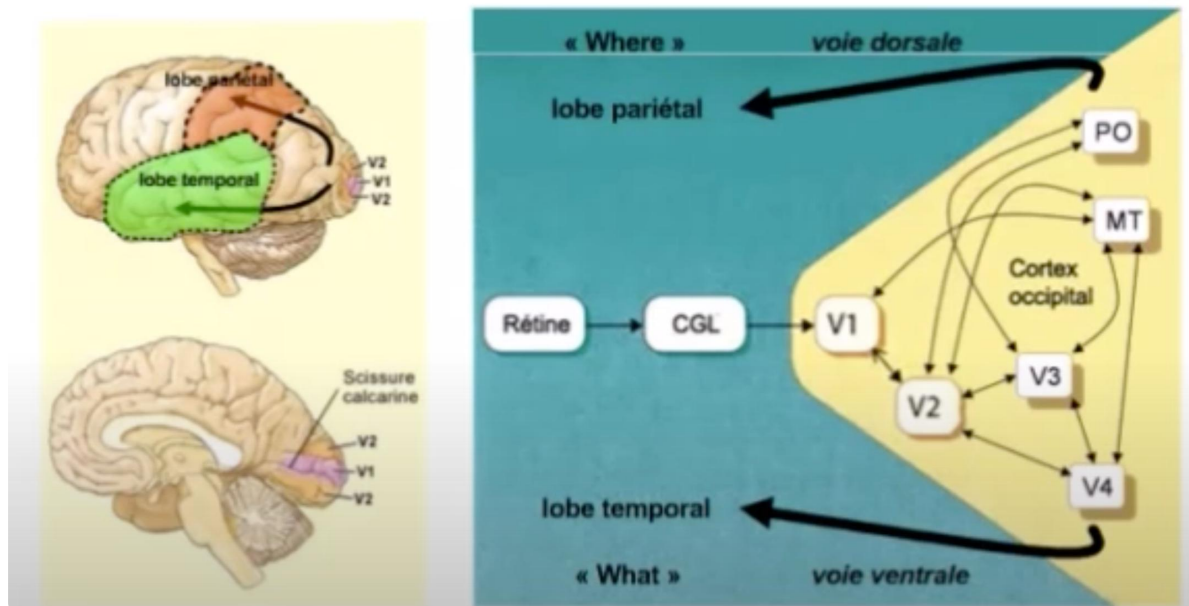


ABB. — Bedeutung des CGL in der Wahrnehmung

29. DISSOZIATION VON ERINNERUNGEN

DAUER : 03:20

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der Dissoziation emotionaler Erinnerungen anhand des Berichts über eine prägende persönliche Erfahrung. Der Sprecher erzählt, wie stressige Ereignisse im Zusammenhang mit seiner Familie seine Wahrnehmungen und seine körperliche Gesundheit beeinflusst haben. Dank der Intervention einer Psychiaterin lernte er, Emotionen von Ereignissen zu dissoziieren, was ihm eine neue Perspektive auf seine Ängste und körperlichen Schmerzen eröffnete. Die Lehre konzentriert sich auf die Bedeutung der Befreiung von emotionalen Assoziationen und der Neuausrichtung der eigenen Erfahrungen, um das Selbstverständnis zu fördern und als Therapeut zu handeln. Dieser Neubewertungsprozess ist grundlegend, um eine echte emotionale Befreiung zu erreichen.

DISSOZIATION VON ERINNERUNGEN

Während einer prägenden Erfahrung befand ich mich in einer Situation, in der mein Vater ins Krankenhaus kam. Alle waren besorgt, aber als Jüngster fühlte ich mich fast distanziert. Meine Eltern hatten sich gerade getrennt, und obwohl ich erfuhr, dass meine Mutter ein Flugzeug nehmen würde, um zu kommen, empfand ich eine gewisse **Zufriedenheit** angesichts ihrer Streitigkeiten.

Am nächsten Tag war meine Schwester in einem kritischen Zustand, und mit meinem Bruder fuhren wir den Berg hinunter. Auf dem Weg zum Krankenhaus konnte ich nicht aus dem Fenster schauen, aber ich sah ein Flugzeug vorbeifliegen. Zu diesem Zeitpunkt musste ich selbst fliegen, und eine Woche zuvor hatte ich die emotionalen Auswirkungen, die dies auf mich hatte, nicht erkannt. Ich begann, Bauchschmerzen und einen **Druck** in der Brust zu verspüren, und ich suchte nach Ausreden, um das Fliegen zu vermeiden.

Eine prominente Psychiaterin war anwesend und bat mich, innezuhalten und darüber nachzudenken, was ich erlebte. Sie fragte mich nach meinen Ängsten, insbesondere der Flugangst, die ich einem Vorfall zuschrieb, den ich gesehen hatte. Sie ließ mich dann verstehen, dass diese Ereignisse nicht meine Verantwortung waren. Sie dissoziierte die Ereignisse: die **Appendizitis** meiner Schwester, die Probleme zwischen meinen Eltern und den Flugzeugabsturz. Ich erkannte, dass ich nichts mit diesen Situationen zu tun hatte.

Diese Erkenntnis war befreiend. Ich hatte all diese Emotionen in verschiedenen Teilen meines Körpers angesammelt: in meinem Bauch, meinen Hoden, meinen Knien, meinen Füßen, meinen Ellbogen und meinen Schultern. Sobald all dies in Perspektive gerückt war, verspürte ich Erleichterung.

Diese Erfahrung veranschaulicht, wie unsere **Ängste** mit verdrängten Wünschen verbunden sein können. Zum Beispiel kann die Frage an ein Elternteil, ob man Fahrrad fahren darf, von der Angst vor einem Sturz geprägt sein. Jede Angst verbirgt einen Wunsch. Es ist ein komplexer Erinnerungsprozess.

Es ist wesentlich, sich von diesen emotionalen Assoziationen zu befreien und unsere Erfahrungen neu zu bewerten. Dies ist ein Weg zur **Befreiung** und Selbstfindung.

30. DIE AUGENPAARE

DAUER : 04:11

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt das faszinierende Thema der Augenpaare als Fenster nicht nur zur Seele, sondern auch zu verschiedenen Aspekten unseres Seins, von der Physiologie bis zur Spiritualität. Es untersucht, wie kulturelle Elemente, wie die Aktivierung der Hypophyse in Asien, mit Vorstellungen von Hellsehen und Wahrnehmung verbunden sind. Die Verbindungen zwischen den Augen, den inneren Organen und sogar Gelenken wie Ellbogen und Knien werden entschlüsselt und bieten eine neue Perspektive auf den menschlichen Körper und seine Erinnerungen. Die Konzepte der Harmonie zwischen physischem und energetischem Körper sind wesentlich, um unseren persönlichen Weg zu verstehen und wie unsere Geschichten unsere Wahrnehmung der Welt beeinflussen.

AUGENPAARE: EINE ERKUNDUNG DER SINNE UND DES BEWUSSTSEINS

Polyvoyance wird als die Fähigkeit beschrieben, **Gott** in allem zu sehen, während die **Hypophyse** der Sitz der **Hellsichtigkeit** ist. In Asien wird oft das **dritte Auge** erwähnt, das den Zugang zur verborgenen Seite der Dinge ermöglicht. Diese Drüse spielt eine entscheidende Rolle, indem sie die für den Körper notwendigen Hormone absondert.

In Kulturen wie denen **Indiens** und **Nepals** werden Farben auf die Stirn aufgetragen, um diese Drüse durch die **Frequenz** und die **Schwingung** der Farben zu aktivieren. Die Augen werden oft als die **Fenster der Seele** betrachtet, aber sie repräsentieren auch die Augen des **Mentalkörpers**.

Das hebräische Wort **ayin** bedeutet Auge, aber auch **Lichtquelle**. Dies unterstreicht, dass das Auge nicht nur ein Lichtempfänger, sondern auch ein **Lichtsender** ist. Ein tiefer Blick kann sowohl bei Frauen als auch bei Männern **hormonelle Stimulationen** hervorrufen.

Es ist auch interessant festzustellen, dass der **Kieferwinkel** als ein Auge betrachtet wird, das es ermöglicht, das Unbewusste zu erforschen. Lichtsensoren befinden sich ebenfalls in dieser Region. Die **Parotiden** sind mit diesem Bereich verbunden, ebenso wie die **Hoden**.

Der **Ringfinger** wird oft als Finger des Bundes und der inneren Vision bezeichnet. Das **Herz** wird als Sitz der **liebenden Vision** wahrgenommen und fungiert als Fenster des Geistes. Die Augen stehen in direkter Verbindung mit den **Eierstöcken** und den **Knien** und bilden ein komplexes Netzwerk.

Der **D3-Wirbel** ist entscheidend, da er die Sehkraft beeinträchtigen kann. Die **Eierstöcke** und die **Hoden** werden als die Augen des **Energiekörpers** betrachtet. Der Eisprungzyklus ist mit der Entwicklung der Frau verbunden, während die **Menopause** den Beginn der körperlichen und spirituellen Reife markiert.

Die **Ellenbogen** werden als Augen wahrgenommen, die es ermöglichen, im Energiekörper zurückzublicken. Der Ausdruck "die Ellenbogen einsetzen" evoziert die Idee, im Leben voranzukommen. Die **Knie** repräsentieren die Augen des physischen Körpers, wo die Frau ihre Beziehungen zu anderen und zu sich selbst bewertet.

Die **Ferse** ist ebenfalls ein Auge, das es ermöglicht, im physischen Körper zurückzublicken. Sie wird als das erste Auge der Erde betrachtet, ein Symbol des Friedens. Jedes Auge ist mit den anderen verbunden und trägt **Erinnerungen** in den physischen, ätherischen, astralen und mentalen Körpern.

Diese Erinnerungen übermitteln Informationen, die unsere Interpretation und unsere Erfahrungen beeinflussen. Daher ist es unerlässlich, darüber nachzudenken, was wir mit diesen Bildern tun, die uns gehören und die von unserer **genetischen, karmischen**, aktuellen Geschichte und der **reinen Erinnerung** beeinflusst werden.

31. PRAXIS: EPIPHYSE UND HYPOPHYSE

DAUER : 10:39

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine eingehende Untersuchung der grundlegenden Rollen von Zirbeldrüse und Hypophyse bei der Hormonregulation und dem Gedächtnis. Es werden Techniken zur energetischen Wiederherstellung des Gleichgewichts vorgestellt, die von der embryonalen Reise inspiriert sind, insbesondere im Hinblick auf die Motilität der Hypophyse. Die Studierenden lernen, die Wechselwirkungen zwischen göttlichem und aktuellem Licht zu identifizieren und klinische Beobachtungen wie Atmung und Augenbewegungen zu nutzen, um das Gleichgewicht zwischen diesen beiden entscheidenden Drüsen wiederherzustellen. Der Kurs beleuchtet auch die Bedeutung der Zirbeldrüse bei der Regulierung vitaler Funktionen wie Atmung, Verdauung und Schlaf.

PRAXIS: EPIPHYSE UND HYPOPHYSE

Epiphyse und Hypophyse spielen eine entscheidende Rolle bei der **Hormonregulation** und dem **Gedächtnis**. Die Epiphyse, oft als Zirbeldrüse bezeichnet, ist die **Verbindung zwischen den Neuronen** und dem Hormonsystem. Sie wird durch Licht beeinflusst und enthält Mikroorganismen, die **Serotonin** in **Melatonin** umwandeln. Wenn die Lichtintensität abnimmt, beginnt die Melatoninproduktion.

Um Hypophyse und Epiphyse wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wird eine energetische Ausgleichstechnik angewendet, die die **embryologische Reise** neu beleuchtet. Dies beinhaltet die Untersuchung der Motilität der Hypophyse durch die Eintrittspforten am **Nasion** und **Bregma**.

Zum Zeitpunkt der Schädelbasisbildung entsteht ein Raum, die sogenannte **Rathke-Tasche**. Diese Epithelfalte des Epiblasten bildet die Hypophyse, die sowohl absteigende als auch aufsteigende Informationen empfängt. Die Hypophyse teilt sich in einen vorderen und hinteren Teil, und ihre Entwicklung ist mit der Bildung des **Prosencephalons** verbunden, das sich in **Telencephalon** und **Diencephalon** unterteilt.

Die Epiphyse bewegt sich von vorne nach hinten, beeinflusst durch das göttliche Licht und die Hypophyse. Diese Interaktion zwischen dem göttlichen Licht und dem aktuellen Licht ist essenziell für die Funktion der Hypophyse.

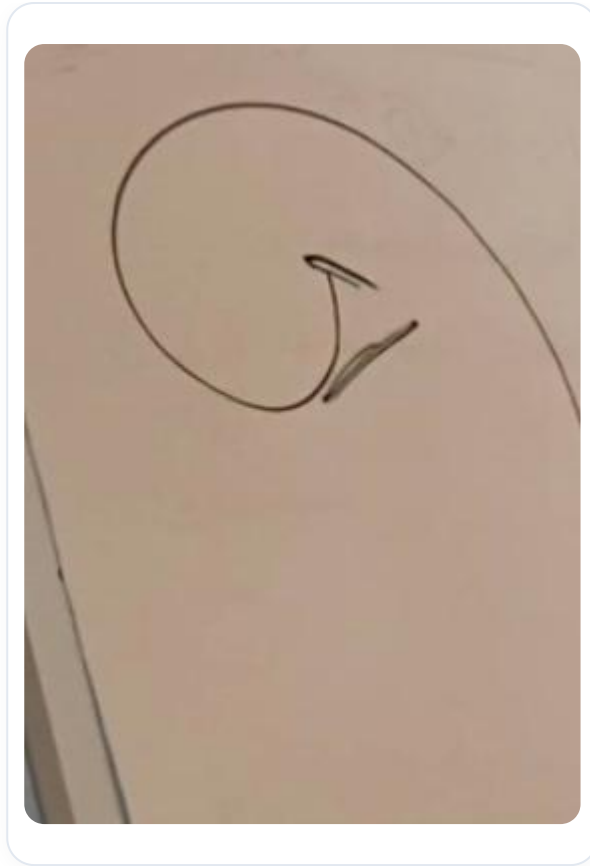


ABB. — *Bildung der Schädelbasis*

Die Hypophyse entwickelt sich aus dem Oberflächenepithel, und die Beugungsbewegung führt zu einer Aspiration zum Zentrum hin, wodurch die vordere Hypophyse entsteht. Parallel dazu führt eine Aspirationsbewegung im Gehirn zur Bildung des Infundibulums, das den hinteren Teil der Hypophyse bildet.



ABB. — *Entwicklung der Hypophyse*

In der Praxis ist es möglich, interne Techniken anzuwenden, um an der energetischen Achse zwischen Hypophyse und Epiphyse zu arbeiten. Dies beinhaltet die Beobachtung der Atmung und der Augenbewegungen des Patienten, da diese Elemente Aufschluss über den energetischen Zustand geben.



ABB. — Entwicklung des Infundibulums

Das **Nervensystem**, einschließlich Hypothalamus und Thalamus, spielt eine Schlüsselrolle in dieser Dynamik. Durch die Reaktivierung der embryonalen Motilität ist es möglich, die vordere und hintere Hypophyse wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Augenbewegungen können eine Rückkehr zum Hara anzeigen und so die Stabilität fördern.

Die Epiphyse ist essenziell für die Regulation von **Atmung, Verdauung** und **Schlaf**. Sie produziert Melatonin, ein Hormon, das die Gehirnwellen beeinflusst und so das Einschlafen, den Tiefschlaf und die Träume erleichtert. Obwohl die Hypophyse fast alle Drüsen kontrolliert, wird die Epiphyse als die Meisterdrüse angesehen, die eine zentrale Rolle im hormonellen und energetischen Gleichgewicht des Körpers spielt.

31. BIS. EINFLÜSSE AUF DAS AUGE

DAUER : 24:37

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Untersuchung der Rolle des Auges im neurosensorischen Programm und seiner Verbindung zur Tenon-Kapsel / hypothalamisch-ventrikulären System. Integration von posturaler Chemie, somatischem Feedback und energetischen Mechanismen, um zu zeigen, wie visuelle Afferenzen den Tonus und den psychischen Zustand beeinflussen. Analyse des Faziengewebes als Vektor des Körpergedächtnisses und des Einflusses des Herz-Kreislauf-Systems auf das elektromagnetische Gleichgewicht.

EINFLÜSSE AUF DAS AUGE

Die **Tenon-Kapsel** ist mit dem gesamten Körper verbunden und spielt eine entscheidende Rolle in einem **neurosensorischen Programm**. Das bedeutet, dass sie Informationen über den **posturalen Tonus** integriert, der als **posturale Chemie** betrachtet werden kann. Im **Hypothalamus** werden viele Informationen integriert, insbesondere über den **Thalamus** und den **Pulvinar** sowie andere Kerne um das ventrikuläre System.

Diese Informationen können in zwei Typen eingeteilt werden: **trophotrop** und **ergotrop**, die den sympathischen bzw. parasympathischen Systemen entsprechen. So beeinflussen die vom Hypothalamus empfangenen Informationen, einschließlich derer aus den Augen, die posturale Chemie auf zellulärer Ebene, indem sie Elemente wie **Oxidoreduktion** und **Nukleotide** wie **Guanosin** und **Adenosin** integrieren. Der Hypothalamus nutzt diese Daten, um die Körpertönizität anzupassen.

Zum Beispiel kann eine Spiralbewegung nach rechts oder links ausgerichtet sein und mit verschiedenen Energiezuständen wie **Depression** oder **Überdruck** verbunden sein. Die posturale Chemie integriert sich somit in einen Tonus, der durch verschiedene Afferenzen auf das kortikale und visuelle System beeinflusst wird, wodurch ein kontinuierliches, positives oder negatives **Feedback** entsteht.

Das Auge spielt als Informationsquelle eine wesentliche Rolle bei der Integration dieser Botschaften. Es trägt zu einem spezifischen posturalen Ergebnis bei, das die bestmögliche Anpassung zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt. Es gibt keine schlechte Position, nur die

funktional adäquateste Antwort. Es ist entscheidend, dem zu vertrauen, was man sieht, während man sich bewusst ist, dass das Programm manchmal in einer Schleife laufen kann. Dies erfordert einen Blick, eine befreiende Geste, die zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ausgeführt wird.

Meditation kann auch helfen, aus diesen Gewohnheitsmustern auszubrechen, die manchmal unsere Wahrnehmung der Realität verzerren können. Mikroverletzungen im Gesichts- und Augenbereich können die Ausrichtung des Auges verändern und mentale Programme beeinflussen. Das Auge hat eine entscheidende Bedeutung bei der Integration neurosensorischer Informationen, in Verbindung mit dem **tektospinalen System** und den im **Fasziengewebe** gespeicherten Erinnerungen.

Die **Faszie** ist ein intelligentes Gewebe, das Informationen und Erinnerungen speichern kann. Indem man zuhört, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit, mit einer adäquaten mentalen Kartierung, ist es möglich, eine Befreiung zu erreichen. Diese mentale Repräsentation ist beeinflussbar und kann sogar die visuelle Botschaft unterstützen.

Die Verbindung zwischen Auge und Meningen ist fundamental. Das Auge fungiert als Leuchtturm und integriert alle Informationen auf dieser Ebene. Es ist wesentlich zu verstehen, dass das Auge nicht täuschen kann, da es rein ist. Licht, als Photon, ist eine Energiequelle, die unsere Wahrnehmung beeinflusst. Die Beziehung zwischen Frequenz und Wellenlänge ist entscheidend: Eine höhere Frequenz entspricht einer kürzeren Wellenlänge, was zu einer Energieerhöhung führt.

Lichtinformationen, die von der Netzhaut erfasst werden, können eine flüssige Mobilisierung hervorrufen. Die **Zapfen** und **Stäbchen** der Netzhaut sind nicht nur Informationssensoren, sondern auch Energiesensoren. Körperliche Ermüdung kann oft mit sympathischen Läsionen zusammenhängen, die zu einer **Mydriasis** und einer Erregung der Stäbchen führen, was das sympathische System erschöpfen kann.

Faktoren wie Energiestress können unseren Zustand verschlechtern. Die richtige Lichtinformation ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Die Aura, als Lichtfeld, wird durch unsere Position im Leben beeinflusst. Innerer Frieden und Weisheit müssen kultiviert werden, um eine positive Energie auszustrahlen.

Das Auge durchläuft ein Energie- und Interpretationsprogramm, das Informationen in Form von Vorprogrammen integriert. Dieser Prozess führt uns zu einer elektrischen und elektromagnetischen Ebene, wo das Herz eine zentrale Rolle spielt. Das Herz sendet ein starkes elektromagnetisches Feld aus, und das Auge, als beweglicher Drehpunkt, wird ebenfalls von verschiedenen Strömen beeinflusst.

Es gibt signifikante vaskuläre Unterschiede zwischen dem linken und rechten Auge, die ihre Funktion beeinflussen. Zum Beispiel ist das rechte Auge mit hepatischen venösen Stauungen verbunden, während das linke Auge mit arteriellem Überdruck assoziiert ist. Diese anatomischen Unterschiede können spezifische Interferenzen auf dem visuellen Kortex verursachen.

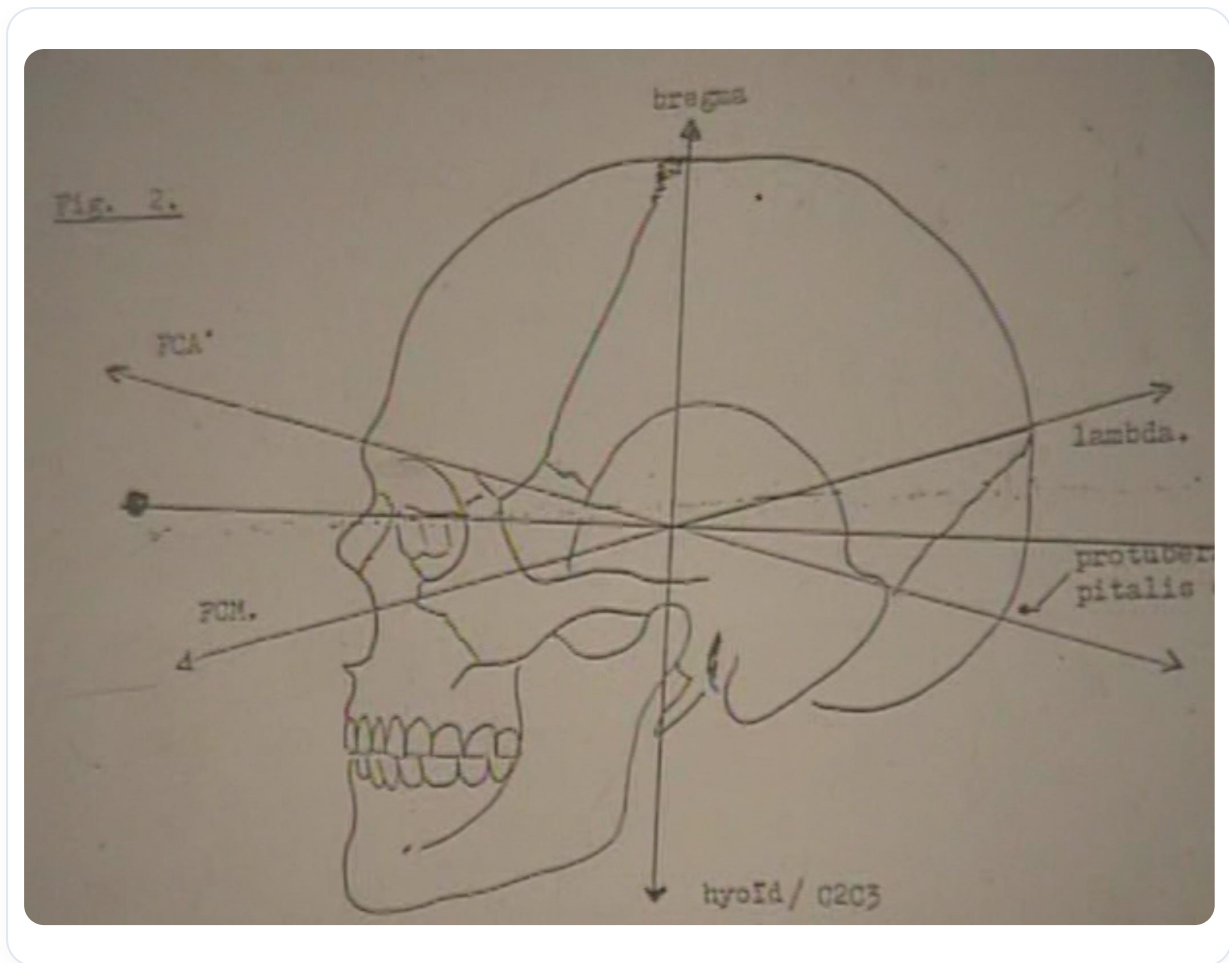


ABB. — Überquerung der Linie

Schließlich zeigen Informationsachsen, wie die Felsenbeinachse, wie okuläre Destabilisierungen das Gleichgewicht beeinflussen können. In Knochen oder elektrischen Schemata integrierte Erinnerungen können ebenfalls unsere Wahrnehmung und unser Gleichgewicht beeinflussen.

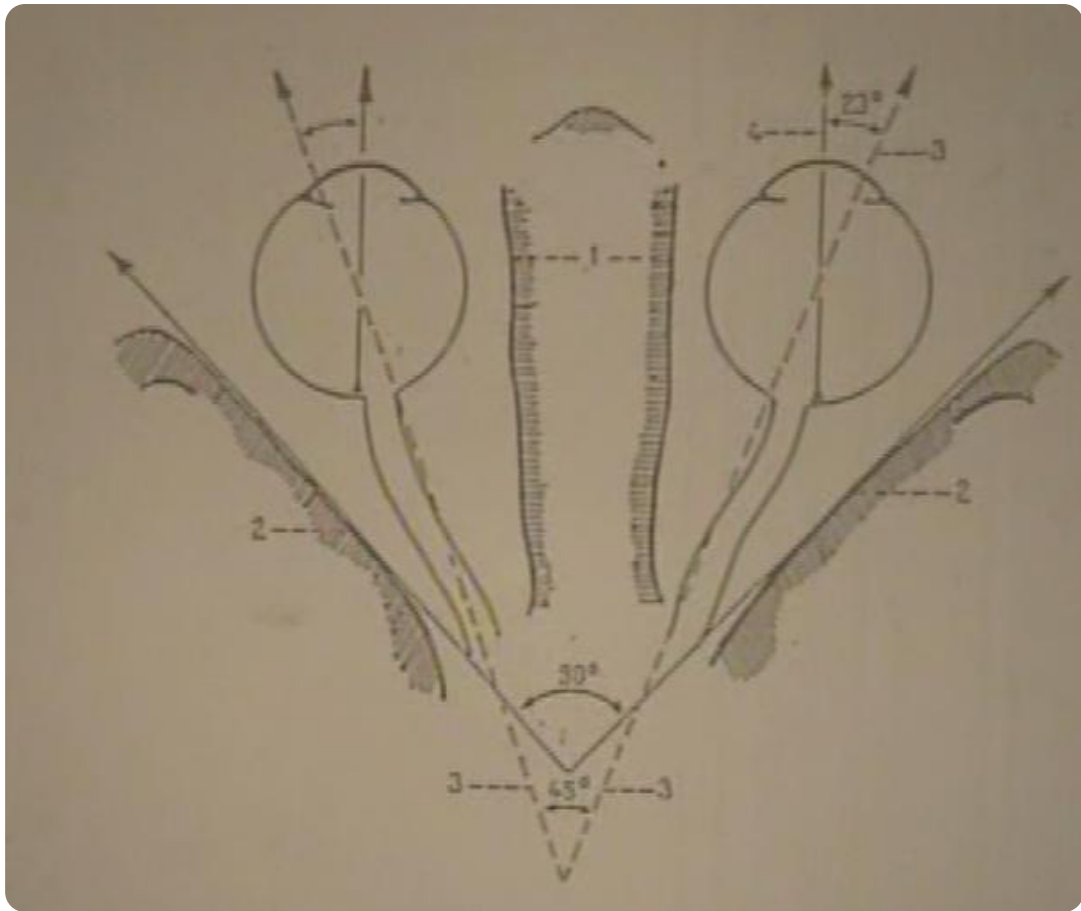


ABB. — Achsen und Winkel der visuellen Integration

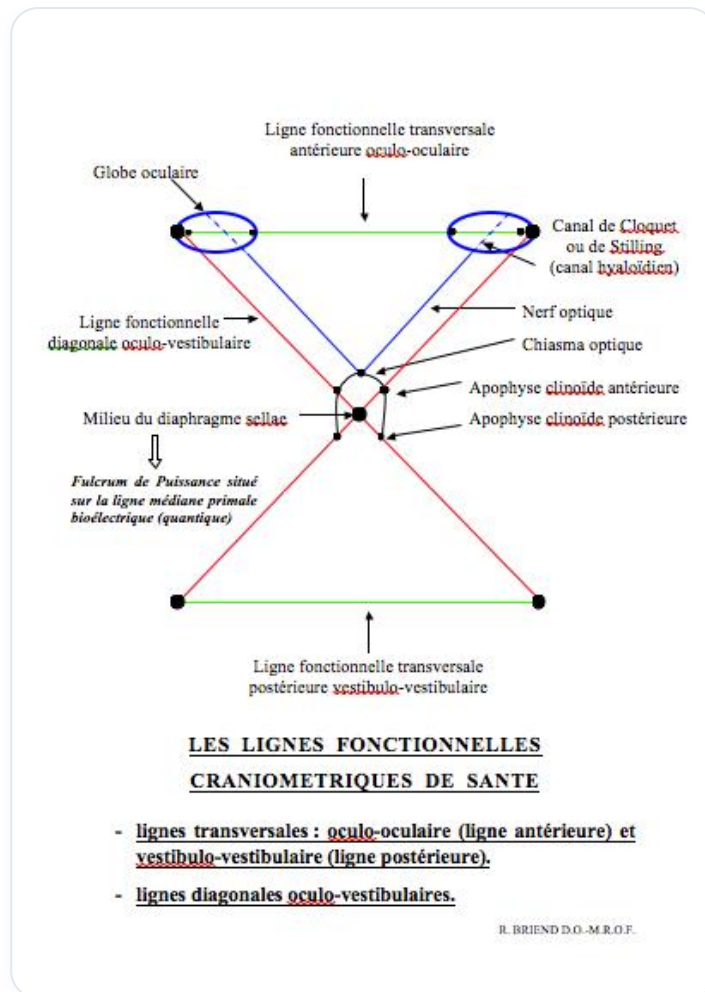


ABB. — Augenbewegungen

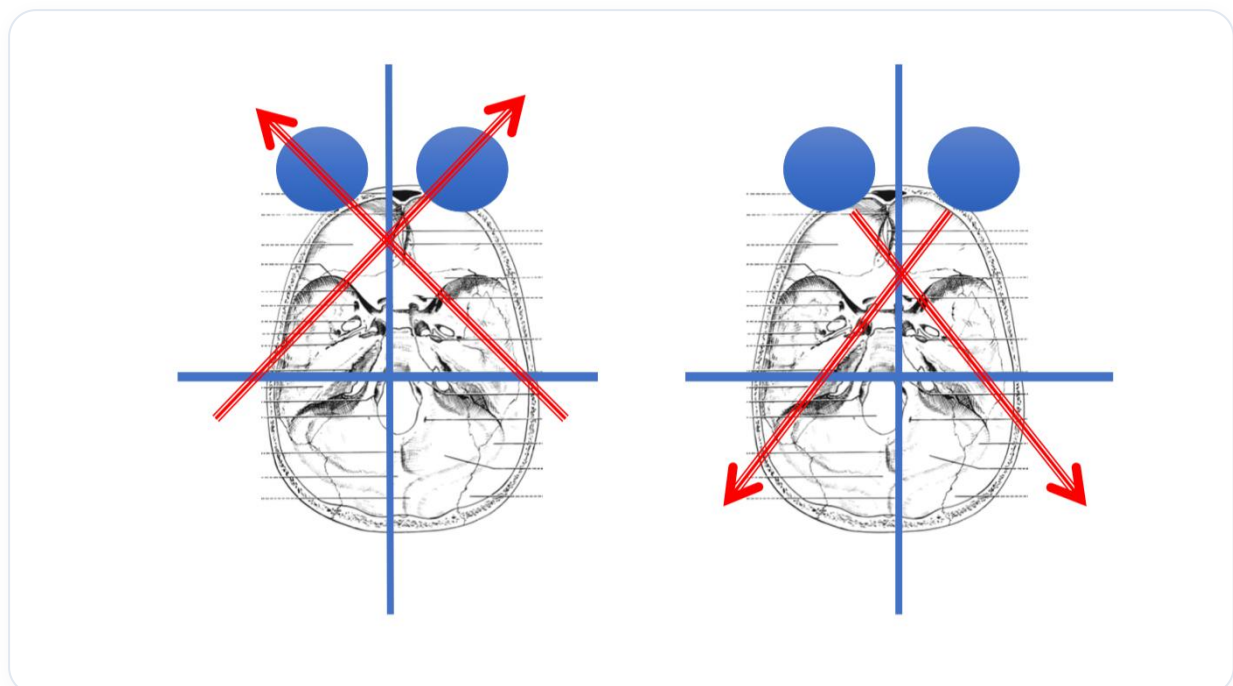


ABB. — 23 Grad visuelle Freiheit

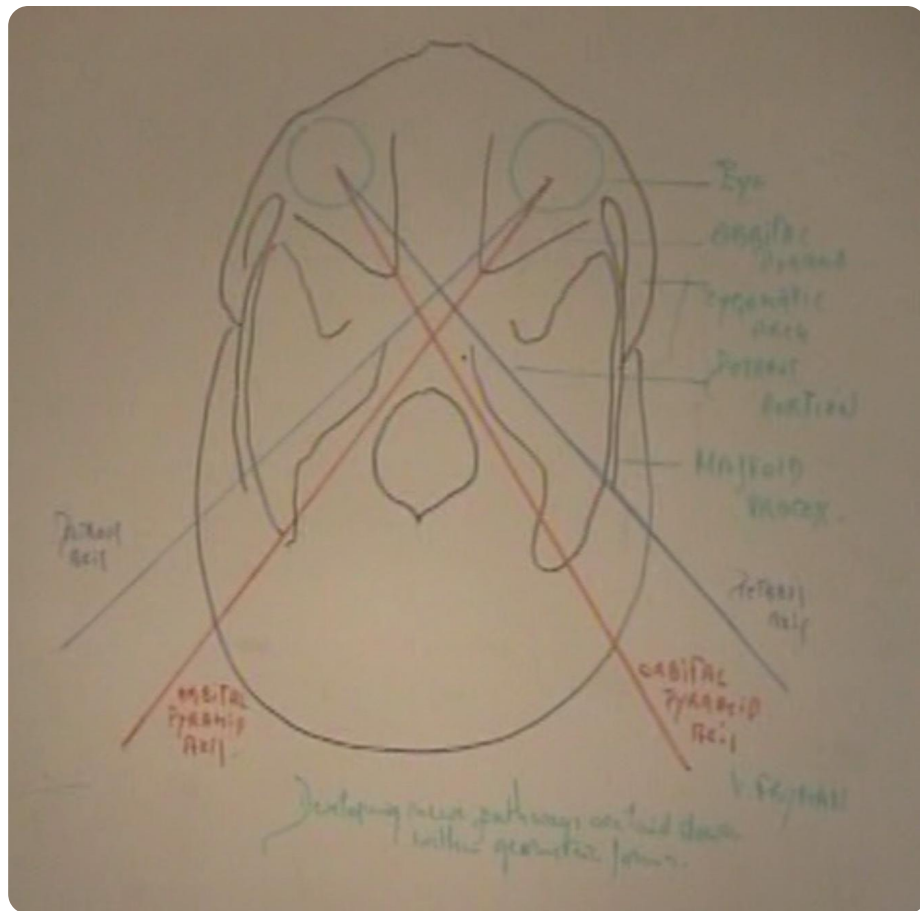


ABB. — Orbitale und pyramidale Achsen

Orbital Pyramid axes in right lateral strain...

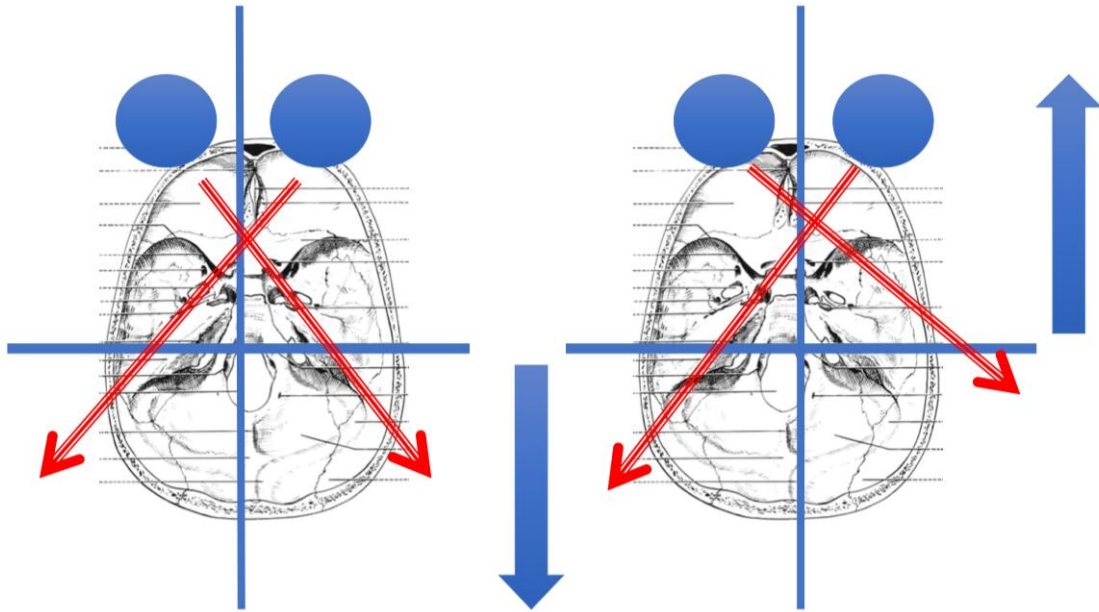


ABB. — Erinnerungen im Knochen